



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 19

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta vinculada a la imagen nº 1:

Señale, de entre las estructuras cerebrales numeradas en la imagen, correspondiente a una resonancia magnética cerebral sagital potenciada en T1, cuál corresponde al cíngulo anterior:

1. 4.
2. 2.
3. 1.
4. 3.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El cíngulo bordea al cuerpo calloso. Su porción anterior se ha relacionado con los procesos cerebrales de valoración de riesgo y toma de decisiones.

2. Pregunta vinculada a la imagen nº 2:

Mujer de 32 años, primigesta de 39+5 semanas, que se encuentra en periodo expulsivo del parto con analgesia epidural. Una hora tras alcanzar la dilatación completa se objetiva el RCTG que se muestra en la imagen. El feto se encuentra en III plano de Hodge, en occípito ilíaca izquierda transversa (OIIT), ¿cuál sería la actitud correcta?:

1. Puesto que se trata de una primigesta con epidural podemos dejar evolucionar el expulsivo hasta 3 horas más.
2. Realización de cesárea urgente.
3. Extracción fetal urgente con ventosa (vacuum).
4. Extracción fetal urgente con fórceps.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante la sospecha de pérdida de bienestar fetal durante el expulsivo (DIP II en RCTG) la indicación es la realización de una extracción fetal urgente. La gestante se encuentra en dilatación completa y no existe ninguna contraindicación de parto por vía vaginal. Dado que el feto aún no está rotado (no se encuentra en occípito-pública) el único instrumento que se podría aplicar es el fórceps (único instrumental rotador), y dado que el feto se encuentra en un III plano, hace posible la realización del mismo (respuesta 4 correcta).

3. Pregunta vinculada a la imagen nº 3:

Una paciente de 50 años de edad ingresa en el hospital por un episodio de pancreatitis aguda litiasica. Seis meses más tarde la paciente está asintomática y en la ecografía abdominal se aprecia la lesión que aparece en la TC abdominal de la imagen, dependiente del páncreas. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas aconsejaría?:

1. Punción drenaje del pseudoquiste.
2. Resección quirúrgica.
3. Actitud expectante.
4. Antibioterapia de amplio espectro durante 10 días y volver a realizar una ecografía abdominal para plantear la posibilidad del drenaje del pseudoquiste.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Primero de todo, tenemos que situarnos en el contexto de que la paciente sale de una pancreatitis aguda. La imagen muestra una lesión redondeada de contenido homogéneo líquido y gran tamaño (aunque no haya escala se aprecia a simple vista que la lesión es muy grande) que se corresponde a un pseudoquiste pancreático. La formación de pseudoquistes pancreáticos es una de las complicaciones más frecuentes de las pancreatitis que sucede sobretodo de forma tardía. Previamente estaba indicada la punción-aspiración de los pseudoquistes grandes (> 6 cm), aunque no dieran síntomas. Sin embargo, hoy en día lo indicado para pacientes asintomáticos, independientemente del tamaño y del tiempo de evolución, es mantener actitud expectante (CONCEPTO CLAVE).

4. Pregunta vinculada a la imagen nº 4:

Los signos radiológicos de la imagen, ¿de qué le parecen sugerentes?:

1. Obstrucción intestinal.
2. Paresia gástrica.
3. Íleo paralítico.
4. Síndrome de Ogilvie.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta radiografía corresponde a una obstrucción intestinal (OI). Se ve el estómago muy dilatado, asas de intestino delgado dilatadas con patrón en pila de monedas, organizadas y con edema de pared. En el colon derecho se ven abundante heces y en el izquierdo algo de gas pero no colon dilatado. Probablemente se trate de una OI incipiente en la que todavía no se ha eliminado todo el gas del colon. Esta es una de las pocas Rx de abdomen que hay que tener bien grabadas en la mente.

5. Pregunta vinculada a la imagen nº 5:

Acude a urgencias un varón de 27 años, fumador, de complexión atlética, por cuadro de dolor torácico en hombro izquierdo y disnea, de inicio reciente mientras subía una escalera. En la exploración presenta TA 123/67, FC 88, Sat 92%, auscultación cardiaca normal, y auscultación pulmonar con descenso de murmullo en hemitórax izquierdo, sin crepitantes ni sibilancias. Se realiza una radiografía de tórax que se muestra en la imagen. El tratamiento recomendable para este paciente es:

1. Tubo de drenaje, reposo, oxigenoterapia.
2. Reposo, oxigenoterapia, y pleurodesis posterior.
3. Reposo, oxigenoterapia.
4. Tubo de drenaje, reposo, oxigenoterapia, y pleurodesis posterior.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Lo primero es diagnosticar; si te fijas en la zona periférica del torax la trama pulmonar no llega hasta la caja torácica en el apex izquierdo, y hay una línea que separa la trama pulmonar de un área más negra, que es la línea de un neumotórax. El segundo pase es establecer la gravedad; como la cámara apical es menor de 3 cm, es un neumotórax leve. En el manejo del neumotórax espontáneo se deben tener en cuenta dos datos: la gravedad del neumotórax actual y el riesgo de recidiva. La gravedad nos define el tratamiento inmediato, y así optaremos por un manejo conservador (como las opciones 2 o 3) en un paciente estable hemodinámicamente con neumotórax leve, o por drenaje pleural (opciones 1 o 4) si está inestable o con colapso mayor del 30% (cámara apical de >3 cm). Según el riesgo de recidiva optaremos por no tomar ninguna medida adicional o realizar pleurodesis: está indicada la pleurodesis ante segundos neumotórax ipsi- o contralaterales, ante neumotórax bilaterales, y en primeros episodios en pacientes con profesiones de riesgo. Está indicada la cirugía cuando hay una causa tratable del neumotórax (como bullas localizadas). También hay indicación quirúrgica si el neumotórax persiste tras 3 días de drenaje. En este caso, tenemos un neumotórax leve, luego manejo inicial conservador. Y no tiene antecedentes de neumotórax, ni es secundario a una causa tratable, luego no tiene indicación de manejo quirúrgico posterior. Así que optaremos por la tres.

6. Pregunta vinculada a la imagen nº 6:

Mujer de 30 años de edad que presenta un cuadro de dos meses de evolución compuesto de tos con escasa expectoración, disnea especialmente por la noche y febrícula de 37,6°. La radiografía de tórax se muestra en la imagen. La paciente tiene palomas y periquitos. ¿Qué aparecerá en el lavado broncoalveolar?:

1. Aumento de linfocitos T supresores (CD8).
2. Aumento de linfocitos T colaboradores (CD4).
3. Predominio evidente de eosinófilos.
4. Aumento de macrófagos.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Se sospecha una neumonitis por hipersensibilidad subaguda, cuyo dato característico es el exceso de linfocitos CD8 en el lavado broncoalveolar. La radiografía de tórax muestra un patrón reticular de predominio en bases, en un paciente con exposición a polvos orgánicos. La neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca es un grupo de

enfermedades producidas por reacción inmunológica contra polvos orgánicos, generalmente en relación con exposiciones laborales (granjeros, agricultores, ... pero también posible en exposiciones por "hobbies" y en propietarios de pájaros). Cursan con infiltración intersticial por linfocitos y macrófagos. Hay una forma aguda, relacionada con exposiciones intensas al antígeno, que aparece a las pocas horas con una clínica similar a una neumonía bacteriana: fiebre, mialgias, malestar, tos no productiva; cursa con neutrofilia y marcada linfopenia en sangre periférica, y en la placa de tórax es habitual un infiltrado retículo-nodular bibasal. Responde a la retirada del antígeno, y en casos graves se añaden corticoides. Hay una forma subaguda (ésta), en la que la exposición es de meses de evolución, la clínica es de instauración insidiosa, y la afectación radiográfica es en campos inferiores. Hay una forma crónica, tras exposiciones prolongadas de baja intensidad, que cursa con disnea de larga evolución y tos (que puede ser productiva), similar a una bronquitis crónica. Puede cursar con patrón obstructivo espirométrico por su asociación a bronquitis. En la radiografía muestra un patrón retículo-nodular de predominio apical. En las formas subaguda y crónica es característica la presencia de granulomas no necrotizantes en la biopsia, y linfocitosis en el LBA, con predominio de linfocitos CD8 y por tanto cociente CD4/CD8 bajo. Responden a la retirada del estímulo antigénico, y se puede valorar el uso de corticoides, pero si hay lesiones crónicas pueden ser no reversibles.

7. Pregunta vinculada a la imagen nº 7:

Paciente varón de 65 años, con antecedentes personales, según palabras del paciente, de "infección pulmonar y en la pleura en la adolescencia", que acude a la consulta de su médico de atención primaria por clínica de edemas en piernas y fatigabilidad. A la exploración física se detecta hepatomegalia palpable. En relación con la exploración cardiopulmonar destaca la presencia de pulso paradójico y no se palpa el impulso apical. Su médico le realiza un electrocardiograma que muestra bajos voltajes. Además le realiza una radiografía de tórax que se muestra en la imagen. ¿Cuál sería el tratamiento de elección de la patología del paciente?:

1. Diuréticos y broncodilatadores.
2. Control de la frecuencia cardíaca con betabloqueantes o calcioantagonistas y mantener en la medida de lo posible el ritmo sinusal. En caso de refractariedad podría plantearse miomectomía.
3. Trasplante cardíaco.
4. Pericardiectomía.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Una clínica de insuficiencia cardíaca derecha (edema de

miembros inferiores, hepatomegalia) con bajos voltajes en ECG y presencia de pulso paradójico (RECORDEMOS: pulso paradójico es la disminución de la presión sistólica arterial MÁS de 10 mmHg con la inspiración profunda) puede presentarse en un paciente con derrame y taponamiento cardíaco (en caso de ser una situación con deterioro clínico importante y de poco tiempo de evolución) o una pericarditis constrictiva (situación más crónica y menor deterioro clínico). Además, el antecedente de probable tuberculosis pulmonar hace pensar en PERICARDITIS CONSTRICTIVA. Es frecuente que los pacientes se refieran a la tuberculosis como “enfermedad de la pleura”. La etiología conocida más frecuente de pericarditis constrictiva es la tuberculosis. Por otro lado, el pulso paradójico aparece en un 70-90% de pacientes con taponamiento y únicamente en un 33% de pacientes con pericarditis constrictiva. El pulso paradójico es más característico del taponamiento mientras que el signo de Kussmaul (ingurgitación venosa yugular que AUMENTA o no desciende con la inspiración) lo es de la pericarditis constrictiva (aunque en este caso está ausente). Es muy típico de la pericarditis constrictiva que no se palpe el impulso apical, lo que sí sucede en la miocardiopatía hipertrófica. Si se suele apreciar un golpe o “knock” pericárdico. El tratamiento de elección de la pericarditis constrictiva es la pericardiectomía de frénico a frénico (decorticación cardíaca). El ECG presenta bajos voltajes. Los bajos voltajes pueden aparecer en cualquier patología que aumente el espacio entre el corazón y el electrodo explorador: aire en el caso de los pacientes EPOC, líquido en el derrame pericárdico o taponamiento, un pericardio engrosado en la pericarditis constrictiva o infiltración pericárdica en la miocardiopatía restrictiva. La miocardiopatía hipertrófica tiene voltajes aumentados. La presencia de calcificaciones pericárdicas como se muestra en la radiografía lateral de tórax establece prácticamente el diagnóstico de certeza de la pericarditis constrictiva

8. Pregunta vinculada a la imagen nº 8:

Varón de 22 años, asintomático desde el punto de vista cardiológico, que acude al servicio de urgencias por haber presentado un episodio de palpitaciones rápidas, autolimitada, de 10 minutos de duración. El electrocardiograma realizado a su llegada se muestra en la imagen. Usted lo interpreta como:

1. Normal
2. Síndrome de Brugada.
3. Segmento PR corto y onda delta, en precordiales derechas.
4. Repolarización precoz.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el electrocardiograma se objetiva PR corto con onda delta en precordiales derechas (V1-V3) (opción 3 cierta), en un paciente joven que acude por palpitaciones. Se trata de un Síndrome de Wolf-Parkinson-White. El resto de opciones se descartan por no cumplir criterios electrocardiográficos

(aunque esta morfología nos pueda recordar a un Brugada, recordad que en este síndrome encontramos morfología de BRD + elevación del ST descendente en forma de aleta de delfín) o no corresponder con el cuadro clínico del paciente

9. Pregunta vinculada a la imagen nº 9:

Un paciente de 76 años, presentó un infarto de miocardio complicado hace 6 meses. Actualmente permanece estable con disnea de grado III. Ha sido tratado con medidas generales, AAS, IECAS, Betabloqueantes y estatinas, con buena adherencia terapéutica. El trazado ECG se muestra en la imagen. Dicho trazado sugiere la presencia de:

1. Trastorno avanzado de conducción ventricular.
2. Pre excitación.
3. Aneurisma ventricular.
4. Comunicación interauricular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El ECG muestra elevación del segmento ST en V2-V5, así como ondas Q en V3-V6 que informan de la presencia del IAM previo. La persistencia de la elevación de segmento ST tiempo después de un infarto nos debe sugerir el aneurisma del ventrículo izquierdo (que es una de las posibles complicaciones mecánicas postinfarto). Estos aneurismas aparecen con más frecuencia en infartos transmurales poco extensos y suelen ocasionar insuficiencia cardíaca como en el caso de la pregunta (disnea grado III) o fenómenos embólicos periféricos (la sangre se remansa en el aneurisma y se convierte en una potencial fuente de embolias). Debemos sospecharlo en pacientes con historia de IAM previo, donde encontramos ascensos del segmento ST que no se acompañan de nueva clínica sugerente de isquemia.

10. Pregunta vinculada a la imagen nº 10:

Paciente de 50 años con episodios recurrentes de dolor precordial en la última semana, motivo por el que acude al servicio de urgencias de un hospital comarcal que no tiene laboratorio de hemodinámica. El electrocardiograma durante un episodio de dolor se muestra en la imagen. La primera determinación analítica muestra valores de troponina I de 2,35 ng/mL (rango normal del laboratorio 0.00-0.20 ng/mL). ¿Cuál de las siguientes pautas de tratamiento antitrombótico le parece más adecuada?:

1. Aspirina y acenocumarol.
2. Aspirina y heparina.
3. Aspirina, ticagrelor y heparina de bajo peso molecular.
4. Aspirina, heparina y bivalirudina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El ECG muestra descenso del segmento ST en V5-V6, I y aVL de pendiente descendente compatible con lesión subendocárdica. Además, existe taquicardia sinusal a unos 130 lpm. Se trata de un SCASEST de tipo infarto subendocárdico. En tal caso se recomienda, además del correspondiente tratamiento antianginoso, iniciar tratamiento antiagregante y anticoagulante. Se administrará de inicio AAS y anticoagulación (heparina sódica, heparina de bajo peso molecular o fondaparinux); en el momento de la realización de la coronariografía precoz, se administrará prasugrel de elección como segundo antiagregante.

11. Pregunta vinculada a la imagen nº 11:

Hombre de 22 años de edad que ha sufrido un traumatismo y presenta gran dolor a nivel del muslo. Se realiza una radiografía que se adjunta. ¿Cuál sería la conducta terapéutica?:

1. Osteosíntesis con placa y tornillos.
2. Osteosíntesis con clavo intramedular.
3. Osteosíntesis con fijador externo.
4. Osteosíntesis con injerto óseo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La fractura que aparece en la imagen es una fractura transversal cerrada de tercio medio de fémur. De forma general debes recordar que las fracturas de los huesos de los miembros de carga deben intervenir para ser estabilizadas aunque no sean inestables de forma intrínseca. En el caso de fracturas diafisarias de huesos largos se emplea el sistema de enclavado intramedular, muy resistente, y que tolera muy bien la carga. En miembro superior podría practicarse alternativamente una osteosíntesis con placa y tornillos. Recuerda que para las fracturas abiertas de tibia se debe aplicar un fijador externo. La tracción transesquelética podría ser una medida transitoria de estabilización de la fractura, pero que debería de ir seguida de una fijación quirúrgica.

12. Pregunta vinculada a la imagen nº 12:

Paciente de 45 años con antecedentes de hipertensión con las lesiones que se muestran en la imagen. Dichas lesiones afectan, además de lo que se observa en la imagen, a piernas y cuero cabelludo; también presenta pitting ungueal. Ha realizado tratamiento con fototerapia pero no mejora. ¿Qué tratamiento cree que sería el más conveniente?:

1. Corticoides orales.
2. Ciclosporina.
3. Acitretino.
4. Ustekinumab.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente con psoriasis moderada-grave (placas eritematodescamativas en localizaciones típicas) que no responde a fototerapia. Lo más conveniente sería dar un fármaco sistémico; en la pregunta nos ofrecen dos: ciclosporina (contraindicado en caso de hipertensión) y acitretino (un retinoide oral). Los tratamientos biológicos (ej ustekinumab) los deberíamos reservar en caso de fallo de respuesta a tratamientos sistémicos o imposibilidad de indicación. Recuerda que la psoriasis no se debería de tratar con corticoides orales por el fenómeno de taquifilaxia (necesidad de dosis cada vez mayor).

13. Pregunta vinculada a la imagen nº 13:

Mujer de 69 años que acude a urgencias porque refiere: “no veo nada de nada desde hace dos horas por mi ojo izquierdo”. En las últimas semanas ha perdido peso, tiene dolores musculares y se encuentra más cansada. La imagen corresponde a la retinografía del ojo izquierdo. Respecto a la patología que sospecha, señale la respuesta incorrecta:

1. Suele acompañarse de dolor al masticar y mialgias.
2. La proteína C reactiva (PCR) es más específica y sensible que la VSG, pero ambas se solicitan para un diagnóstico precoz.
3. La afectación del ojo contralateral es poco frecuente, por lo hasta que no se obtenga un valor positivo en la biopsia de la arteria no se administran corticoides.
4. Los corticoides no mejoran el pronóstico del ojo afecto una vez que ha debutado la enfermedad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad alta. En la retinografía se aprecia un edema de papila (bordes imprecisos y ligero edema peripapilar). El paciente ha tenido una pérdida masiva de visión (“no veo nada de nada”) y refiere síntomas generales como pérdida de peso, mialgias y astenia, que nos orientan a una posible polimialgia reumática. Esto nos orienta a una neuropatía óptica isquémica de tipo arterítico (por arteritis de la temporal). En la opción 1, nos hablan de una claudicación mandibular y mialgias que son síntomas típicos de una arteritis de la temporal. El diagnóstico se establece por la clínica y por las pruebas complementarias (VSG y PCR), siendo más específica y sensible la PCR. En un 20% de los casos, estas pruebas son normales. Por lo que ante la sospecha de esta enfermedad es necesario empezar de inmediato el tratamiento con corticoides sistémicos a altas dosis, para evitar que se haga bilateral (MUY IMPORTANTE: LA DOSIS ES 1 GRAMO/DÍA, 3 DÍAS SEGUIDOS). El pronóstico visual de estos pacientes no mejora con los corticoides. Recuerda que la biopsia de arteria temporal puede ser negativa debido a que la lesión arterial es parcheada.

14. Pregunta vinculada a la imagen n° 14:

Mujer de 70 años de edad que es traída al Servicio de Urgencias donde usted trabaja por haber presentado, de manera brusca mientras almorzaba hace 2 horas, alteración en la emisión del lenguaje y pérdida de fuerza y sensibilidad en hemicuerpo derecho. Usted evalúa a la paciente, confirmando estos hechos, y objetivando además hemianopsia homónima derecha por amenaza con respuesta cutáneo-plantar extensora derecha. Además de un análisis urgente que muestra hemograma, bioquímica y coagulación normales, y un ECG que arroja FA a 110 lpm (TA 175/ 100 mmHg), usted solicita TC cerebral inmediata cuyo resultado se muestra en la imagen. Señale la respuesta INCORRECTA:

1. La FA se asocia con ictus más graves y con AIT con mayor tiempo de recuperación que los producidos por la embolia arterio-arterial de la enfermedad carotídea.
2. La FA paroxística tiene el mismo riesgo embolígeno que la FA persistente.
3. No todo ictus acaecido en un paciente con FA es atribuible a esta arritmia.
4. Los infartos cerebrales de origen cardioembólico presentan menor riesgo de transformación hemorrágica que aquéllos debidos a un mecanismo aterotrombótico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un infarto de la arteria cerebral media izquierda (fíjate en la hiperdensidad de la arteria cerebral media izquierda o signo de la cuerda, signo indirecto de infarto en el TC). IMPORTANTE: el ictus cardioembólico tiene mayor tasa de transformación hemorrágica, y este riesgo es mayor en la primera semana postinfarto. El resto de opciones son correctas.

15. Pregunta vinculada a la imagen n° 15:

Mujer de 40 años, primigesta, acude a su consulta por primera vez hoy, en la semana 13, para el control de su gestación. Le realiza una ecografía abdominal obteniendo la imagen que se ofrece, en la que se mide la translucencia nucal (TN). Aporta un screening serológico con rubéola IgM negativo, Ig G positivo, siendo negativo para toxoplasma, sífilis y VIH. Se encuentra asintomática aunque refiere estar en tratamiento con antidiabéticos orales. Las cifras de TA fueron 150/ 95. Señale la opción más correcta:

1. La translucencia nucal está sugiriendo, entre otras cosas, riesgo de cardiopatía fetal.
2. No le daría la mayor importancia a la

translucencia nucal, pues no se encuentra en rango patológico.

3. La translucencia nucal no es valorable, pues no se ha medido en las semanas de gestación debidas.
4. La translucencia nucal nos indica diagnóstico de cromosomopatías, no sólo trisomía 21, sino también trisomía 13 y 18.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Imagen de translucencia nucal patológica (>3mm). Se debe medir entre las semana 11 y 14. No es diagnóstica, sugiere cromosomopatías e indica además, riesgo de cardiopatía.

16. Pregunta vinculada a la imagen n° 16:

Acude a urgencias un paciente de 82 años, hipertenso con cardiopatía hipertensiva, diabético tipo II en tratamiento oral y obeso, por disnea de reposo asociada a aumento de edemas e intolerancia al decúbito. Refiere que lleva una semana con tos, febrícula y expectoración amarillenta; no aqueja dolor pleurítico ni dolor anginoso. En la exploración muestra TA 155/75, FC 94, saturación de oxígeno 88% basal, ingurgitación yugular, edemas en ambos MMII hasta rodillas, auscultación cardiaca con ritmo de galope R3, auscultación pulmonar con crepitantes bibasales e hipofonesis en base izquierda. Se realiza una radiografía que se muestra en la imagen. ¿Qué descripción se corresponde con esta imagen radiológica?:

1. Infiltrado basal izquierdo con derrame asociado, sugerente de infiltrado neumónico.
2. Infiltrado perihiliar bilateral con cardiomegalia y derrame asociado, sugerente de insuficiencia cardiaca.
3. Infiltrado perihiliar bilateral con derrame asociado, sugerente de neumonía atípica bilateral.
4. Atelectasia basal izquierda con derrame asociado, sugerente de TEP.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La pregunta es de radiología, no de neumología. Tenemos una radiografía (de un varón, puesto que no hay silueta mamaria, y operado del corazón, puesto que hay cerclajes esternales) con una silueta cardiaca un poco ensanchada, con infiltrados alveolares perihiliares bilaterales, y derrame pleural bilateral de franco predominio derecho. La primera opción es insuficiencia cardiaca, probablemente desencadenada por una cuadro respiratorio de vías altas. Además, se ve la prótesis valvular aórtica que tiene implantada el paciente, superpuesta sobre un cuerpo vertebral

17. Pregunta vinculada a la imagen nº 17:

Mujer de 57 años diagnosticada de mieloma múltiple presenta las lesiones cutáneas y mucosas que se muestran en la imagen. ¿Cuál de las siguientes tinciones utilizaría para confirmar el diagnóstico?:

1. Warthin-Starry.
2. Gram.
3. Rojo Congo.
4. Hierro coloidal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El antecedente de mieloma y las lesiones que presenta esta paciente (púrpura periocular -ojos de mapache- y macroglosia) sugieren la presencia de amiloidosis primaria. El diagnóstico definitivo de amiloidosis se basa en la demostración anatomopatológica de los depósitos de sustancia amiloide que presentan características tintoriales específicas con la tinción de Rojo Congo (birrefringencia verde manzana en el microscopio de luz polarizada). El lugar de biopsia es aquella estructura sobre la que recae la sospecha de infiltración o bien en localizaciones de alto rendimiento diagnóstico, entre las que destaca la grasa abdominal subcutánea sobre la rectal por el menor número de complicaciones que implica su obtención.

18. Pregunta vinculada a la imagen nº 18:

Si en el paciente al que corresponde la imagen, al iniciar el tratamiento correspondiente, comienza con dificultad respiratoria y cuadro de inestabilidad hemodinámica sospecharía:

1. Cuadro de shock séptico.
2. Síndrome de Evans.
3. Síndrome de Richter.
4. Síndrome de ATRA (Síndrome de diferenciación).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La imagen muestra células grandes, inmaduras de aspecto blástico y en su citoplasma se detectan, múltiples granos así como unas inclusiones tipo astilla llamadas Bastones de Auer y típicas de las leucemias agudas mieloides. El paciente tiene una leucemia aguda mieloide y aunque el diagnóstico definitivo requiere un AMO, el cuadro clínico y la presencia de múltiples astillas de Auer, debe hacernos pensar en la LMA M3 (Promielocítica), que además es la Leucemia Aguda más preguntada en el MIR. El Síndrome de ATRA (o Síndrome de diferenciación) es una complicación relacionada con el tratamiento específico de la LAM-promielocítica (M3) que se puede presentar al inicio de tratamiento específico con ATRA. Se produce como consecuencia de la maduración rápida de los promielocitos expuestos a ATRA, con la consiguiente liberación de mediadores inflamatorios

de su citoplasma, lo que genera en el paciente un cuadro de respuesta inflamatoria sistémica en forma de edemas (por hiperpermeabilidad capilar), hipotensión y dificultad respiratoria (Repuesta 4 correcta). El tratamiento de estos pacientes es suspender ATRA de forma temporal y añadir oxígeno + corticoides + diurético.

19. Pregunta vinculada a la imagen nº 19:

Mujer de 49 años con antecedentes de tabaquismo (10 cigarrillos/día), hipertensión arterial en tratamiento con amlodipino, e hipercolesterolemia leve que controla con dieta. Es remitida a su consulta por cifras de calcemia persistentemente elevadas. No refiere antecedentes de cólicos renales y el examen físico es anodino. Analíticamente destaca Cr 0,9 mg/dL; Na 137 mEq/L; K 4,6 mEq/L ; Cl 102 mEq/L; proteínas totales 7,8 g/dL; albúmina 3,5 g/dL; Calcio total 10,3 mg/dL (normal 8,1-10,5); Fósforo 2,6 mg/dL; PTH 104 pg/mL (normal <70); Calciuria de 24 horas 600 mg/dL. Solicita una gammagrafía con sestamibi cuyo resultado se muestra en la imagen. Sobre la enfermedad que presenta esta paciente, es cierto:

1. El cuadro clínico es sugerente de hiperparatiroidismo primario. La gammagrafía muestra una hiperplasia de las paratiroides, por lo que habría que sospechar la presencia de un MEN I.
2. El diagnóstico de sospecha es bioquímico según las cifras de calcio y PTH plasmáticos. El diagnóstico de confirmación precisa de una gammagrafía, que además precisa el número de glándulas afectas y su localización.
3. La paciente presenta un hiperparatiroidismo primario. Aunque la calcemia es normal en este momento no puede descartarse el diagnóstico, ya que en la mayoría de los casos la hipercalcemia es leve e intermitente.
4. La gammagrafía muestra un adenoma paratiroideo, que es la causa más frecuente de hiperparatiroidismo. La localización habitual del adenoma es en la glándula inferior izquierda.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La paciente presenta un hiperparatiroidismo primario (hipercalcemia, hipofosforemia y cifras elevadas de PTH). El diagnóstico es bioquímico y la gammagrafía NO es necesaria para confirmarlo (opción 2 falsa), aunque ayuda a diferenciar hiperplasia de adenoma y precisar la localización. La imagen muestra un adenoma paratiroideo hipercaptante en fase tardía (la fase precoz muestra también la tiroides), opción 1 falsa. La hipercalcemia en el hiperPTH puede ser intermitente, por lo que el calcio normal NO descarta su diagnóstico. No obstante, el calcio de esta paciente NO es

normal. Aunque el calcio sérico es normal hasta 10,5 mg/dL, debe ajustarse según las cifras de albúmina [Calcio corregido (mg/dL) = (4.0 - Albumina serica [g/dl]) x 0.8 + Ca total (mg/dL)]. El calcio corregido de esta paciente es 10,7 mg/dL, y por tanto por encima de los límites normales.

20. Pregunta vinculada a la imagen n° 20:

Lactante de 9 meses que acude a Urgencias por cuadro de fiebre hasta 39°C de 4 días de evolución junto con cuadro catarral de larga evolución. Sus padres le notan más decaído. Sin antecedentes personales de interés, correctamente vacunado (incluido 3 dosis de vacuna neumocócica 13 valente). A la exploración física presenta Tª 38,5°C, aceptable estado general, sin aspecto séptico, sin petequias, sin signos externos de dificultad respiratoria, con auscultación cardiopulmonar normal y ORL normal. Se realiza radiografía de tórax adjunta. ¿Qué observa en la imagen?

1. Atelectasia en el lóbulo superior derecho.
2. Radiografía de tórax normal.
3. Neumonía en lóbulo superior derecho.
4. Radiografía de tórax compatible con bronquiolitis aguda.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de la típica imagen del signo de la vela tímica (opción 2 CORRECTA), en los lactantes es normal tener hipertrofia tímica y es normal observar dicha estructura de forma habitual en la radiografía de tórax. El signo radiológico más característico es el que se presenta en la imagen de esta pregunta, aunque también puede verse el signo de la onda tímica (las costillas hacen mella en la imagen tímica). También puede aparecer en el lado izquierdo con imágenes aberrantes que no debemos confundir con una neumonía, el timo está extrapulmonar por tanto, no desplaza estructuras, ni tiene efecto masa, no produce disminución de volumen pulmonar compensatorio (como si ocurriría en una neumonía o atelectasia pulmonar) ni veremos broncograma aéreo (opciones 1 y 3 incorrectas).

21. Pregunta vinculada a la imagen n° 21:

Varón de 38 años, VIH positivo que acude a Consultas presentando dolor abdominal generalizado y fiebre de 4 semanas de evolución. En la exploración clínica presenta hepatoesplenomegalia sin adenopatías significativas así como unas lesiones papulonodulares sobreelevadas de aspecto vascular en miembros inferiores. Las transaminasas fueron normales excepto la fosfatasa alcalina que se encontraba discretamente elevada (5 veces por encima de lo normal). La ecografía hepática mostró

heterogenicidad del parénquima hepático que fue confirmado posteriormente mediante TC (ver imagen). ¿Qué prueba diagnóstica le parecería más rentable?

1. Hemocultivos en medio específico para hongos, así como determinación de Beta-glucano plasmático y fondo de ojo.
2. Realización de Radiografía de tórax así como de TAC cerebral para confirmar la existencia de otras lesiones abscesificadas. En caso de evidenciarse en parénquima pulmonar, proceder a realizar fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar.
3. Inicialmente buscaríamos lesiones cutáneas para biopsiar. En caso de no encontrarlas, probablemente se requiera de una biopsia en cuña hepática para estudio histopatológico ya que la rentabilidad del aspirado es bajo para el diagnóstico de esta entidad. El cultivo de la muestra mediante lisis-centrifugación así como la PCR podrían ser de ayuda.
4. Un fondo de ojo podría ser de utilidad así como una Radiografía de tórax que mostraría un patrón miliar evidente. Si las muestras microbiológicas respiratorias o de jugo gástrico no fueran diagnósticas se podría plantear la realización de una biopsia de médula ósea.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil en la que se nos están planteando métodos diagnósticos y terapéuticos para las siguientes entidades: a) Candidiasis hepatoesplénica, b) Nocardiosis, c) Peliosis hepática, d) Tuberculosis miliar y e) Leishmaniasis visceral. En esta pregunta se hace referencia a una peliosis hepática, producida por Bartonella henselae. La clave para el diagnóstico nos la da la presencia de lesiones cutáneas compatibles con una angiomasia bacilar así como la imagen del TAC que sugiere afectación hepática

22. Pregunta vinculada a la imagen n° 22:

Varón de 42 años de origen guineano que refiere cuadro de tres meses dolor en la cara lateral del cuello. En las últimas 3 semanas presenta una masa con exudación amarillenta. Refiere asimismo pérdida de peso de 5 Kgs junto con sudoración nocturna y fiebre de bajo grado. La exploración física evidenciaba una úlcera de 2 cms (ver imagen). La radiografía de tórax fue normal y el TAC mostró abundantes ganglios linfáticos aumentados de tamaño con áreas de necrosis en su interior. La serología para VIH fue positiva, con 47 CD4+ y carga viral de 85.000 copias de RNA/mL. ¿Cuál le parece el planteamiento terapéutico más adecuado?

1. Comenzar tratamiento con Trimetoprim-

sulfametoxazol como profilaxis de la neumonía por *P. jiroveci* así como tratamiento con Etambutol, Claritromicina, y Rifabutin. Asociar tratamiento con Abacavir, Lamivudina y Efavirenz dado que el paciente presenta menos de 500 CD4+.

2. Comenzar tratamiento con Trimetoprim-sulfametoxazol como profilaxis de la neumonía por *P. jiroveci* así como tratamiento con Etambutol, Pirazinamida, Isoniacida y Rifampicina. Retrasar el tratamiento con Abacavir, Lamivudina y Efavirenz unas tres semanas desde el inicio del tratamiento antituberculoso.
3. Anfotericina B liposomal así como tratamiento con Trimetoprim-sulfametoxazol como profilaxis de la neumonía por *P. jiroveci*. Iniciar de inmediato Abacavir, Lamivudina y Efavirenz.
4. Derivar a la consulta de ORL para planteamiento de exéresis tumoral quirúrgica con radioterapia posterior. Una vez resuelta la patología tumoral comenzar tratamiento con Tenofovir, Emtricitabina y Raltegravir.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una escrófula (linfadenitis tuberculosa). La imagen es muy característica en el contexto de un paciente VIH+ por lo que no debería generar dudas en su diagnóstico. La duda puede surgir entre la opción 1 y la 4. En la primera se hace referencia al tratamiento del MAI y en la cuarta al de la Tuberculosis. Recordad que por debajo de 50 CD4+, el tratamiento antirretroviral ha de retrasarse 2-3 semanas para evitar el Sd de reconstitución inmune (si presentase más de 50 CD4+ se podría demorar 8 semanas).

23. Pregunta vinculada a la imagen nº 23:

En el servicio de urgencias atiende a una paciente que se queja de dolor en fosa iliaca izquierda desde hace 2 días. En el último día, además, han aparecido vómitos y fiebre de hasta 39°C. En la exploración física destaca dolor a la palpación en fosa iliaca izquierda con irritación peritoneal. En la analítica tiene 23.000 leucocitos/ml. La paciente aporta un enema opaco realizado hace dos años. ¿Qué es lo que se observa en ese enema opaco?

1. Cáncer de colon.
2. Una estenosis benigna del sigma.
3. Diverticulosis.
4. Una angiodisplasia de colon.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El caso es el típico de una diverticulitis (la clínica es igual que una apendicitis pero en la fosa iliaca izquierda). En la

imagen se ve como el bario rellena los sacos de los divertículos dando unas imágenes características. Le llamamos diverticulosis a la presencia de divertículos sin patología (como es en el caso de cuando la paciente se hizo el enema). Recordad que no se debe realizar esta prueba en pacientes con diverticulitis aguda por el riesgo de empeorar ésta al aumentar la presión dentro del divertículo.

24. Pregunta vinculada a la imagen nº 24:

Se muestra una imagen de TC helicoidal torácica con contraste de una mujer de 86 años, hipertensa y obesa, que acudió a Urgencias de su hospital por dolor torácico de varias horas de evolución. Indique el diagnóstico:

1. Disección de aorta.
2. Cáncer de pulmón que infiltra pericardio y pared aórtica.
3. Rotura cardiaca.
4. Aneurisma de aorta roto.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La imagen muestra un corte axial del corazón bastante craneal, a nivel de los grandes vasos. En la zona más posterior de la imagen, a la izquierda de la columna vertebral, está la aorta descendente. Más anterior está un corte de la aurícula izquierda, y anterior a ésta, cruzando en diagonal, la arteria pulmonar. La imagen circular anterior, de gran diámetro y con una línea en su interior que la atraviesa de manera oblicua, es la aorta ascendente, y la línea es el "flap" intimal que separa la luz verdadera (más pequeña) de la luz falsa (más grande) de una disección aórtica.

25. Pregunta vinculada a la imagen nº 25:

La imagen corresponde a niña de 2 años que acude a Urgencias con dolor abdominal intermitente de dos días de evolución, febrícula, náuseas, vómitos y leucocitosis de 15000/ul. La imagen es sugerente de:

1. Apendicitis aguda.
2. Invaginación ileocólica.
3. Adenitis mesentérica.
4. Vólvulo intestinal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Imagen que ha sido preguntada en el MIR. Estamos ante la visión ecográfica transversal típica de un invaginación intestinal con el signo de la "diana" o "donut". Halo periférico hipocogénico: pared edematosa del asa intususciente. - Asa intermedia hiperecogénica: espacio entre asas intususciente e intususepta. - Anillo interno hipocogénico: asa intususepta. Además se muestran hallazgos en Eco-Doppler color, que demuestra el compromiso de los vasos mesentéricos entre las paredes entrante y saliente del asa intususepta.

26. Pregunta vinculada a la imagen nº 26:

Un paciente de 37 años, profesor de matemáticas, presenta desde hace 1 año debilidad de la musculatura proximal, fenómeno de Raynaud, fibrosis pulmonar, poliartalgias y lesiones en la cara lateral de los dedos que se muestran en la imagen. ¿Qué anticuerpo esperaría encontrar positivo?

1. Anti-Jo1.
2. Factor reumatoide.
3. Anti-Sm.
4. Anti-La.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un paciente con un síndrome antisintetasa, que se caracteriza por la presencia de miositis, fenómeno de Raynaud, enfermedad pulmonar intersticial, artralgias/artritis e hiperqueratosis en la cara lateral de los dedos denominada "manos de mecánico", representada en la imagen. En el síndrome antisintetasa aparece positividad de anticuerpos antisintetasa, destacando entre todos ellos el anti-Jo1 (también conocido como anti-histidil-RNAt-sintetasa) que se asocia a las características clínicas de la pregunta anterior, especialmente a la neumopatía intersticial.

27. Pregunta vinculada a la imagen nº 27.

Una mujer de 24 años, fumadora, consulta a la urgencia por odinodisfagia de 4 días de evolución que se ha hecho peor el día de hoy, localizándose hacia el lado izquierdo. Fiebre no termometrada e imposibilidad casi total para la ingesta de alimentos. A la exploración presenta adenopatías laterocervicales dolorosas bilaterales, trismus moderado y la imagen anexa al ver la orofaringe. El diagnóstico inicial más probable entre los siguientes es:

1. Absceso periamigdalino izquierdo.
2. Mononucleosis infecciosa.
3. Angina de Ludwig.
4. Absceso retrofaringeo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La presencia de trismus y el empeoramiento en un cuadro general de amigdalitis debe hacernos sospechar la presencia de alguna complicación. La más frecuente es el absceso periamigdalino, que en el caso de la pregunta se confirma con la imagen de abombamiento del paladar blando y desplazamiento de la amígdala afectada y la úvula. El tratamiento debe incluir el drenaje de la colección y algunas dosis de antibiótico IV.

28. Pregunta vinculada a la imagen nº 28:

Hombre de mediana edad, diagnosticado de síndrome de Sjögren, que se queja de cuadro de inicio insidioso de pérdida de fuerza principalmente a nivel proximal de las cuatro extremidades y visión borrosa y diplopia, aunque añade extrañado que al iniciar un ejercicio nota cierta recuperación. Usted comprueba este dato en la exploración física, observando además que los reflejos osteotendinosos se encuentran abolidos. Como parte del estudio del paciente de la pregunta anterior, usted obtiene la radiografía que se muestra en la imagen. A estas alturas del proceso diagnóstico, usted está ya en condiciones de saber que una de las siguientes aseveraciones es INCORRECTA:

1. La estimulación única dará un potencial de respuesta disminuido.
2. Algunas sustancias como la tubocurarina o el dexametoni empeoran la clínica.
3. La plasmaféresis y la terapia inmunosupresora son útiles en el tratamiento de este síndrome.
4. Probablemente se trate de un carcinoma de células grandes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un caso de síndrome de Eaton-Lambert, que como sabes es un trastorno presináptico de la unión neuromuscular. El síndrome de Eaton-Lambert se asocia típicamente al carcinoma pulmonar de células pequeñas (respuesta 4 incorrecta). El resto de opciones son correctas.

29. Pregunta vinculada a la imagen nº 29:

Varón de 28 años sin antecedentes de interés que acude al hospital por cuadro de una semana de evolución de malestar general y orinas oscuras. En la exploración física muestra TA 161/92 mmHg sin otros hallazgos. Se practica análisis urgente que muestra Creatinina 1.6 mg/dl, proteínas totales 6.1 g/dl, albúmina 3.5 g/dl, y sedimento de orina con sangre +++ y proteínas ++. Es ingresado para estudio, solicitándose complemento que resulta normal y serologías víricas (VIH, VHB y VHC) que resultan negativas. Se practica finalmente una biopsia renal (en la imagen se muestra la inmunofluorescencia directa para IgG, anticuerpos anti-IgG humana marcados con fluoresceína a 400x). El diagnóstico final es:

1. Glomerulonefritis membranosa.
2. Glomerulonefritis membranoproliferativa.
3. Glomerulonefritis extracapilar de tipo 1.
4. Glomerulonefritis extracapilar de tipo 2.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un paciente con síndrome nefrítico (HTA, FRA, hematuria y proteinuria), por lo que podemos descartar la GN membranosa al ser causa de síndrome nefrítico (respuesta 1 falsa). Dado que el complemento es normal, podemos descartar la GN membranoproliferativa y la GN extracapilar de tipo 2 dado que ambas cursan con hipocomplementemia (respuestas 2 y 4 falsas). Por lo tanto, el paciente padece una GN extracapilar de tipo 1 (respuesta 3 CORRECTA) debido a la presencia de anticuerpos anti-membrana basal glomerular, siendo característico y exclusivo el hallazgo de un depósito LINEAL de IgG en la inmunofluorescencia que se muestra en la imagen.

30. Pregunta vinculada a la imagen nº 30:

Su servicio ha comenzado un nuevo programa de implante de asistencias ventriculares de largo plazo como puente a trasplante cardiaco. Tras dos años de actividad se decide realizar una auditoría y valorar los resultados en su población con dispositivo todavía en la lista de espera de trasplante, con respecto a aquellos pacientes ya trasplantados tras el implante de asistencia ventricular. Los resultados se muestran en la imagen asociada. Señale la presupuesta correcta con respecto a dicha gráfica:

1. La supervivencia en los pacientes trasplantados no mostró diferencias durante el primer año pero fue claramente superior a los dos años con respecto a los pacientes no trasplantados indicando que los resultados de la terapia como puente a trasplante son mejores si el trasplante se lleva a cabo lo antes posible.
2. La supervivencia de los pacientes trasplantados es claramente superior al año y dos años y se reduce a los 4 años indicando que las diferencias son sólo significativas en el primer periodo tras el implante.
3. La supervivencia de los pacientes trasplantados es superior a los no trasplantados durante todo el seguimiento pero la diferencia no es estadísticamente significativa.
4. La supervivencia de los pacientes trasplantados es superior a los no trasplantados durante todo el seguimiento por lo que debemos considerar que el trasplante en pacientes con este tipo de dispositivo es una mejor alternativa a largo plazo que el mantenimiento como terapia destino sin trasplante.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La gráfica de supervivencia muestra que los valores durante todo el seguimiento son superiores en los pacientes trasplantados con respecto a los de los paciente no trasplantados. Aún así, la diferencia es estadísticamente no significativa ($p < 0.21$).

31. Sobre la circulación coronaria, señale la respuesta correcta:

1. El grado máximo de flujo coronario se obtiene en la sístole isovolumétrica.
2. La adenosina tiene un efecto vasoconstrictor, reduciendo el flujo coronario.
3. La resistencia es el impedimento que muestra un vaso al paso del flujo sanguíneo, siendo un parámetro opuesto a la conductancia.
4. El flujo turbulento es característico de arterias largas y lisas.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La opción 3 recoge la definición de “resistencia” en cuanto a dinámica de fluidos se refiere, adaptado a la fisiología. Recuerda que la hiperemia o flujo máximo de las arterias coronarias se obtiene en diástole. La adenosina tiene un efecto vasodilatador, y puede utilizarse como fármaco de test de detección de isquemia farmacológica en la gammagrafía o resonancia magnética por su capacidad de producir “robo coronario” (aunque habitualmente se utiliza la regadenosina, con una semivida algo más larga). El flujo turbulento es característico de arterias con obstrucciones / placas de ateroma.

32. Una de las siguientes no es una ramificación directa del tronco celiaco:

1. Arteria esplénica.
2. Arteria gástrica izquierda.
3. Arteria hepática.
4. Arteria gastroduodenal.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Esplénica, gástrica izquierda y hepática son las tres ramas del tronco celiaco. La hepática se divide a su vez en la gastroduodenal y la gástrica izquierda antes de dar la hepática propia.

33. ¿Cuál de las siguientes hormonas estimula la secreción de bicarbonato por el páncreas?:

1. Insulina.
2. Colecistocinina.
3. Secretina.
4. Glucagón.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La secretina regula la secreción de agua y bicarbonato.

34. Paciente con adenocarcinoma de recto medio-bajo T2N0M0 recibe quimiorradioterapia neoadyuvante y se programa para resección anterior baja. Se plantea cirugía robótica. ¿Cuál es una ventaja diferencial frente a la laparoscopia convencional?

1. Reducción significativa del tiempo quirúrgico.
2. Mayor preservación del aparato esfinteriano y nervios pélvicos
3. Disminución clara de tasa de recidiva tumoral
4. Indicada solo en tumores T1-T2.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La cirugía robótica aporta ventaja clara en cirugía pelviana profunda (generalmente en la cirugía compleja por cirugía laparoscópica clásica por localizaciones estrechas o difíciles donde tener 5 grados de libertad en los movimientos sería una ventaja: recto, páncreas, esófago). La cirugía robótica es solo un abordaje por lo tanto T no condiciona la elección del abordaje, lleva más tiempo que la cirugía clásica laparoscópica y tiene que ser igual oncológicamente que el gold-standar clásico. Se ha asociado a menor disfunción urogenital porque al ser una disección más fina permite preservar las estructuras nerviosas de la pelvis, sin aumentar la tasa de complicaciones ni oncología negativa

35. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre agentes infecciosos y neoplasias cutáneas malignas no está descrita?:

1. Sarcoma de Kaposi – Virus herpes humano 8 (VHH-8).
2. Carcinoma espinocelular – Virus del papiloma humano (VPH).
3. Dermatofibrosarcoma protuberans – Virus de Epstein-Barr (VEB).
4. Carcinoma de Merkel – Poliomavirus (MCPyV).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El dermatofibrosarcoma protuberans, considerado una variante maligna del dermatofibroma, es un tumor poco frecuente que se presenta en forma de pápulas y nódulos indurados, mal delimitados o incluso de apariencia multifocal en una misma área, con poca tendencia a las metástasis pero un comportamiento localmente agresivo. Por todo ello, el tratamiento de elección es la cirugía de Mohs. Hasta la fecha, no se ha descrito asociación con agentes infecciosos (respuesta 3 falsa y por tanto correcta). Contrariamente, todos los sarcomas de Kaposi guardan relación con el virus herpes 8, y se han descrito también las asociaciones de poliomavirus con gran parte de los carcinomas de Merkel y del VPH en ciertos carcinomas epidermoides (especialmente los no asociados a radiación ultravioleta, como los secundarios a lesiones premalignas por VPH oncogénicos en región anogenital).

36. Con respecto a la ginecomastia en el adulto, solo una de las siguientes es correcta:

1. Las causas hormonales fundamentales son la hiperprolactinemia, hipotiroidismo e hipogonadismo.
2. La ginecomastia secundaria a tumores testiculares se debe fundamentalmente

a hiperproducción de testosterona con hipogonadismo secundario.

3. La obesidad no provoca ginecomastia sino adipomastia, por lipoacúmulo a nivel mamario.
4. En el anciano puede aparecer ginecomastia fisiológica por aumento de globulinas transportadoras de hormonas sexuales (SHBG).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica directa sobre causas de ginecomastia. La ginecomastia puede ser fisiológica de forma natural en tres momentos de la vida, por desbalance entre andrógenos y estrógenos: al nacimiento (conversión placentaria de estrógenos maternos en estrona y estradiol), en la pubertad (el aumento de estrona/estradiol precede al aumento de testosterona) y en el anciano (el aumento de SHBG fija mayor cantidad de testosterona que de estrógenos). La obesidad puede ser causa de adipomastia o ginecomastia, por el exceso de aromatasa adipocitaria que transforma testosterona en estrona/estradiol. La ginecomastia secundaria a tumor hipofisario no suele deberse a interferencia en el eje gonadotrofo sino a producción de beta-HCG con hiperestrogenismo secundario (se estimula la síntesis suprarrenal de estrógenos). Por último, es causa endocrinológica de ginecomastia, aparte de las consabidas hiperprolactinemias, hiperestrogenismos e hipogonadismos, el hipertiroidismo por enfermedad de Graves, en que aparecen aumento de LH (estimula fabricación de estrona por células Sertoli), de SHBG y de aromatización de testosterona.

37. Derivan a su consulta de Endocrinología a un varón de 26 años por alteraciones analíticas realizadas en Atención Primaria. Presenta una glucemia basal en ayunas de 90 mg/dL, HbA1c de 4.9%, anticuerpos anti-GAD, IA2 y ZnT8 positivos, siendo el resto de analítica normal. Su padre fue diagnosticado de Diabetes tipo 2 cuando tenía 38 años tras un episodio de hiperglucemia acompañada de clínica cardinal. Actualmente tiene 52 años y está en tratamiento con insulina exclusivamente, con buen control, tras una evolución complicada alternando muchos tratamientos, ingresos por descompensaciones y presentando complicaciones crónicas (retinopatía y nefropatía). Su abuelo también era diabético. Respecto a este caso, señale la respuesta correcta:

1. El paciente se encuentra en un estadio 2 de la DM-1, por lo que se beneficiaría de tratamiento farmacológico específico preventivo.
2. No cumple criterios para tratamiento farmacológico específico preventivo porque debe tener positividad de anticuerpos registrada al menos durante 8 años.
3. La decisión de su Médico de Atención Primaria de realizar el estudio inmunológico es correcta dados los antecedentes familiares.

4. La positividad de estos anticuerpos es un hallazgo casual, no requiere más estudios ni seguimiento por parte de Endocrinología.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El paciente presenta autoinmunidad positiva para DM-1 pero sus parámetros glucémicos son normales, por lo tanto se encontraría en un estadio 1 y en este estadio no está indicado el tratamiento farmacológico específico preventivo: teplizumab (respuesta 1 falsa). Para que estuviera indicada su administración debe cumplirse criterios de estadio 2 (parámetros de glucemia de pre-diabetes y autoinmunidad positiva) y además el paciente debe tener una edad de 8 años o más (respuesta 2 falsa). Cuando la autoinmunidad para DM-1 sale positiva requiere seguimiento, se recomienda confirmar con una segunda prueba en los siguientes 3 meses, si esta es positiva requiere seguimiento estrecho ya que la positividad persistente tiene elevado riesgo de desarrollar DM-1 en el futuro (respuesta 4 falsa). Actualmente se recomienda el estudio de autoinmunidad en paciente con antecedentes familiares de DM-1. En este caso sabemos que su abuelo fue diabético (no lo especifican) y su padre se clasificó como DM-2, pero la mala evolución con tratamientos y las múltiples descompensaciones y que actualmente este bien controlado solo con insulina ha de hacernos pensar que fue mal clasificado como DM-2 (por lo tanto respuesta 3 correcta). Actualmente se está estudiando la susceptibilidad genética de cada persona para establecer un tamizaje más adecuado en el futuro.

38. **La obesidad puede inducir un estado inflamatorio de baja intensidad, con hiperproducción por parte de adipocitos y macrófagos de citoquinas tales como el TNF- α , la IL-6, la IL-18, la IL-1 β y la Ang-II. Dichas citoquinas inducen entre otras, resistencia a la insulina. Uno de los siguientes mecanismos de la resistencia a la insulina NO está influido por citoquinas proinflamatorias:**

1. Activación de cinasas de Ser/Thr.
2. Disminución en la expresión de IRS-1, GLUT-4 y receptor PPAR-gamma.
3. Expresión y activación de SOCS-3.
4. Activación de los receptores de tipo toll (TLR), en particular TLR-2 y TLR-4.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Parte de la resistencia insulínica inducida por obesidad tiene mediación inmunológica, por un estado inflamatorio de bajo grado inducido por la propia obesidad. Las citoquinas proinflamatorias son responsables de, entre otras, activación de cinasas de Ser/Thr (que reducen la actividad del receptor de insulina y de las IRS), disminución de expresión de IRS-1, GLUT-4 y receptor PPAR-gamma, y expresión de SOCS-3. SOCS son proteínas supresoras de proteínas de señalización de citoquinas, y activan las rutas de señalización inflamatorias a la vez que inhiben la señalización intracelular de la insulina. Es cierto que en la resistencia a la insulina mediada

por obesidad existe una activación de los receptores TLR2 y TLR4, pero está provocada por los ácidos grasos libres, no por citoquinas.

39. **Mujer de 40 años con antecedentes personales de DM-1 e hipotiroidismo primario. En tratamiento con levotiroxina e insulina. Acude a Urgencias por malestar general, dolor abdominal difuso y vómitos persistentes a pesar de automedicarse con metoclopramida. Presenta una TA: 80/45 mmHg, FC: 70 lpm, T^a: 36.3°C, Sat 99% basal. A la exploración el abdomen es normal, la paciente tiene manchas oscuras en labios y mucosa yugal, el resto es normal. A nivel analítico destaca: Glucemia 60 mg/dL, sodio 129 mEq/L, potasio 5.7 mEq/L, pH 7.23, HCO₃⁻ 19. Respecto a la enfermedad que sospecha, señale la correcta:**

1. Es más frecuente en edad adulta.
2. La paciente tiene una insuficiencia suprarrenal secundaria.
3. Es un trastorno debido a la mutación del gen AIRE en el cromosoma 21.
4. No se ha visto implicado ningún HLA.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Por los hallazgos clínicos, tenemos que pensar que el motivo de consulta en Urgencias de esta paciente es una crisis suprarrenal por insuficiencia suprarrenal. El hecho de que presente hiperpigmentación en los labios y cavidad oral nos tiene que hacer pensar en una insuficiencia suprarrenal primaria (respuesta 2 falsa). Si sumamos este hallazgo a los antecedentes de patología de la paciente (DM-1 e hipotiroidismo primario), toda hace pensar en un síndrome poliglandular autoinmune, siendo el que más encaja en este caso el tipo II o Sd. Schmidt. Este síndrome es típico de edad adulta (respuesta 1 correcta), de herencia familiar (casos AD, AR y poligénicos) (respuesta 3 falsa) y se ha relacionado con HLA DR3 y DR4 (respuesta 4 falsa). Las respuestas falsas corresponden a características del SPA-I.

40. **Respecto a las hipoglucemias, señale la respuesta falsa:**

1. El péptido C en sangre está disminuido en los pacientes que toman sulfonilureas.
2. El péptido C en sangre está aumentado en los pacientes con insulinoma.
3. Una de las características de la tríada de Whipple es la desaparición de los síntomas tras normalizar la glucemia.
4. La hipoglucemia postprandial es típica de pacientes con gastrectomía.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La insulina se produce como parte de rotura de una pro-hormona llamada pro-insulina. Esta al romperse libera la insulina y el péptido C. Situaciones en las que haya un aumento

de producción de insulina ha de haber aumento de péptido C. Por ello en el insulinoma y en los pacientes en tratamiento con sulfonilureas el péptido C está elevado (respuesta 1 falsa y por tanto la correcta, respuesta 2 verdadera). La triada de Whipple se caracteriza por clínica de hipoglucemia, constatar la hipoglucemia bioquímicamente y la desaparición de los síntomas tras corregirla (respuesta 3 verdadera). En pacientes gastrectomizados, puede ocurrir un fenómeno de hipersecreción de insulina que cause una hipoglucemia, sobre todo cuando hay comidas con abundantes hidratos de carbono de absorción rápida (respuesta 4 verdadera).

41. Las gestaciones múltiples son aquéllas en las que se desarrolla más de un feto, siendo las más frecuentes las gemelares. Es importante además diferenciar entre gestaciones gemelares bicoriales y monocoriales, dado que las segundas presentan una mayor tasa de complicaciones. Señale la correcta sobre las gestaciones gemelares:

1. Los siameses aparecen cuando la división del cigoto ocurre de manera precoz, antes de los 12 días desde la fecundación.
2. Las gestaciones monocoriales pueden ser bi- o monoamnióticas.
3. Las gestaciones bicoriales no pueden dar lugar a gemelos idénticos.
4. La división más tardía del embrión, durante la segunda semana desde la fecundación, da lugar a las gestaciones bicoriales.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las gestaciones monocoriales pueden ser biamnióticas o monoamnióticas, en función de si la división embrionaria sucede antes o después de las primeras 72 h posfecundación (respuesta 2 correcta). Los siameses aparecen cuando la división en más tardía, a partir de los 13 días posfecundación (respuestas 1 y 4 falsas). Las gestaciones bicoriales pueden tener un origen dicigoto o monocigoto, por lo que pueden dar lugar a mellizos o a gemelos idénticos (respuesta 3 falsa).

42. En relación a ceftazidima-avibactam:

1. Está indicado para el tratamiento de infecciones por cepas resistentes a carbapenemasas (KPC y OXA-48).
2. No es necesario ajuste de dosis en insuficiencia renal.
3. Las dosis son estándar en todo tipo de infección y se ha de administrar siempre en monoterapia.
4. No es un fármaco útil en las infecciones por *P. aeruginosa* resistente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La ceftazidima-avibactam es un fármaco que presenta actividad para los BGN productores de carbapenemasas como

KPC y OXA-48 y se considera un tratamiento eficaz para las infecciones por *P. aeruginosa* resistentes. La dosis varía en función de la localización y en muchas ocasiones precisa darse combinado con otros fármacos. Precisa ajuste a función renal.

43. ¿Qué molécula no es liberada con la degranulación de los mastocitos unidos por alta afinidad a IgE una vez que el antígeno (alérgeno) es detectado por la inmunoglobulina?:

1. Histamina.
2. Triptasa.
3. Proteína básica mayor.
4. Heparinoides.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuando los mastocitos se activan por la unión del alérgeno a la IgE situada en el receptor de alta afinidad FcεRI, liberan mediadores preformados almacenados en sus gránulos, así como mediadores sintetizados de novo. Entre ellos: histamina, con funciones de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, responsable del prurito; triptasa, proteasa liberada por los mastocitos y usada como marcador de activación mastocitaria en reacciones alérgicas sistémicas; heparinoides, polisacáridos sulfatados que regulan la actividad de las proteasas mastocitarias y modulan la inflamación. La proteína básica mayor (BMP) no es producido por los mastocitos, sino un mediador citotóxico liberado por los eosinófilos.

44. Con relación a la hematopoyesis, ¿cuál de los siguientes enunciados es falso?

1. La interacción entre la integrina VLA-4 de la HSC CD34+ con la VCAM-1 de las células estromales medulares, promueve la supervivencia, proliferación y diferenciación y permite el homing de la célula madre hematopoyética en la médula.
2. La acción de la IL-7 sobre la célula madre hematopoyética multipotente promueve su diferenciación hacia el precursor pluripotente linfóide.
3. Una parte de los progenitores pluripotentes linfoides se quedan en la médula ósea y comienzan el proceso de maduración hacia células pro-B, mientras que otra parte pasa a circulación y migra al timo, evolucionando a células pro-T.
4. El timo es un órgano linfóide secundario, ya que allí se produce la maduración de las células T tras la generación de sus precursores en la médula ósea.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El timo no es un órgano linfóide secundario, sino un órgano linfóide primario. Los órganos linfoides primarios son aque-

llos donde se originan y maduran las células inmunológicas, como las células T en el timo y las células B en la médula ósea. Los órganos linfoides secundarios (como los ganglios linfáticos y el bazo) son donde las células inmunológicas se activan y se producen las respuestas inmunitarias. En cuanto al resto de opciones: la interacción entre VLA-4 y VCAM-1 permite el homing y la diferenciación de las células madre hematopoiéticas en la médula ósea; la IL-7 promueve la diferenciación de las células madre hematopoiéticas hacia precursores linfoides, específicamente hacia linajes T y B; y los progenitores linfoides se dividen en dos rutas, una migrando al timo para madurar a células T y otra permaneciendo en la médula ósea para madurar hacia células B.

45. A nivel endocrinológico y metabólico, ¿qué cambio de los siguientes es esperable encontrar durante el proceso de envejecimiento?:

1. Resistencia periférica a la insulina.
2. Aumento de la producción de hormona tiroidea y consiguiente descenso de la TSH.
3. Aumento de la producción de hormona tiroidea y consiguiente descenso de la TSH.
4. Resistencia hipofisaria al cortisol.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Con el paso del tiempo, los tejidos periféricos van generando más resistencia a la insulina (respuesta 1 correcta) de manera que ésta no puede meter glucosa a las células, lo que deriva en una situación de hiperglucemia y aumento del riesgo de desarrollar DM tipo 2. La respuesta 3 es falsa porque dice justo lo contrario. Las respuestas 2 y 4 son falsas porque no tienen sentido (no aumenta la producción de hormona tiroidea, en todo caso lo esperable es que se produzca algo menos; tampoco hay resistencia hipofisaria al cortisol, de lo contrario todos los viejecitos tendrían Síndrome de Cushing).

46. En relación con la curva flujo-volumen, una estenosis traqueal fija produce:

1. Morfología normal.
2. Aplanamiento solo inspiratorio.
3. Aplanamiento solo espiratorio.
4. Aplanamiento inspiratorio y espiratorio (en meseta).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La estenosis traqueal (que puede ocurrir por intubaciones prolongadas, tumores traqueales o compresión extrínseca por ejemplo por un bocio) produce una estenosis fija de la vía aérea, estas afectan ambos flujos y aplanan la curva en ambos sentidos, ya que esa zona no se dilata ni colapsa con la inspiración ni con la espiración, a diferencia de lo que ocurre en las obstrucciones variables. Se llama estenosis fija cuando la obstrucción está en un segmento de la vía aérea que no cambia de calibre con la presión intratorácica, es decir: es rígida y constante, tanto en inspiración como

en espiración. Regla mnemotécnica: Fija = Aplanamiento en los dos lados Variable extratorácica = aplanamiento sólo inspiratorio Variable intratorácica = aplanamiento sólo espiratorio.

47. ¿Cuál de estas alteraciones funcionales resulta sugestiva de debilidad diafragmática?:

1. Alteración de los flujos mesoespiratorios forzados sin afectación de la FEV1 y de la capacidad vital forzada.
2. Disminución importante del FEV1/FVC.
3. Mejoría de la alteración de la capacidad pulmonar total tras el ejercicio.
4. Disminución de la FVC con empeoramiento del resultado obtenido en decúbito supino respecto a la sedestación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En las pruebas funcionales respiratorias de un paciente con disfunción diafragmática observaremos un trastorno restrictivo (capacidad pulmonar total disminuida), y, en este caso, se trata de una alteración esencialmente inspiratoria, mantendrá un volumen residual normal. Por otra parte, estos pacientes empeoran en decúbito supino, pues el diafragma es incapaz de contrarrestar el aumento de presión que ejerce el abdomen en la cavidad torácica y todavía hace menos fuerza (respuesta 4 correcta). Las respuestas 1 y 2 hacen referencia a patrones obstructivos.

48. Respecto a la ecografía clínica multiórgano en el manejo del tromboembolismo pulmonar (TEP) señale la respuesta CORRECTA:

1. En un paciente inestable la ausencia de disfunción del ventrículo derecho descarta el TEP como causa de la inestabilidad.
2. El hallazgo de una trombosis venosa profunda es suficiente para establecer el diagnóstico de TEP.
3. Una ecografía multiórgano negativa en el paciente estable descarta TEP.
4. En la ecocardiografía en presencia de TEP lo típico es encontrar disfunción del ventrículo izquierdo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La ecografía clínica multiórgano consiste en realizar un ecocardiograma y una ecografía de las venas de las piernas en Urgencias, y opcionalmente una ecografía pulmonar. Se considera positiva si hay presencia simultánea de TVP en sistema venoso y disfunción de VD o infartos subpleurales (opción 2 incorrecta). Una ecografía multiórgano negativa en paciente estable no descarta TEP: tiene un alto VPP y bajo VPN (opción 3 incorrecta). En cambio, en el paciente inestable es más valiosa porque sí puede descartar TEP si la ecocardiografía demuestra ausencia de disfunción del ventrículo derecho (opción 1 correcta).

49. En relación al triángulo de Nelaton en el diagnóstico de la luxación de codo, señale la respuesta correcta:

1. Se trata de un triángulo isósceles formado por la epitroclea, el epicóndilo y el olécranon.
2. En condiciones normales el olécranon se sitúa por encima de la línea que une epitroclea y epicóndilo.
3. En la luxación posterior de codo, el olécranon se sitúa en la misma línea que la epitroclea y el epicóndilo.
4. En condiciones normales, el olécranon, la epitroclea y el epicóndilo forman un triángulo equilátero.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El triángulo de Nelaton es una referencia anatómica importante para valorar la congruencia articular del codo. En condiciones normales, el olécranon, la epitroclea y el epicóndilo forman un triángulo equilátero (opción 4 correcta). La opción 2 es incorrecta porque en condiciones normales el olécranon se sitúa por debajo (no por encima). En la luxación posterior de codo se pierde la configuración triangular normal (3 incorrecta)

50. Señale cuál de los siguientes NO es un factor de riesgo relacionado con el desarrollo de hallux valgus:

1. Calzado estrecho con tacón alto.
2. Hiperlaxitud.
3. Pies cavos.
4. Antecedentes familiares.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre factores de riesgo del hallux valgus. El pie cavo (opción 3) no es un factor de riesgo para el desarrollo de hallux valgus, sino al contrario: el pie plano (no el cavo) predispone al hallux valgus. Las otras opciones sí son factores de riesgo reconocidos: el calzado estrecho con tacón alto (opción 1) es probablemente el factor extrínseco más importante, ya que comprime los dedos y aumenta la presión sobre el antepié. La hiperlaxitud ligamentosa, antecedentes familiares y edad avanzada también son factores de riesgo.

51. Señale la FALSA respecto a las vacunas contra el neumococo de polisacáridos conjugados con proteínas (PCV15 o PCV20):

1. Los linfocitos B reconocen el polisacárido y presentan la proteína al linfocito T permitiendo una reacción T dependiente.
2. Los polisacáridos son antígenos T independientes cuya unión al carrier hace que la respuesta inmune pase a ser T dependiente.
3. Tras el proceso de vacunación se obtiene memoria duradera mediada por IgG,

mayoritariamente por IgG4.

4. Los polisacáridos de la cápsula bacteriana son reconocidos por linfocitos B1 (CD5 +) predominantes en las serosas de manera natural dando una respuesta tipo IgM.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla que se responde por descarte. En las vacunas conjugadas se conjugan un polisacárido que no puede ser reconocido por el Linfocito T (debido a la restricción por histocompatibilidad) con un carrier proteico (habitualmente un toxoide, muy inmunógeno). De esta manera una reacción T independiente pasa a ser T dependiente puesto que los linfocitos B reconocen el polisacárido y presentan la proteína al linfocito T que inducirá la síntesis de anticuerpos contra el polisacárido (1 y 2 correctas). Tras el proceso de vacunación se obtendrá memoria duradera mediada por IgG, principalmente por IgG1 (3 incorrecta). Por último, recuerda que los polisacáridos bacteriana de manera natural pueden ser reconocidos por linfocitos B1 (CD5 +) mediante una respuesta T independiente que producirá IgM de manera rápida.

52. Valora a un niño de 3 años con antecedente de retraso en la dentición, varias infecciones pulmonares una de las cuales precisó de ingreso hospitalario y un episodio de celulitis. En la analítica destacan leucocitos 6800 (4.000 -11.000/mm³, linfocitos 980 (1.000-4.800/mm³), eosinófilos: 1121 (100-500/mm³), IgA: 96 (70- 400 mg/dL), IgM: 39 (40 a 230 mg/dL), IgG: 1278 (700-1.600 mg/dL), IgE 855 (<100 UI/mL). El test de VIH es negativo. En el estudio de subpoblaciones linfocitarias, los linfocitos Th17 están disminuidos. ¿Cuál de las siguientes enfermedades y pruebas diagnósticas es más probable?:

1. STAT 3- Síndrome de Job.
2. Test de nitroazul de tetrazolio- Enfermedad granulomatosa crónica.
3. Citometría de flujo para valorar CD18 - déficit de adhesión leucocitaria.
4. RAG 1-Síndrome de Omen.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un paciente con sospecha de inmunodeficiencia. Como antecedente además destaca retraso en la dentición. En la analítica destaca elevación de IgE y eosinofilia. Por lo tanto, sospechamos un síndrome hiper IgE, de ellos dadas las características como el retraso en la dentición, el más probable es el Síndrome de Job cuyo diagnóstico se establece genéticamente por la mutación en STAT 3. Otras características de este síndrome son las alteraciones cutáneas y óseas (extensión articular aumentada). Además, es característica la disminución de linfocitos Th17. El Síndrome de Omen, otro síndrome Hiper IGE no presenta alteraciones en la dentición pero sí hepatoesplenomegalia y linfadenopatías.

53. ¿Cuál es las siguientes afirmaciones es VERDADERA respecto a los últimos avances en la terapia CAR-T para el mieloma múltiple?:

1. BCMA es el único antígeno al que se dirigen las terapias CAR-T en mieloma múltiple.
2. La terapia CAR-T proporciona una cura permanente para la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple.
3. Se están desarrollando terapias CAR-T de doble diana antigénica para superar la evasión inmune y la resistencia de algunos pacientes ante sistemas anti-BCMA.
4. La terapia CAR-T no tiene efectos secundarios significativos en comparación con la quimioterapia tradicional.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La mayor parte de CAR-T dirigidos al tratamiento del mieloma múltiple utilizan como diana BCMA (B-cell maturation antigen) por su expresión casi constante en estas discrasias hematológicas, aunque ya se han ensayado otras dianas como SLAMF7 o GPRC5D. Tanto idecabtagene vicleucel como belcartamab yebtansine reconocen y se unen a BCMA. Por otra parte, ciertas células se hacen resistentes o refractarias al tratamiento inhibiendo la expresión de BCMA, algo que, otros desarrollos intentan superar al incluir sistemas de receptor de antígeno quimérico que reconocen tanto a BCMA como a antígenos secundarios presentes en las células de mieloma múltiple (GPRC5D, SLAMF7, CD19...). Aunque la terapia CAR-T puede inducir remisiones profundas y prolongadas, la mayoría de los pacientes eventualmente recaen, y el mieloma múltiple sigue considerándose una enfermedad incurable. La terapia CAR-T puede producir efectos adversos graves, como el síndrome de liberación de citocinas (CRS) y el de neurotoxicidad asociada a células inmunitarias efectoras (ICANS), potencialmente letales.

54. Un investigador está interesado en determinar si existen diferencias significativas en la puntuación media de ansiedad (medida en una escala cuantitativa) entre dos grupos de pacientes: un grupo que recibió una terapia nueva y un grupo control que recibe una terapia estándar. ¿Cuál de las siguientes pruebas estadísticas sería la más apropiada para analizar estos datos?

1. Chi-cuadrado.
2. ANOVA.
3. t-Student.
4. Correlación de Pearson.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre escoger test estadístico. El razonamiento debe ser siempre el mismo. Primero buscamos el tipo de variable (cualitativa o cuantitativa). En este caso, nos hablan

de una escala cuantitativa. Segundo, tenemos que escoger si se trata de una comparación entre dos o más grupos (o dos o más momentos del tiempo). Fácil, en este caso, dos grupos. Por último, según la característica de la variable usaremos un test paramétrico o no paramétrico. En este caso, no nos dan mucha información respecto a características más específicas de la escala, pero entre las opciones, deberemos escoger la t-Student. Puedes contestar de forma directa si recuerdas este test es el adecuado para comparar medias de variables cuantitativas entre dos grupos independientes.

55. Un signo o síntomas patognomónico es aquel cuya presencia asegura la presencia de una determinada enfermedad. De los siguientes parámetros, indique cuáles de ellos presentan un valor del 100%:

1. Sensibilidad y especificidad.
2. Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo.
3. Sensibilidad y valor predictivo negativo.
4. Especificidad y valor predictivo positivo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Un signo o síntoma patognomónico implica que todos aquellos sujetos que lo presenten son enfermos (verdaderos positivos), por lo que por definición el Valor Predictivo Positivo (VPP) es 100%. De esta definición se extrae que no existen falsos positivos, por lo que la especificidad es de manera secundaria 100%.

56. La incidencia de una determinada enfermedad en la población de estudio es del 1%. Al aplicar un determinado factor protector en dicha población, la incidencia de enfermedad se reduce al 0.5%. Con estos datos, indique cuál es el NNT de dicho factor protector:

1. 200.
2. 20.
3. 2.
4. 2000.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Incidencia en no expuestos al factor protector (Io): 1%, Incidencia en Expuestos al factor protector (Ie): 0.5%. De esto se extrae que la RAR es 0.5%. Recordad que para calcular el NNT hay que "CERRAR--> 100/RAR". $100/0.5=200$.

57. Un equipo de investigadores está interesado en estudiar la posible asociación entre el consumo de bebidas energéticas y la aparición de fibrilación auricular (FA) en pacientes menores de 35 años. La literatura indica que la densidad de incidencia de FA en este grupo poblacional es menor que 1/500.000 pacientes-año. Los investigadores definen la variable dicotómica

“consumo de bebidas energéticas” con las categorías “sí” (≥ 2 bebidas a la semana) y “no” (≤ 1 bebidas a la semana). Se buscan 200 personas menores de 35 años con FA y, posteriormente, 400 personas menores de 35 años sin FA, y se investiga el consumo de bebidas energéticas en cada uno de los grupos. Quedan excluidos del estudio pacientes con cardiopatía estructural o canalopatías congénitas conocidas. Señale la afirmación VERDADERA:

1. Para estudiar la asociación causal, en este caso habría sido más conveniente un estudio con seguimiento prospectivo.
2. El riesgo relativo obtenido en el estudio será probablemente superior a 1.
3. Existe un error metodológico, puesto que ambos grupos deben contar con un número similar de pacientes.
4. Es un diseño adecuado para estudiar otros posibles factores asociados a la aparición de FA en ese grupo etario.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un estudio de casos y controles, en el que se definen dos grupos (pacientes con FA y pacientes sin FA) posteriormente se estudia su asociación con un factor de exposición (el consumo de bebidas energéticas). No te dejes confundir por el orden en que te lo cuenten en el enunciado, sino en el diseño del estudio. Recuerda las características de este tipo de estudio y sus diferencias con los estudios de cohortes. Es un diseño retrospectivo (por lo que no se pueden medir incidencias ni riesgos relativos: respuesta 2 falsa), adecuado para enfermedades con baja incidencia (respuesta 1 falsa), que nos permite estudiar varios factores de riesgo asociados a una enfermedad (respuesta 4 verdadera). No es necesario que el número de casos y controles sea el mismo (respuesta 3 falsa). En este tipo de preguntas, las opciones te tratarán de confundir con el diseño de cohortes, que tiene propiedades “opuestas”.

58. Se quiere estudiar la eficacia de tres tratamientos diferentes para una enfermedad rara, con pocos pacientes. De acuerdo con la literatura, existe la posibilidad de que la combinación de alguno de ellos tenga un efecto sinérgico. ¿Cuál es el diseño más adecuado?:

1. Diseño secuencial.
2. Ensayo clínico aleatorizado, triple ciego, con grupos paralelos.
3. Diseño polietápico.
4. Diseño factorial.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El diseño factorial es el diseño más eficiente cuando existen >2 opciones de tratamiento. Consiste en dividir la mues-

tra en grupos que toman cada tratamiento por separado, y grupos que toman cada una de las posibles combinaciones de tratamientos. Este diseño permite, por un lado, evaluar interacciones entre los tratamientos. Por otro lado, ahorra tamaño muestral, puesto que los pacientes que toman varios tratamientos cuentan para los resultados de cada uno de los tratamientos.

59. Se quiere estudiar la asociación entre la exposición a un tipo de microplástico ambiental y la aparición de cáncer de tiroides (sin especificar el tipo) mediante un estudio de casos y controles. Para ello, seleccionan 100 casos entre los pacientes que acuden actualmente a las consultas de endocrino-oncología, y se buscan 100 controles de características parecidas. Se trata de un tipo de microplástico que ha demostrado en estudios sin seguimiento una asociación con el carcinoma anaplásico de tiroides. En el estudio se obtiene un $OR = 1,1$ $IC_{95\%} [0,93 - 1,34]$. Señale la afirmación CORRECTA:

1. Se confirma la hipótesis de que existe asociación entre dichos microplásticos y el cáncer de tiroides.
2. Dicho OR está probablemente sobreestimado.
3. Debería repetirse el estudio, esta vez anidado en una cohorte.
4. Queda descartada la asociación entre dichos microplásticos y el cáncer de tiroides.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un estudio de casos y controles en el que probablemente se está ocurriendo en un sesgo de incidencia-prevalencia (falacia de Neyman). Se trata de un error sistemático que puede ocurrir en estudios de tipo caso-control, que ocurre cuando cuando se seleccionan únicamente los casos prevalentes de una enfermedad, por una diferencia entre los casos prevalentes y los casos incidentes. En nuestro caso, la evidencia sugiere que los microplásticos producen sobre todo el cáncer de tiroides de subtipo anaplásico, que tiene un pronóstico muy malo y una evolución corta. Si solo seleccionamos los casos prevalentes de cáncer de tiroides (los que duran más y acuden a consultas), probablemente encontraremos principalmente tipos papilar y folicular, que tienen mejor pronóstico y no son los que más se asocian a nuestros microplásticos. Los anaplásicos nos los “perderemos”, porque “no llegan a consulta”, y de este modo infraestimaremos la asociación entre los microplásticos y el cáncer de tiroides (respuesta 3 falsa). Esto se previene siguiendo una cohorte y seleccionando cada caso de cáncer de tiroides que vaya apareciendo – casos incidentes: un estudio de casos y controles anidado (respuesta 3 correcta). El intervalo de confianza cruza el valor nulo (1): no podemos ni afirmar la hipótesis alternativa ni rechazar la hipótesis nula (respuestas 1 y 4 falsas).

60. Un varón de 18 años sin antecedentes relevantes es intervenido de apendicitis aguda bajo anestesia general con sevoflurano y suxametonio. A los 15 minutos tras el inicio de la cirugía el paciente presenta taquicardia de 150 lpm, hipercapnia progresiva (PaCO₂ 70 mmHg), rigidez muscular generalizada y temperatura central de 40,8°C. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a este caso?:

1. El tratamiento de elección es el enfriamiento externo, sueroterapia fría y benzodiacepinas de acción corta.
2. La fisiopatología de este fenómeno está relacionada con una alteración del canal sodio dependiente de voltaje (gen SCN5A) del retículo sarcoplásmico.
3. El dantroleno sódico actúa bloqueando la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y es fundamental iniciarlo precozmente.
4. Es una reacción inmunoalérgica tipo I y se puede prevenir con corticoides preoperatorios en pacientes de riesgo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos están describiendo una situación típica de hipertermia maligna. Recordamos que este fenómeno es una enfermedad autosómica dominante que se produce por alteración en el receptor de la rianodina, el cual es un canal de CALCIO localizado en la membrana del retículo sarcoplásmico. La alteración del canal de SODIO relacionado con el gen SCN5A es típica de otras patologías como el Síndrome de Brugada, pero no de la hipertermia maligna (respuesta 2 falsa). El tratamiento consiste en iniciar rápidamente un relajante muscular, concretamente el dantroleno (respuesta 3 verdadera) además de aplicar medidas de enfriamiento externo y antitérmicos iv (respuesta 1 falsa). Evidentemente este cuadro no es una reacción alérgica (respuesta 4 falsa).

61. En relación a las prótesis valvulares, señale la afirmación correcta:

1. Las prótesis biológicas son de elección en pacientes de edad avanzada, con una duración cada vez mayor debido a los avances tecnológicos que se encuentra en torno a los 15-20 años. A menor edad de implante, mayor riesgo de degeneración precoz.
2. Las prótesis mecánicas (metálicas) precisan anticoagulación indefinida, pudiendo emplearse antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes orales de acción directa (estos últimos a dosis más altas de lo habitual).
3. El implante de prótesis valvular aórtica percutánea puede realizarse con tejido biológico o metálico.
4. Los pacientes con prótesis valvulares biológicas precisan profilaxis de endocarditis en determinadas circunstancias (por ejemplo,

procedimientos dentales), pero no en las mecánicas ya que no hay descritas endocarditis sobre las mismas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La respuesta correcta es la uno. Las prótesis mecánicas las reservaremos para pacientes de menos de 65 años por su mayor durabilidad, y precisan anticoagulación con antagonistas de la vitamina K por que son muy trombogénicas (no valen los ACOD). Las prótesis biológicas si bien tienen cada vez una durabilidad mayor (>15-20 años), cuanto más joven se implanten menor tiempo durarán por que se degeneran a mayor velocidad.

62. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la escala APACHE II es correcta?:

1. La puntuación total se calcula exclusivamente valorar la edad, variables fisiológicas y el diagnóstico principal al ingreso en UCI.
2. Entre las variables fisiológicas evaluadas se incluye la saturación de oxígeno y la bilirrubina total.
3. El APACHE II permite estimar la mortalidad en UCI en función de parámetros fisiológicos agudos, nivel de conciencia, edad y comorbilidades.
4. La escala APACHE II ha sido reemplazada por la APACHE III en la práctica clínica habitual por su mayor precisión.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La escala APACHE II evalúa 12 variables fisiológicas recogidas en las primeras 24h de ingreso en UCI, la edad del paciente, enfermedades crónicas y escala Glasgow (respuesta 3 correcta). La respuesta 2 es falsa ya que ni la bilirrubina ni la saturación de oxígeno están incluidas en esta escala (OJO! la saturación de oxígeno no, pero la presión arterial de oxígeno y/o la fracción de oxígeno inspirado sí). La respuesta 4 es falsa porque, aunque el APACHE III es más moderno (año de publicación 1991) que el APACHE II (año de publicación 1985), no se utiliza en la práctica clínica ya que es mucho más complejo de usar y requiere gran cantidad de datos.

63. Un paciente varón de 65 años con antecedentes de HTA y ERGE, es programado para una colecistectomía laparoscópica por colelitiasis. Durante la inducción anestésica se realiza una secuencia de intubación rápida con preoxigenación adecuada. Se administra fentanilo seguido de Propofol y rocuronio. Tras 60 segundos se realiza IOT (intubación orotraqueal) con éxito. ¿Cuál es la principal razón para utilizar esta secuencia de inducción rápida en este paciente?:

1. Minimizar la hipotensión arterial producida por Propofol.

2. Evitar la bradicardia secundaria al uso de opioides durante la inducción.
3. Reducir el riesgo de broncoespasmo en pacientes con patología respiratoria crónica.
4. Disminuir el riesgo de aspiración pulmonar por contenido gástrico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La inducción de secuencia rápida (RSI) se utiliza para minimizar el tiempo entre la pérdida de conciencia y la intubación orotraqueal para así reducir el riesgo de aspiraciones. Ninguno de los otros efectos (hipotensión arterial, bradicardia o broncoespasmo) tiene nada que ver (ni se evita) con la inducción de secuencia rápida (respuesta 4 verdadera, resto falsas).

64. Una mujer de 80 años con problemas de visión desde hace años, refiere un empeoramiento súbito de su visión en el ojo izquierdo durante la última semana. Describe una nueva área borrosa y distorsionada al leer. La agudeza visual en su ojo izquierdo ha disminuido de 20/40 a 20/80. El examen de fondo de ojo revela la presencia de hemorragias subretinianas y exudados en la mácula del ojo izquierdo. ¿Cuál de los siguientes tratamientos se considera de primera elección según su sospecha diagnóstica?

1. Suplementación oral con altas dosis de vitaminas antioxidantes y zinc (fórmula AREDS).
2. Fotocoagulación con láser térmico.
3. Terapia fotodinámica (TFD) con verteporfina.
4. Inyecciones intravítreas de aflibercept.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El caso clínico describe una DMAE seca que ha evolucionado a una forma húmeda (progresión de una semana, con nueva metamorfopsia y fondo de ojo con hemorragias y exudación). El tratamiento de la DMAE exudativa es con inyecciones intravítreas de anti-VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular). Como por ejemplo ranibizumab, bevacizumab, aflibercept, y faricimab.

65. Mujer de 36 años, previamente sana, acude a su oftalmólogo por visión borrosa y aparición de moscas volantes en su ojo derecho durante la última semana. Niega dolor ocular significativo, pero sí leve molestia. En la exploración, se observa una vitritis activa con células inflamatorias en la cavidad vítrea y una lesión retinocoroidea blanquecina macular con bordes borrosos en la retina posterior del ojo derecho, adyacente a una cicatriz pigmentada antigua. No presenta signos de inmunosupresión sistémica. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el manejo inicial más adecuado?:

1. Observación y seguimiento sin tratamiento activo, dado que la mayoría de las lesiones son autolimitadas en individuos inmunocompetentes.
2. Inicio inmediato de corticosteroides tópicos para reducir la inflamación intraocular.
3. Inicio de tratamiento con antibióticos de amplio espectro para cubrir posibles infecciones bacterianas secundarias.
4. Inicio de tratamiento antiparasitario sistémico (por ejemplo, pirimetamina con sulfadiazina y leucovorina) junto con corticosteroides sistémicos o tópicos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta. El enunciado es un caso clínico clásico de toxoplasmosis ocular (paciente sano, con midesopsias, vitritis y lesión tipo “faro en la niebla”, con cicatriz antigua). El tratamiento habitual está indicado cuando tiene pérdida de visión, afectación central o la lesión es cercana a grandes vasos retinianos o a el nervio óptico. Consiste en terapia antiparasitaria sistémica combinada con corticosteroides para controlar la inflamación asociada. La observación sin tratamiento activo podría ser una opción en lesiones periféricas pequeñas sin inflamación significativa o amenaza macular.

66. Varón de 42 años que acude al Servicio de Urgencias por dolor de inicio agudo en su ojo derecho, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y fotofobia. Al examen con lámpara de hendidura, se observa una lesión ramificada fluo positiva en la córnea del OD, sin afectación estromal significativa. La agudeza visual en el ojo izquierdo es de 20/30. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

1. Inicio de tratamiento con un antiviral tópico (aciclovir pomada oftálmica).
2. Administración tópica de corticosteroides para reducir la inflamación corneal.
3. Oclusión ocular con parche para promover la curación epitelial.
4. Lavados con suero salino e higiene extrema.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Respuesta de dificultad media-alta. Una lesión ramificada en el epitelio corneal (fluo positiva) sin antecedentes de traumatismo previo es típica de los herpes virus (dendrita). El tratamiento de elección es pomada oftálmica de aciclovir o ganciclovir. Los lavados con suero y la higiene extrema son la base del tratamiento de las conjuntivitis infecciosas.

67. Paciente de 34 años que acude a consulta de otorrinolaringología por presentar hipoacusia progresiva de oído derecho que ha progresado rápidamente tras los tres embarazos que ha tenido. No ha presentado otorrea ni antecedentes

de otitis, aunque comenta que su madre presentó el mismo problema. Sobre la patología que sospecha cuál de las siguientes respuestas es falsa:

1. La otoscopia es generalmente normal.
2. En relación con la patología que sospecho la prueba de Rinne tendría que evidenciar una vía ósea en el oído derecho predominante sobre la vía aérea.
3. Si realizamos una audiometría verbal independientemente del volumen a la que se realice la prueba no vamos a conseguir el 100 % de discriminación.
4. En la audiometría tonal encontraremos una vía ósea en rango de normoacusia con una vía aérea patológica formando un GAP audiométrico en las frecuencias graves.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos orientan un caso de una mujer con hipoacusia progresiva del oído derecho, antecedentes familiares de hipoacusia y empeoramiento tras cambios hormonales, con lo que tenemos que orientar el caso hacia una posible otosclerosis. Una vez orientada la pregunta la respuesta incorrecta es la 3. La otosclerosis presenta en la mayoría de los casos una otoscopia normal, aunque en ocasiones podemos encontrar la mancha de Schwartz, que aunque patognomónica es infrecuente. La respuesta 2 nos dice que si realizamos una prueba de Rinne tiene que ser compatible con hipoacusia de transmisión, por lo que el Rinne tiene que ser negativo (vía ósea predominante sobre vía aérea), al igual que la respuesta 4 que nos describe una audiometría tonal compatible con hipoacusia de transmisión. La respuesta 3 es incorrecta, ya que las hipoacusias de transmisión como la que genera la otosclerosis genera una discriminación del 100 % pero la curva está desplazada hacia la derecha, es decir en rango de hipoacusia.

68. Un paciente adulto es derivado a Otorrinolaringología porque presenta hipoacusia de oído izquierdo y sensación de autofonía, sin otalgia de 3 meses de evolución. El paciente niega haber presentado síntomas compatibles con coriza ni otro proceso nasosinusal. En la otoscopia se evidencia un tímpano ambarino con niveles hidroaéreos en el oído izquierdo, mientras que el oído derecho es normal. Sobre la enfermedad otológica que presenta el paciente, señale la respuesta correcta:

1. Es recomendable realizar una fibroscopia de la nasofaringe para descartar un proceso neoplásico.
2. La sensación de autofonía es muy sugestiva de una hipoacusia que curse con distorsión de intensidad o reclutamiento.
3. Teniendo presente los hallazgos otoscópicos

que se describen en el caso clínico, el Weber se lateralizará hacia el oído derecho.

4. La timpanometría de ambos oídos presentará curva centrada en presión de 0 mmH2O.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico sobre un paciente adulto que presenta hipoacusia y sensación de taponamiento con un tímpano ambarino lo que nos debe hacer sospechar una otitis secretora (acumulación mucóide detrás de la membrana timpánica). Aunque la causa más frecuente en adultos es generada en un proceso de rinitis aguda, nunca hay que olvidar que puede ser la primera manifestación de un cáncer de cavum o nasofaringe, por lo que es obligado realizar una exploración del cavum con fibroscopia ante otitis secretora unilaterales fuera de un contexto catarral (respuesta 1 correcta). La pérdida auditiva que genera la otitis secretora es una hipoacusia de transmisión, por lo que no habrá reclutamiento, ya que está sensación de distorsión de intensidad es típica de hipoacusia neurosensorial coclear. Al ser una hipoacusia de transmisión el Rinne será negativo en el oído patológico y el Weber se desplazará hacia el oído enfermo (respuesta 2 y 3 falsa). En cuanto a la timpanometría, recordad que hay que tener en cuenta que la timpanometría se aplana cuando con los cambios de presión la membrana no se puede mover, que sería con la ocupación del oído medio o las perforaciones timpánicas. En condiciones normales la timpanometría se encuentra centrada a 0 mm de H2O.

69. Paciente de 14 años con historia de otorreas de repetición fétidas de oído izquierdo y que en la exploración física se objetiva una lesión blanquecina en la región epitimpánica. Acude al servicio de urgencias por síndrome séptico, cefalea, vómitos, disminución del nivel de conciencia y focalidad neurológica como parálisis facial central izquierda. En las pruebas de imagen complementarias se diagnostica un absceso cerebral a nivel parietal izquierdo que explicaría la presencia de la exploración facial previamente descrita, pero ¿cómo sería la exploración física de la función facial en este paciente?:

1. La comisura bucal se desplaza hacia el lado izquierdo y existe afectación de las ramas frontal y ocular.
2. La comisura bucal se desplaza hacia el lado izquierdo y las ramas frontal y ocular no están afectadas.
3. Existe parálisis facial completa de la hemicara izquierda.
4. La comisura bucal se desplaza a la derecha al sonreír y las ramas frontal y ocular no están afectadas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos proponen un caso clínico de una complicación intracra-neal de un posible colesteatoma pero que cursa con parálisis facial central, por lo que nos están preguntado cómo es la exploración física en una parálisis facial central. Recordad que se produce una asimetría facial con debilidad de la mitad inferior de la cara contralateral a la lesión mientras que el paciente puede fruncir el ceño y elevar las cejas sin dificultad, es decir, se produce, en las parálisis faciales centrales, afectación del tercio inferior de la hemicara contralateral a la lesión (respuesta 2 correcta).

70. ¿Qué músculo intrínseco de la laringe se encarga de la abducción de las cuerdas vocales?:

1. Circotiroideo.
2. Cricoaritenoideo posterior.
3. Cricoaritenoideo lateral.
4. Tiroaritenoideo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta directa sobre anatomía de la laringe, en concreto una pregunta sobre el único músculo encargado de abrir, abducir las cuerdas vocales es el músculo cricoaritenoideo posterior y está inervado por el nervio laríngeo recurrente (respuesta correcta 2).

71. ¿Cuál de las siguientes aserveraciones sobre el papiloma invertido es incorrecta?:

1. No suele presentar agresividad local.
2. El riesgo de malignización hacia carcinoma epidermoide está entre el 5-10 %.
3. Existe un importante riesgo de recidiva que en los últimos años ha disminuido con el desarrollo de la cirugía endoscópica nasosinusal hasta aproximadamente el 15 %.
4. Tenemos que sospechar un papiloma invertido en pacientes con rinorrea serosanguinolenta unilateral y una masa unilateral en fosa nasal de color rosado-griseáceo y superficie lobulada o verrugosa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El papiloma invertido es una lesión premaligna de la fosa nasal que suele cursar con rinorrea serosanguinolenta unilateral y se muestra en la endoscopia nasal como una masa grisácea y lobulada o de aspecto cerebriforme (respuesta 4 correcta). La presencia de rinorrea con restos de sangre nos indica de manera directa que, aunque el tumor puramente es benigno, puede presentar destrucción de las estructuras anatómicas de las fosas nasales, por lo que aunque sea benigno tiene un comportamiento maligno (respuesta 1 incorrecta). Tiene una probabilidad de aproximadamente el 7 % de malignizar y de recidiva de hasta el 10-15 %. Aunque no sean datos clave para el examen, sí teneis que recordar que puede recidivar y tiene potencial de malignizar.

72. Con respecto a mola hidatiforme completa, señale la opción verdadera:

1. Se debe administrar tratamiento con metotrexate y ácido fólico semanal en cualquier caso, hasta la negativización de la B-HCG.
2. El seguimiento tras la evacuación uterina se realiza mediante la determinación semanal de B-HCG durante tres semanas y posteriormente mensual durante 1 año.
3. El estudio de extensión ha de realizarse a todas las pacientes con body TAC y RM pélvica.
4. El diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional siempre requiere confirmación histopatológica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El tratamiento curativo de la mola es el legrado evacuador, y no serán necesarios la administración de MTX ni el estudio de extensión salvo que se sospeche una neoplasia trofoblástica (respuestas 1 y 3 falsas), cosa que sucede cuando las titulaciones de B-HCG se mantienen en meseta o aumentan (respuesta 4 falsa). El seguimiento de la mola completa es de 1 año, mientras que el de la mola parcial es de 6 meses (respuesta 2 correcta).

73. Dentro de las complicaciones asociadas al polihidramnios NO se encuentra:

1. Parto prematuro.
2. Rotura prematura de membranas.
3. Desprendimiento prematuro de placenta normalmente inserta.
4. Crecimiento intrauterino restringido.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El polihidramnios se asocia típicamente a la macrosomía fetal (diabetes gestacional). Complicaciones derivadas de la sobredistensión uterina son el parto prematuro, la rotura prematura de membranas y el desprendimiento de placenta, cuando la pérdida de tanto volumen de líquido disminuye la presión intrauterina (respuestas 1, 2 y 3 verdaderas).

74. Mujer de 7 años que debuta con una leucemia aguda y precisa tratamiento con quimioterapia gonadotóxica. Antes de comenzar la quimioterapia, ¿podemos plantearle algún método de preservación de fertilidad?

1. Preservación de corteza ovárica.
2. Vitricación de ovocitos.
3. Ooforopexia.
4. No existen técnicas adecuadas que podamos recomendarle.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La preservación de fertilidad en mujeres prepúberes que van

a comenzar un tratamiento potencialmente gonadotóxico debe realizarse mediante criopreservación de corteza ovárica, y siempre antes de comenzar dicho tratamiento. Cuando la paciente en un futuro desee gestación, se podrá realizar la descongelación y el trasplante del tejido ovárico. En cambio, en mujeres postpúberes que van a comenzar un tratamiento de quimioterapia gonadotóxica, la técnica de elección es la vitrificación de ovocitos.

75. ¿Cuál de los siguientes NO es un criterio de malignidad ecográfico de las masas anexiales?

1. Ausencia de estructuras papilares.
2. Flujo sanguíneo muy intenso (score de color 4/4).
3. Tumor mayor de 10 cm de bordes irregulares, mal definidos.
4. Presencia de ascitis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La ausencia de estructuras papilares en formaciones quísticas es un criterio de benignidad. Si vemos papilas grandes o vascularizadas debemos sospechar malignidad. Todos los demás son criterios de sospecha.

76. Con respecto a la histogénesis del cáncer de ovario, es cierto que:

1. El 75% de las masas ováricas son malignas.
2. El 90% de los cánceres de ovario deriva del epitelio superficial.
3. Los tumores germinales son más frecuentes en la menopausia.
4. Los tumores de los cordones sexuales nunca tienen producción hormonal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El 75% de las masas ováricas son benignas (1 falsa), pero el 90% de las malignas es de estirpe epitelial (2 verdadera). Los tumores germinales son típicos de mujeres en edad fértil (3 falsa). Los tumores de los cordones sexuales frecuentemente producen hormonas (estrógenos los de la granulosa, testosterona los de las células de Leydig, etc.) (4 falsa).

77. Ante una paciente con diagnóstico de hiperémesis gravídica, que NO es necesario en primera instancia:

1. Ingreso hospitalario para reposición hidroelectrolítica.
2. Electrocardiograma.
3. Metoclopramida intravenosa hasta inicio de tolerancia oral progresiva.
4. Sonda nasogástrica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante una hiperémesis gravídica es necesario el ingreso para reposición hidroelectrolítica, hasta que la paciente tolere por vía oral (respuesta 1 correcta). Es importante descartar afectación del ECG por hipopotasemia (respuesta 2 correcta). La actitud inicial debe incluir antieméticos IV (respuesta 3 correcta), pero la sonda nasogástrica no será necesaria salvo ausencia de mejoría en 4-5 días (respuesta 4 falsa).

78. Respecto a la prevención del parto pretérmino espontáneo en gestantes con factores de riesgo, señale la opción CORRECTA:

1. El uso de progesterona vaginal puede estar indicado en gestantes con longitud cervical acortada, aunque no tengan antecedentes de prematuridad.
2. La progesterona vaginal está indicada únicamente en gestantes con antecedentes de parto pretérmino espontáneo previo.
3. El cerclaje cervical está indicado en gestantes con cérvix <25 mm, independientemente de sus antecedentes obstétricos previos.
4. El pesario cervical ha demostrado consistentemente mayor eficacia que el cerclaje en gestantes con cérvix corto y antecedentes de prematuridad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La opción 1 es correcta. La administración de progesterona vaginal está indicada como medida preventiva en gestantes asintomáticas con cuello uterino corto (<25 mm) detectado por ecografía transvaginal entre las semanas 16-24, incluso sin antecedentes previos de parto pretérmino. Su uso ha demostrado reducir el riesgo de prematuridad en gestaciones únicas y es una de las medidas más eficaces y con buen perfil de seguridad. La opción 2 es incorrecta porque restringe el uso de progesterona solo a gestantes con antecedentes de parto pretérmino. Si bien en ese grupo también podría estar indicada, no es el único criterio: la longitud cervical es un factor independiente que justifica su uso, con o sin historia previa. La opción 3 también es falsa. El cerclaje cervical no se indica únicamente por cérvix corto en mujeres sin antecedentes. Está especialmente indicado en pacientes con cérvix <25 mm + antecedente de parto pretérmino espontáneo o pérdida gestacional tardía. En gestantes sin antecedentes, se suele preferir progesterona como primera línea. La opción 4 es incorrecta. Aunque el pesario cervical es una opción no invasiva que se ha explorado en gestantes con cérvix corto, la evidencia sobre su eficacia es contradictoria, y no ha demostrado superioridad consistente sobre otras medidas como el cerclaje o la progesterona. Su uso se considera en algunos casos seleccionados, pero no como primera elección.

79. Mujer de 34 años, con diagnóstico de endometrioma ovárico derecho de 3,5 cm, que consulta por dismenorrea intensa y dispareunia

profunda. No desea gestación a corto plazo, pero ha probado anticonceptivos combinados sin mejoría clínica. Según las guías actuales, ¿cuál de las siguientes opciones estaría justificadamente indicada como siguiente escalón terapéutico?

1. Tratamiento con Relugolix, Estradiol y Acetato de Noretisterona; terapia combinada diaria oral.
2. Observación periódica con controles ecográficos cada 6 meses.
3. Iniciar anticoncepción oral combinada en pauta cíclica en lugar de pauta continua y control clínico en 6 meses.
4. Programar cirugía para realizar anexectomía derecha vía laparoscópica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La opción 1 es la correcta. El tratamiento con relugolix + estradiol + acetato de noretisterona (Ryeqo) es una terapia oral combinada recientemente aprobada para mujeres con endometriosis sintomática moderada-severa, especialmente cuando ha habido falla del tratamiento con ACOs. Relugolix, un antagonista de GnRH, reduce los niveles de estrógenos para controlar la enfermedad, y su combinación con estrógenos y progestágenos evita los efectos adversos del hipostrogenismo (como pérdida de masa ósea o sofocos). Las guías de la SEGO y la ESHRE la consideran una opción médica válida de segunda línea antes de plantear intervenciones quirúrgicas, especialmente en mujeres sin deseo gestacional inmediato. La opción 2 es incorrecta porque la paciente tiene síntomas clínicos importantes (dismenorrea y dispareunia), lo que descarta una actitud expectante como manejo adecuado. La observación solo es razonable en casos asintomáticos o de endometriomas estables en perimenopáusicas. La opción 3 también es incorrecta. Cambiar de pauta continua a cíclica en ACOs no tiene fundamento, ya que la pauta continua es más efectiva para controlar el dolor. Si no ha funcionado el ACO en pauta continua, se debe escalar a otra opción terapéutica. La opción 4 (anexectomía laparoscópica) es una medida demasiado radical para este escenario. La paciente es joven, tiene un endometrioma pequeño, y aunque no desea más hijos, no ha agotado las opciones médicas disponibles. La anexectomía se reserva para casos refractarios, sospecha oncológica, o cuando existen masas complejas, persistentes, y la paciente acepta la pérdida ovárica. No es el siguiente paso tras fallo de ACOs. En caso de plantearse una opción quirúrgica tras fracasos de tratamientos médicos deberíamos plantearnos una quistectomía vía laparoscópica.

80. ¿En cuál de estos casos existe riesgo de isoinmunización antiRh?:

1. Madre B negativa y recién nacido B positivo.
2. Madre A positiva y recién nacido A negativo.
3. Madre O negativa y recién nacido B negativo.
4. Madre A negativa y recién nacido O negativo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre la isoinmunización antiRh. Existe riesgo de la misma cuando la madre es Rh negativo y el recién nacido Rh positivo (opción 1 correcta).

81. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre enfermedad y complicación clínica típica es correcta?:

1. Exantema súbito – anemia aplásica.
2. Rubeola – panencefalitis esclerosante subaguda.
3. Escarlatina – glomerulonefritis.
4. Sarampión – aneurismas coronarios.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre enfermedades exantemáticas. La asociación correcta es la de la respuesta 3. El exantema súbito se asocia a convulsiones febriles siendo la anemia aplásica típica del megaloblastemia (respuesta 1 falsa). La rubeola se asocia a artralgias y encefalitis, pero la panencefalitis esclerosante subaguda es típica del sarampión (respuesta 2 falsa). El sarampión además de a la panencefalitis esclerosante subaguda se asocia a sobreinfecciones como otitis media aguda y neumonía mientras que los aneurismas coronarios son típicos de la enfermedad de Kawasaki (respuesta 4 falsa).

82. ¿En cuál de los siguientes supuestos sería posible diagnosticar enfermedad celiaca sin necesidad de realizar biopsia?:

1. Mujer de 20 años con anemia ferropénica crónica y aftas orales que en estudio analítico presenta anticuerpos antitransglutaminasa elevados 30 veces el valor normal con inmunoglobulinas normales y anticuerpos antiendomiso positivos.
2. Niño de 2 años con clínica de estancamiento pondoestatural que en estudio analítico presenta déficit de IgA y anticuerpos anti-péptidos de gliadina positivos.
3. Niño de 8 años con síndrome de Down asintomático que en control analítico rutinario presenta anticuerpos antitransglutaminasa elevados 20 veces el valor normal con inmunoglobulinas normales y anticuerpos antiendomiso positivos.
4. Niña de 4 años con clínica de dolor abdominal y diarrea crónica que presenta HLA DQ2/DQ8 positivo con anticuerpos antitransglutaminasa elevados 5 veces el valor normal y anticuerpos antiendomiso positivos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Únicamente podemos diagnosticar de enfermedad celiaca sin biopsia a niños (opción 1 falsa) sin déficit de IgA (opción 2 falsa) que presentan anticuerpos antitransglutaminasa

> 10 veces el valor normal (opción 4 falsa) y anticuerpos antiendomisio positivos. Este diagnóstico se puede realizar en niños sintomáticos o asintomáticos a los que se somete a screening, salvo los pacientes con DM1 asintomáticos (opción 3 correcta).

83. Recién nacido pretérmino de 35+4 SEG. Peso recién nacido: 2200 g. Apgar 9/10. Bolsa rota prolongada y fiebre materna intraparto (38.5°C axilar). Cultivo vaginorrectal negativo. Se instauran controles de constantes en los que se objetiva a las 12 horas de vida taquicardia persistente a 180 lpm, así como decaimiento y rechazo parcial de las tomas. PCR en sangre de cordón 8 mg/dl (normal <2 mg/dl) e IL-6 elevada. ¿Cuál sería la actitud más adecuada en este momento?:

1. Mantener actitud expectante con monitorización de constantes en planta de maternidad.
2. Ingreso en Neonatología, extracción de hemograma y coagulación, recogida de urocultivo y hemocultivo y realización de punción lumbar si no hay contraindicación. Inicio de ampicilina y gentamicina intravenosos.
3. Ingreso en Neonatología, extracción de hemograma y coagulación, recogida de urocultivo y hemocultivo y realización de punción lumbar si no hay contraindicación. Inicio de fluconazol intravenoso.
4. La clínica puede ser debida a una hipoglucemia dado que se trata de un recién nacido pretérmino y bajo peso con escasa ingesta por lo que canalizaría acceso venoso e iniciaría perfusión con suero glucosado intravenoso.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una sospecha de sepsis neonatal precoz ya que se trata de un paciente con factores de riesgo (recién nacido pretérmino, bolsa rota prolongada y fiebre materna intraparto) con taquicardia persistente, decaimiento y rechazo de tomas junto con reactantes de fase aguda elevados. Lo más indicado sería extracción de pruebas complementarias (hemograma, bioquímica, coagulación, urocultivo, hemocultivo y punción lumbar) e inicio de antibioterapia intravenosa, de elección en estos casos ampicilina y gentamicina. El fluconazol no está indicado ya que no se sospecha infección fúngica.

84. Recién nacido pretérmino de 29 SEG ingresado en UCI Neonatal desde hace 4 días por enfermedad de membrana hialina. Se administró dosis de surfactante a su ingreso con mejoría posterior. Actualmente se encuentra ventilado con presión positiva continua (CPAP) con PEEP de 6 y FiO2 21%. Se ha avanzado progresivamente con la nutrición enteral con lactancia materna.

Inicia progresivamente cuadro de vómitos y distensión abdominal junto con empeoramiento respiratorio. ¿Qué sería lo más adecuado a continuación?:

1. Administraría nueva dosis de surfactante intratraqueal.
2. Iniciaría antibioterapia intravenosa con ampicilina y gentamicina.
3. Dejaría a dieta absoluta y solicitaría radiografía de abdomen.
4. Aumentaría FiO2 y mantendría actitud expectante por el momento.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ante un recién nacido pretérmino que presenta empeoramiento clínico junto con vómitos y distensión abdominal relacionados con el inicio o el aumento de la ingesta debemos sospechar una enterocolitis necrotizante. Ante esta sospecha, está indicado dejar a dieta absoluta y solicitar una radiografía de abdomen para confirmar la sospecha (respuesta 3 correcta). Si se confirma habrá que iniciar antibioterapia intravenosa (normalmente triple terapia antibiótica). La clínica no parece un empeoramiento de la membrana hialina (respuesta 1 y 4 falsas). Podría tratarse también de una sepsis, aunque el cuadro clínico es más típico de enterocolitis necrotizante y haríamos alguna prueba complementaria antes de iniciar antibioterapia (respuesta 2 falsa).

85. Sobre las nuevas terapias específicas de fibrosis quística, señale la respuesta correcta:

1. Se trata de fármacos que solo se pueden usar en combinación en formato de triple terapia.
2. La triple terapia solo está indicada en niños mayores de 12 años.
3. Se pueden usar actualmente en todos los pacientes, independientemente del tipo de mutación que presenten.
4. Son fármacos modificadores que actúan a nivel de CFTR bien corrigiéndola o bien potenciando su acción.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia sobre el tratamiento de la fibrosis quística, en concreto las nuevas terapias. Se trata de fármacos que tienen como diana la proteína CFTR corrigiéndola o potenciando su acción (respuesta 4 correcta). Estos fármacos se pueden usar en monoterapia, biterapia o triple terapia (respuesta 1 falsa). Recientemente se han aprobado nuevos usos de estos fármacos estando actualmente indicada la triple terapia en niños >2 años, la biterapia en algunos casos a partir del año y la monoterapia a partir de los 4 meses (respuesta 2 falsa). Desafortunadamente su uso depende del perfil de mutaciones de los pacientes siendo posible que en algunos casos no esté indicado el uso de estos fármacos (respuesta 3 falsa).

86. Niño de 12 meses de edad con antecedente de infección del tracto urinario (ITU) febril por E. Coli a los 8 meses de edad. En cistouretrografía miccional seriada (CUMS) se objetiva reflujo vesico-ureteral (RVU) grado III izquierdo. ¿Cuál sería la actitud más adecuada en este momento?:

1. Actitud expectante.
2. Iniciar profilaxis antibiótica.
3. Solicitar gammagrafía DMSA.
4. Solicitar gammagrafía DMSA e iniciar profilaxis antibiótica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre la actitud tras una ITU febril. Se trata de un varón de 12 meses que ha tenido un único episodio de ITU febril por germen típico con un RVU grado III. En este caso, no estaría indicada la profilaxis antibiótica ya que se indica en niños con RVU grados IV-V y niñas con RVU grados III-V o cuando haya ITUs de repetición (respuestas 2 y 4 falsas). Además, la gammagrafía DMSA no estaría indicada por el momento al tratarse de un episodio aislado de ITU febril típica con RVU que no se considera de alto grado y sin otras complicaciones (Respuesta 3 falsa).

87. ¿Cuál de los siguientes síntomas no esperaría encontrar en un cuadro de abstinencia por benzodiazepinas?:

1. Sudoración.
2. Contracciones musculares. Hipersensibilidad a la luz.
3. Hipersensibilidad a la luz.
4. Sedación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La sedación no es un síntoma propio de la abstinencia de benzodiazepinas, sino de su uso (respuesta 4 correcta). En el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas existen tanto síntomas psicológicos como ansiedad, irritabilidad o disforia; como síntomas fisiológicos como palpitaciones, sudoración, temblor o contracciones musculares (respuestas 1 y 2 incorrectas). También pueden aparecer otros trastornos como hipersensibilidad a la luz o sonidos, algas, gusto metálico o fenómenos de despersonalización (respuesta 3 incorrecta).

88. Mujer de 38 años que acude a consulta refiriendo elevado grado de ansiedad y preocupación ante la idea de padecer cáncer de mama desde que falleció una compañera de trabajo por esta enfermedad hace dos años. Su marido, que es quien ha insistido en que acudiera a un Psiquiatra, asegura que no para de revisarse y de realizar búsquedas en internet acerca de posibles signos o síntomas de enfermedad a

pesar de haberse realizado su examen anual recientemente, descartándose alguna alteración, manteniendo una excesiva preocupación que invade su vida diaria. En este caso, el diagnóstico más probable sería:

1. Trastorno obsesivo-compulsivo.
2. Trastorno por síntomas somáticos.
3. Trastorno de ansiedad por enfermedad.
4. Trastorno de adaptación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El Trastorno de ansiedad por enfermedad se caracteriza por una ansiedad y preocupación excesiva por tener o adquirir una enfermedad médica grave no diagnosticada, no apareciendo síntomas somáticos o, si están presentes, son sólo de intensidad leve. La evaluación completa de la paciente descarta afección médica que justifique las preocupaciones de la persona que sin embargo permanece ansiosa y realizando conductas como comprobaciones repetidas o búsquedas relacionadas con la enfermedad temida (respuesta 3 correcta). Debe realizarse diagnóstico diferencial con TOC, pero cabría encontrar obsesiones o compulsiones que impliquen otras preocupaciones además de los temores de contraer una enfermedad (respuesta 1 incorrecta). En el Trastorno por síntomas somáticos existen síntomas somáticos significativos, en contraste con el trastorno de ansiedad por enfermedad en el que si hay algún síntoma es mínimo, centrándose la preocupación en la idea de estar enfermos (respuesta 2 incorrecta). El hecho de mantener esa ansiedad y preocupación por un tiempo mayor de 6 meses, descartaría el diagnóstico de trastorno de adaptación (respuesta 4 incorrecta).

89. Un niño 3 años es llevado a consulta por sus padres por preocupación sobre su desarrollo. Mencionan falta de interés al interactuar con otros niños, retraso del lenguaje respecto a coetáneos y realiza algunas acciones peculiares como girar sobre sí mismo, ¿Cuál de los siguientes podría ser un indicio de un Trastorno del Espectro Autista (TEA)?:

1. Mantiene contacto visual cuando interactúa con otras personas.
2. Utiliza un cartón como si fuese un barco pirata.
3. Juega solo mostrando interés por alinear objetos de manera repetitiva.
4. Imita acciones de las personas de su alrededor como hablar por teléfono o aplaudir cuando otros aplauden.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre hitos del desarrollo e indicio de autismo. El juego simbólico (respuesta 2 y 4) y el contacto visual (respuesta 1) son aspectos del desarrollo típicamente observados en niños de 3 años. En contraste, alinear objetos es una conducta repetitiva que es frecuente en niños con trastorno del espectro autista.

90. Paciente de 25 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ha sufrido varias hospitalizaciones en las que se han ensayado más de tres líneas de tratamiento a dosis y tiempo adecuadas. La opción terapéutica más adecuada sería:

1. Clozapina.
2. Fármacos depot.
3. Amisulpiride
4. Aripiprazol.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan el caso clínico típico de un trastorno esquizofrenico resistente a tratamiento (dos o mas tratamientos a dosis y tiempo adecuados) por lo que el tratamiento de elección sería la clozapina. Si nos dieran como opción la terapia electroconvulsiva también podría ser una opción adecuada pero no esta entre las opciones.

91. Ante un paciente diagnosticado de trastorno bipolar con ciclación rápida y que actualmente se encuentra en fase depresiva, ¿cuál de los siguientes tratamientos le parecería más recomendable utilizar?:

1. Venlafaxina.
2. Carbonato de litio.
3. Carbamazepina.
4. Clonazepam.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta acerca de pacientes con trastorno bipolar con ciclación rápida. Recuerda que son resistentes a tratamiento con litio (respuesta 2 incorrecta), siendo más adecuado cualquier otro estabilizador de ánimo, como la carbamazepina (respuesta 3 correcta). El uso de antidepresivos como la venlafaxina podría inducir un viraje maniaco por lo que se desaconseja su uso (respuesta 1 incorrecta). En este caso no tendría sentido usar el clonazepam (respuesta 4 incorrecta).

92. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta acerca del uso de esketamina en el tratamiento de la depresión?

1. La vía de administración es oral.
2. Habitualmente se utiliza en combinación con un antidepresivo oral.
3. Actúa como antagonista del receptor N-metil-Aspartato (NMDA) que modula la actividad de serotonina, neurotransmisor clave en la depresión.
4. La esketamina es un tratamiento de primera línea para la depresión mayor.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La esketamina es un fármaco de reciente aparición en Espa-

ña. Se trata de un antagonista no selectivo y no competitivo del receptor de N-metil-D-Aspartato (NMDA), un receptor inotrópico de glutamato (Respuesta 3 falsa). Tiene indicación en tratamiento de depresión resistente, es decir, aquella en la que no hay respuesta a al menos dos tratamientos con diferentes antidepresivos, en episodio depresivo grave o moderado (Respuesta 4 falsa). La vía de administración es nasal, a través de un pulverizador (respuesta 1 falsa). Habitualmente se utiliza en combinación con tratamiento antidepresivo oral (Respuesta 2 correcta)

93. Ante un paciente mayor sin antecedentes psiquiátricos relevantes y que comienza con sintomatología alucinatoria aguda y alteraciones del comportamiento debemos:

1. Prescribir benzodiacepinas ya que se trata de un cuadro de ansiedad.
2. Derivar a neurología dado que se trata de una demencia rápidamente progresiva.
3. Filiar el posible origen del cuadro para tratarlo e iniciar haloperidol a dosis bajas.
4. Indicar medidas de contención mecánica y pautar benzodiacepinas hasta que se resuelvan las alteraciones de conducta.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clásica del MIR, el famoso síndrome confusional agudo. Cuando en un paciente añoso sin antecedentes psiquiátricos comienza de forma abrupta con un cuadro psicopatológico alucinatorio, confusional y con alteraciones de conducta debemos de sospechar la existencia de un cuadro confusional. Recordar que el tratamiento es el de la causa más un neuroléptico a dosis bajas. Evitar las benzodiacepinas salvo en aquellos casos en los que las mismas sean tratamiento de la causa (abstinencia a benzodiacepinas o abstinencia a alcohol) dado que empeorarían el cuadro.

94. Señala la respuesta correcta en relación al Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH):

1. El metilfenidato, la lisdexanfetamina y la atomoxetina, son tratamientos indicados en estos pacientes.
2. Las benzodiacepinas suelen utilizarse como sedantes o tranquilizantes, con buena respuesta.
3. Es más frecuente en mujeres.
4. Existe una hiperfunción dopaminérgica frontotálámica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Recuerda que las benzodiacepinas y sedantes no se deben utilizar en pacientes con TDAH, empeorando la sintomatología (respuesta 2 incorrecta). Son tratamientos indicados en TDAH el metilfenidato, la lisdexanfetamina y la atomoxetina (respuestas 1 correcta). Se trata de un trastorno que se da más frecuentemente en varones (respuesta 3 incorrecta). Las personas con el TDAH pueden tener menores niveles de do-

pamina, sustancia implicada en la atención y la motivación (respuesta 4 incorrecta).

95. Un paciente presenta debilidad y espasticidad en el lado derecho de su cuerpo, junto con pérdida de la sensación de dolor y temperatura en el lado izquierdo del cuerpo por debajo de un cierto nivel. ¿Qué combinación de vías nerviosas sugiere esto que está afectada unilateralmente a nivel de la médula espinal o tronco encefálico bajo?

1. Tracto corticoespinal ipsilateral y vía espinotalámica contralateral.
2. Vía espinotalámica ipsilateral y cordones posteriores contralaterales.
3. Tracto corticoespinal contralateral y cordones posteriores ipsilaterales.
4. a espinotalámica contralateral y segunda motoneurona ipsilateral.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El cuadro clínico descrito, con debilidad y espasticidad en el lado derecho del cuerpo (signos de afectación de neurona motora superior) junto con pérdida de la sensación de dolor y temperatura en el lado izquierdo del cuerpo por debajo de un nivel, es característico de un síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Sequard. Este síndrome se produce por una lesión unilateral de la médula espinal o del tronco encefálico bajo. Las fuentes indican que en el síndrome de Brown-Sequard se afectan las siguientes vías principales en el lado de la lesión: * El tracto corticoespinal (o haz piramidal), que desciende ipsilateralmente en la médula espinal después de decusar a nivel del bulbo. Su lesión causa debilidad espástica ipsilateral. * La vía espinotalámica lateral, que transporta la sensibilidad termoalgésica. Las fibras de esta vía decusan a nivel medular poco después de entrar, por lo que una lesión unilateral de la vía espinotalámica afecta las fibras que provienen del lado opuesto del cuerpo, causando pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica contralateral. Considerando una lesión en el lado derecho de la médula espinal se afectaría tanto el tracto corticoespinal derecho (ipsilateral a la lesión), causando debilidad y espasticidad en el lado derecho (ipsilateral a la lesión) como la vía espinotalámica derecha (ipsilateral a la lesión), la cual lleva información del lado izquierdo (contralateral) después de que las fibras decusaran en dicho nivel medular. Esto causaría pérdida de sensación de dolor y temperatura en el lado izquierdo (contralateral a la lesión).

96. Acude a consultas un paciente de 35 años profesor de surf y sin antecedentes de interés. Refiere cuadro de años de evolución de cervicobraquialgia bilateral que asocia desde hace 5 semanas alteración de la marcha con múltiples tropiezos y comenta además episodios de incontinencia urinaria. A la exploración se observa reflejo de Hoffman bilateral con exaltación de reflejos rotulianos y aquileos y

reflejo cutáneo plantar extensor bilateral con clonus aquileo. No asocia déficit motor. Respecto al cuadro descrito señale la opción incorrecta:

1. Se encuentra indicado realizar una resonancia magnética cervical para valorar la presencia de mielopatía.
2. Puede estar indicado realizar una discectomía cervical anterior y fusión intersomática.
3. Hay que instaurar tratamiento urgente con metilprednisolona 1g/24h.
4. Los estudios de conducción nerviosa podrían mostrar un retraso de la conducción de potenciales evocados motores.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se describe un cuadro de mielopatía cervical típico con uno de los antecedentes clásicos, la mielopatía del surfista. En estos deportistas la extensión cervical forzada conduce a una degeneración acelerada a nivel cervical que condiciona el desarrollo de un cuadro de estenosis cervical con mielopatía. El cuadro descrito con cervicobraquialgia por los cambios espondilóticos y compresión radicular. La alteración de la marcha encuentra un origen sensitivo por compresión de los cordones posteriores pero también podría ser secundaria a un posible déficit motor (no presente en este paciente). Respecto a los reflejos presentan habitualmente signos claros de primera motoneurona. En estos casos claramente está indicada una RMN cervical para confirmar la presencia de alteración de señal medular que confirme una mielopatía (respuesta 1 correcta) así como un estudio de conducción que mostraría un retraso tanto en los potenciales evocados motores y sensitivos (respuesta 4 correcta). El tratamiento, especialmente en cuadros de 3 niveles o menos suele ser por una vía de abordaje anterior (opción 2 correcta) para realizar una discectomía e implantar una caja intersomática que favorezca la fusión. El tratamiento con megabolos de corticoides no se encuentra indicado en esta patología (opción 3 incorrecta).

97. Lactante de 14 meses en estudio por retraso psicomotor. A la exploración se objetivan 8 manchas hipomelánicas “en hoja de fresno” y múltiples adenomas sebáceos. Los padres refieren múltiples episodios de espasmos. Respecto a la patología descrita, elija la opción correcta:

1. Un criterio diagnóstico es la presencia de neurinomas del acústico bilateral.
2. Además de las manchas hipomelánicas, desarrollan manchas café con leche, mostrando una alternancia característica entre ambos tipos de lesiones.
3. Es un enfermedad no hereditaria.
4. El tratamiento con everolimus es útil en el manejo de los astrocitomas subependimarios gigantocelulares.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

El cuadro descrito con manchas hipomelánicas, retraso psicomotor y espasmos debe orientarnos hacia una esclerosis tuberosa. La opción 1 nos habla de neurinomas del acústico bilaterales, cuya presencia es un criterio diagnóstico de la neurofibromatosis tipo 2 (opción 1 falsa). En esta enfermedad no se desarrollan manchas café con leche, sino que estas son típicas de otras como la neurofibromatosis tipo 1 (opción 2 falsa). Se trata de una enfermedad hereditaria por mutación de genes que codifican para las tuberinas (opción 3 falsa) (hay que recordar que la única no hereditaria es el síndrome de Sturge Weber). Por último, el tratamiento con inhibidores de m-TOR (everolimus) muestra excelentes resultados con disminución del volumen de los astrocitomas subependimarios de células gigantes, siendo una nueva opción a recordar en su manejo (opción 4 correcta).

98. Señale la correcta en relación con el temblor esencial:

1. El temblor es de reposo, más que intencional, más que postural.
2. El DAT SCAN alterado lo diferencia del temblor farmacológico.
3. Es fácil de diferenciar del temblor fisiológico exacerbado.
4. Para casos graves es útil el ultrasonido focal de alta intensidad generalmente en el núcleo ventral intermedio del tálamo.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

El temblor esencial es de acción, no de reposo, lo que puede dificultar la diferenciación con el temblor farmacológico o fisiológico exacerbado, el DAT SCAN es normal, la D es correcta.

99. ¿Cuál de las siguientes presentaciones clínicas es más sugestiva de NMO?

1. Episodios de debilidad en diferentes partes del cuerpo separados en el tiempo y espacio.
2. Brote único de neuritis óptica unilateral y mielitis transversa corta.
3. Brote de neuritis óptica grave y/o mielitis longitudinalmente extensa que tiende a recurrir.
4. Síntomas cognitivos progresivos con atrofia cerebral difusa.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

La pregunta busca la presentación clínica más sugestiva de Neuromielitis Óptica (NMO). La NMO se diferencia de la Esclerosis Múltiple en que no tiene una fase progresiva, pero los brotes clínicos son más graves. Estos brotes típicamente incluyen: * Neuritis óptica severa, a menudo bilateral (simultánea o secuencial), que puede ser recurrente. * Mielitis longitudinalmente extensa, afectando a ≥ 3 cuerpos verte-

brales, con importante repercusión motora. * También puede haber un síndrome de área postrema con vómitos e hipo incoercible. La opción 3 describe precisamente un "Brote de neuritis óptica grave y/o mielitis longitudinalmente extensa que tiende a recurrir", lo cual concuerda directamente con las características distintivas de la NMO mencionadas, resaltando la gravedad y la extensión de las lesiones, así como la naturaleza recurrente de los episodios graves.

100. Respecto al síndrome de Guillain-Barré, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Es una polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante aguda.
2. Puede asociarse a infección previa por *Campylobacter jejuni*.
3. La debilidad suele predominar en las extremidades superiores al inicio.
4. El tratamiento incluye inmunoglobulinas intravenosas o plasmaféresis.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por una debilidad simétrica ascendente que típicamente comienza habitualmente en las extremidades inferiores. Por tanto, afirmar que predomina inicialmente en las extremidades superiores es incorrecto (opción 4, falsa y por tanto la que hay que marcar). El resto de las afirmaciones son ciertas: se trata de una polirradiculoneuropatía desmielinizante, frecuentemente precedida por infecciones (como *Campylobacter jejuni*), y su tratamiento se basa en inmunoglobulinas o plasmaféresis.

101. Una mujer de 68 años acude a consulta por alteraciones progresivas de la memoria desde hace 2 años. Su marido refiere que la paciente ha empezado a tener dificultades para recordar citas importantes, repetir preguntas, y perder objetos personales. En la exploración destaca desorientación temporal, dificultad para recordar tres palabras tras 5 minutos y un test del reloj anómalo. No hay alteraciones motoras ni signos extrapiramidales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Demencia con cuerpos de Lewy.
2. Demencia frontotemporal.
3. Enfermedad de Alzheimer.
4. Deterioro cognitivo vascular.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El patrón clínico descrito, con alteraciones progresivas de memoria episódica, desorientación temporal y errores en el test del reloj, sin signos extrapiramidales ni síntomas conductuales prominentes en fases iniciales, es altamente sugestivo de enfermedad de Alzheimer. La demencia frontotemporal suele debutar con alteraciones conductuales o del

lenguaje, la demencia con cuerpos de Lewy incluye alucinaciones visuales y fluctuaciones cognitivas, y el deterioro vascular suele tener un inicio más brusco o escalonado.

102. Respecto al diagnóstico de muerte encefálica en adultos, señale la afirmación INCORRECTA:

1. La prueba de apnea debe realizarse asegurando una PaCO_2 superior a 60 mmHg.
2. La temperatura corporal debe ser superior a 36 °C antes de iniciar el protocolo de diagnóstico.
3. La administración de sedantes no contraindica inmediatamente la evaluación clínica.
4. Si la exploración clínica no es concluyente, pueden emplearse pruebas complementarias como el doppler transcraneal o el electroencefalograma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La administración reciente de sedantes sí contraindica la evaluación clínica de muerte encefálica hasta que se haya demostrado su eliminación (en función de la vida media del fármaco y función hepatorenal). La prueba de apnea debe alcanzar un $\text{PaCO}_2 > 60$ mmHg para ser válida. La temperatura debe ser superior a 36 °C, y si la exploración no es concluyente, se permiten técnicas complementarias como doppler transcraneal, arteriografía cerebral o EEG.

103. Varón de 38 años con cirugía de apendicitis hace 4 años, sin otros antecedentes, trabaja de informático, sufre mientras está realizando una mudanza un cuadro de afasia motora y hemiparesia derecha de 2 horas de duración. En la RM se identifica una lesión isquémica aguda cortical. El ecocardiograma muestra FOP con aneurisma de septo. Señale la correcta a continuación.

1. El estudio etiológico se ha completado.
2. Debe recibir anticoagulación a largo plazo como prevención secundaria.
3. El tratamiento es el cierre del foramen oval permeable.
4. La doble antiagregación es igual de efectiva y segura que el cierre de FOP.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

pregunta sencilla sobre el manejo de un ictus cardioembólico por FOP, la primera respuesta es falsa porque siempre hay que hacer un estudio de troncos supraaórticos para descartar otras etiologías, la segunda es falsa porque a pesar de que la anticoagulación es un tratamiento posible, en pacientes jóvenes sin otras causas de cardioembolia el cierre se considera de elección.

104. Un varón de 40 años consulta por episodios diarios de dolor de cabeza intenso, estrictamente unilateral, localizado en la región periorbitaria

y temporal. Estos episodios son de muy corta duración, de unos 10-15 minutos, y ocurren varias veces al día, alternando con periodos completamente asintomáticos entre crisis. El dolor se asocia a congestión nasal y lagrimeo del mismo lado de la cefalea. El paciente menciona que ha probado diversos analgésicos sin alivio significativo, pero una vez recibió un tratamiento que le hizo desaparecer el dolor por completo. ¿Cuál es el diagnóstico de cefalea primaria más probable y a qué tratamiento específico suele ser invariable la respuesta?

1. Cefalea en racimos; respuesta invariable a triptanes.
2. Hemicránea paroxística; respuesta invariable a la indometacina.
3. Cefalea tensional; respuesta invariable a relajantes musculares.
4. Hemicránea continua; respuesta invariable a corticoides.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La Hemicránea paroxística se caracteriza precisamente por episodios de dolor intenso, estrictamente unilateral, de corta duración (menos de 30 minutos, mencionando específicamente 10-15 minutos en un caso similar) y alta frecuencia diaria (al menos 5 episodios al día), acompañados de síntomas trigémino-autónómicos como lagrimeo, inyección conjuntival, congestión nasal o rinorrea en el mismo lado del dolor. Un rasgo distintivo y definitorio de la Hemicránea paroxística es su respuesta espectacular e invariable a la indometacina.

105. Varón de 65 años, sin antecedentes relevantes, acude por masa indolora submandibular izquierda de crecimiento lento en los últimos meses. Se acompaña de leve xerostomía y molestias al tragar, sin fiebre ni síntomas generales. En la exploración física presenta una masa firme no adherida a planos profundos. La analítica muestra IgG total elevada, con IgG4 sérica de 2.200 mg/dL (normal <135). ANA, AntiRo y AntiLa negativos. Se realiza biopsia de la glándula afectada que muestra infiltrado linfoplasmocitario denso, fibrosis en patrón "en torbellino" (storiforme) y obliteración de vasos venulares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Sarcoidosis.
2. Linfoma no Hodgkin tipo MALT.
3. Sialodinitis crónica inespecífica.
4. Enfermedad relacionada con IgG4.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La enfermedad relacionada con IgG4 es una entidad fibroinflamatoria sistémica que puede afectar múltiples órganos,

entre ellos las glándulas salivales, y suele presentarse como una masa tumoral indolora, a menudo confundida con procesos neoplásicos o autoinmunes. La anatomía patológica es clave para el diagnóstico: se caracteriza por un infiltrado linfoplasmocitario denso rico en células plasmáticas IgG4+, fibrosis con patrón storiforme (en torbellino) y flebitis obliterante. En este caso, la elevación marcada de IgG4 sérica y los hallazgos histológicos orientan con claridad hacia esta enfermedad. El diagnóstico diferencial incluye el síndrome de Sjögren, que también afecta glándulas salivales, pero suele acompañarse de autoanticuerpos (anti-Ro/SSA y anti-La/SSB), síntomas más marcados de xerostomía y xeroftalmía, y no presenta fibrosis storiforme ni flebitis obliterante. La sarcoidosis muestra granulomas no caseificantes, el linfoma MALT presenta atipia linfocitaria y monoclonalidad, y la sialoadenitis crónica inespecífica carece de las características histológicas específicas de la enfermedad por IgG4. Por tanto, la opción 4 es la correcta.

106. Una mujer de 28 años acude a consulta por astenia, fiebre vespertina, artralgias en pequeñas articulaciones de las manos y una erupción eritematosa en alas de mariposa que empeora con la exposición solar. En la analítica destacan anemia normocítica, leucopenia y proteinuria en rango no nefrótico. ¿Cuál de los siguientes hallazgos serológicos sería más característico para confirmar el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico?:

1. Anticuerpos anti-Ro (SSA) positivos
2. Anticuerpos anti-mitocondriales (AMA) positivos.
3. Anticuerpos anti-DNA de doble cadena (anti-dsDNA) positivos
4. Anticuerpos anti-DNA de cadena simple (anti-ssDNA) positivos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el caso descrito, altamente sugestivo de lupus eritematoso, los anticuerpos anti-DNAs son los que más reforzarían la sospecha diagnóstica, dada su mayor especificidad respecto a las otras opciones (anti-Ro, aunque posibles en el LES, se correlacionan también con otras enfermedades autoinmunes, como el Sjögren). Los anticuerpos anti-DNA, aunque frecuentes en lupus, son menos específicos. Los antimitocondriales sugieren colangitis biliar primaria aunque también están presentes en una proporción notable de casos de Sjögren.

107. Mujer de 55 años sin antecedentes de interés. Acude por tumefacción y dolor en rodilla derecha limitante de un mes de evolución; refiere que desde hace 5 años notaba deformidad progresiva y episodios de dolor en interfalángicas proximales y distales de las manos, siendo diagnosticada de artrosis, pero en el último año se ha hecho el dolor más intenso, con enrojecimiento y

tumefacción francos de dichas articulaciones y asociando tumefacción en metacarpofalángicas. En análisis presenta proteína C reactiva, ANA, Factor reumatoide y anti-CCP negativos. Preguntando por antecedentes familiares nos refiere hermana con psoriasis. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable?:

1. Artritis por depósito de pirofosfato cálcico.
2. Artritis reumatoide seronegativa.
3. Artrosis generalizada o poliartritis.
4. Artritis psoriásica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico en el que tenemos que hacer un diagnóstico diferencial donde el patrón articular es clave; aunque acude por una gonartrosis se trata de una mujer relativamente joven para una artritis por pirofosfato cálcico, y aunque ésta puede producir una pseudo-AR con afectación de metacarpofalángicas, no se afectan las interfalángicas distales (respuesta 1 incorrecta). Esta misma razón, la afectación de interfalángicas distales, sumado a la ausencia de FR y CCP, hace muy improbable que se trate de una artritis reumatoide (respuesta 2 incorrecta). Por último tampoco podríamos hablar de una artrosis exclusivamente ya que, aunque la paciente comenzó hacia años con lo que parece que es una artrosis nodular, ahora se sobreañade otra patología que explica la tumefacción en metacarpofalángicas (respuesta 3 incorrecta). En este caso esa patología es una artritis psoriásica, ya que nos hablan de tumefacción de MCF e IFD en una paciente con AF de primer grado de psoriasis (respuesta 4 correcta)

108. Varón de 82 años institucionalizado en una residencia que refiere dolor óseo generalizado de varios meses de evolución, principalmente en región lumbar y caderas, con dificultad progresiva para la deambulación. Apenas sale al exterior. En la exploración destaca debilidad muscular proximal y dolor a la palpación ósea. Entre los datos analíticos destacan: calcio 8,5 mg/dl (rango laboratorio 8,5-10,9mg/dL), fósforo 2,1 mg/dl (2,5-4,5mg/dl), fosfatasa alcalina 340 UI/L (53-128 UI/L), 25-hidroxivitamina D 8 ng/ml(20-50ng/mL), CPK 100 UI/L (32-294UI/L) La radiografía muestra disminución generalizada de la densidad mineral ósea y bandas radiolúcidas perpendiculares a la cortical, de 2-5 mm de ancho, en pelvis. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Osteomalacia por déficit de vitamina D.
2. Metástasis óseas.
3. Enfermedad de Paget ósea.
4. Polimialgia reumática.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ante un paciente de edad avanzada con dolor óseo gene-

ralizado hay que plantear varios diagnósticos diferenciales. La clave del caso nos la da la analítica, con la pista de que está institucionalizado y apenas sale a la calle. Encontramos una vitamina D muy baja, en rango osteomalácico (<10ng/mL) junto con una fosfatasa alcalina elevada (esto es muy sugestivo de osteomalacia por déficit de vitamina D, que es la causa más frecuente de osteomalacia). El calcio en estos casos puede estar normal o disminuido. La clínica puede simular una polimialgia reumática, pero con estos niveles de vitamina D lo primero que tenemos que hacer es reponerlo y veremos como la clínica mejora. La enfermedad de Paget no suele ser sintomática y de serlo suele ser en zonas localizadas y aunque se caracteriza por elevación de fosfatasa alcalina no se alteran otros parámetros analíticos, además de hallazgos radiográficos característicos (lesiones líticas, escleróticas), no disminución de densidad ósea ni líneas de Looser-Milkman (las bandas radiolúcidas a las que nos hace referencia). En el caso de las metástasis óseas suelen presentar focos de dolor localizados, lesiones líticas o blásticas en radiografía.

109. Una paciente de 38 años consulta por entumecimiento y tirantez cutánea que se inició en los dedos de ambas manos hace aproximadamente un año, asociando ya desde entonces crisis de palidez digital con el frío (le enseña fotos). El endurecimiento cutáneo está progresando proximalmente y ya la sitúa en la totalidad de los brazos, área cervical y tercio superior del tórax. La paciente dice haber tenido febrícula ocasional en este tiempo, se atraganta de vez en cuando, especialmente con los sólidos, ha perdido unos 5 kg de peso en el último trimestre y muestra intolerancia al esfuerzo y dolor articular de ritmo inflamatorio en carpos y ambas muñecas. En el panel de autoinmunidad se demuestra la presencia de anti-RNA polimerasa III. Respecto a la enfermedad que usted sospecha, indique lo correcto:

1. La paciente seguramente desarrollará una forma cutánea limitada.
2. El marcador analítico es de bajo riesgo para crisis renal.
3. Es muy probable el desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial a lo largo de la evolución clínica.
4. El anticuerpo circulante se ha relacionado con una mayor probabilidad de neoplasia asociada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Estamos ante un caso de esclerodermia anti-RNA polimerasa III positiva, por lo que lo esperable es que se desarrolle una forma cutánea difusa en el que algunos compromisos, como el cutáneo, lleguen a ser graves. Este marcador se ha relacionado tanto con un mayor riesgo de crisis renal como de neoplasia subyacente. Aunque la EPID es posible, es un compromiso más relacionado con otros anticuerpos, como anti-Scl70 (anti-topoisomerasa) o anti-PM/Scl.

110. Mujer de 38 años que consulta por debilidad muscular proximal de 3 meses de evolución, artralgiás en manos y rodillas, y fenómeno de Raynaud. En la exploración presenta artritis de 3° MCF bilateral, 2° MCF derecha y 4° IFP izquierda, hiperqueratosis, fisuras e hiperpigmentación en el borde radial de 2° dedo bilateral, así como crepitantes secos bibasales en la auscultación pulmonar. En las pruebas complementarias destaca: CPK 850 U/L, LDH elevada, patrón en vidrio deslustrado pulmonar bilateral en la TACAR. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Dermatomiositis.
2. Polimiositis.
3. Síndrome antisintetasa.
4. Miopatía necrotizante inmunomediada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos muestran un caso típico de síndrome antisintetasa con la tríada característica: miopatía, EPID y artritis, junto con manifestaciones típicas como manos de mecánico y fenómeno de Raynaud. El síndrome antisintetasa se asocia con anticuerpos antisintetasa, siendo el más frecuente el anticuerpos anti-Jo1.

111. Una mujer de 75 años acude a urgencias por clínica de cefalea bitemporal persistente desde hace dos semanas, claudicación mandibular, febrícula y visión borrosa en el ojo izquierdo. En la exploración se palpa una arteria temporal izquierda endurecida y dolorosa. La analítica muestra VSG de 96 mm/h y PCR de 13 mg/dL. Se inicia tratamiento bolos intravenosos de metilprednisolona 1g durante 3 días. Se realiza una ecografía Doppler Color de las arterias temporales, que muestra un signo del halo hipoeoico alrededor de la luz vascular en todas las ramas de las arterias temporales. Tras una mejoría inicial, al disminuir la dosis de corticoides, la paciente presenta recaída clínica y aumento de reactantes. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más indicado en este contexto?:

1. Infliximab.
2. Rituximab.
3. Etanercept.
4. Upadacitinib.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Upadacitinib es un inhibidor selectivo de JAK1 que ha sido recientemente aprobado para el tratamiento de la arteritis de células gigantes, especialmente en pacientes que presentan recaídas o dependencia de corticoides. Ha mostrado eficacia en la reducción de brotes y en el mantenimiento de la remisión. A diferencia de otros biológicos como infliximab, rituximab o etanercept, que no han demostrado beneficios con-

sistentes en ACG, upadacitinib ofrece una alternativa eficaz junto a tocilizumab en pacientes con enfermedad refractaria o corticodependiente.

112. Con respecto al tratamiento de la artritis reumatoide, señale la incorrecta:

1. Si el paciente no tolera ningún FAME sintético convencional, se recomienda el uso de fármacos como tocilizumab o tofacitinib.
2. Si se produce ineficacia a dos anti-TNF, hay que probar un tercer anti-TNF.
3. Los inhibidores de la tirosin kinasa son una opción en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa asociada en caso de ineficacia a abatacept y rituximab.
4. En caso de que el paciente tenga antecedente de neoplasia, hay que esperar a que esté cinco años en remisión para poder poner un FAME biológico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta compleja de manejo de artritis reumatoide; en los casos en los que el paciente vaya a recibir una terapia compleja en monoterapia, efectivamente es preferible el uso de inhibidores de la interleukina 6 o inhibidores de la janus kinasa, ya que han demostrado una mayor eficacia en este contexto que los anti-TNF, el rituximab o el abatacept en monoterapia (respuesta 1 correcta). Por otro lado, si el paciente ha tenido fallo a dos anti-TNF, es muy probable que fracase a un tercero, por lo que se recomienda cambiar a un biológico con distinto mecanismo de acción o a un inhibidor JAK (respuesta 2 incorrecta). Con respecto a la evidencia de uso de terapias complejas en artritis reumatoide y EPID, los que han demostrado una mayor seguridad han sido abatacept y rituximab, lo que los convierte en primera elección, pero ya existen datos que avalan la seguridad de tocilizumab e inhibidores JAK, por lo que podrían ser una alternativa. Finalmente, el abordaje de los pacientes oncológicos ha cambiado en las últimas guías europeas y españolas dado que no se han observado mayores recurrencias de cáncer en pacientes con anti TNF, rituximab o tocilizumab (por lo que se prefiere a estas terapias complejas antes que abatacept o inhibidores JAK), por tanto no es necesario esperar un tiempo concreto de remisión del cancer, recomendándose individualizar cada caso según el tipo de neoplasia y su extensión así como del estado de actividad de la AR.

113. Mujer de 26 años que acude por cuadros repetidos de aproximadamente 10 días de evolución de fiebre intermitente de hasta 40°C junto con maculas eritematosas en el tronco y artralgias en carpos, rodillas y tobillos. A la exploración física se palpan adenopatías cervicales. Se dispone de análisis de una visita que hizo a urgencias por este motivo donde se objetiva PCR de 25mg/dL, 186.000 plaquetas y fibrinógeno en 630mg/dL, sin alteraciones en el

perfil renal ni hepática. Ante el diagnóstico de sospecha indique la respuesta incorrecta:

1. La determinación de la calprotectina sérica y/o la interleukina 18 pueden ser útiles para el diagnóstico.
2. Fármacos como tocilizumab o canakinumab han demostrado disminuir el uso de corticoides y altas tasa de remisión libre de fármaco.
3. El tratamiento de elección es la corticoterapia.
4. Puede producirse como complicación una enfermedad pulmonar intersticial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad elevada que requiere haber estudiado en profundidad el tema de la enfermedad en cuestión; nos presentan un caso sugestivo de enfermedad de Still del adulto en una mujer con la triada clásica de fiebre alta en agujas, exantema macular y artralgias (que suelen ser tal y como se describe en grandes articulaciones) y aumento de reactantes de fase aguda y trombocitosis reactiva. Además refiere adenopatías, que junto con la hepatoesplenomegalia son hallazgos frecuentes. Dado que los análisis son de urgencias no tienen determinada la ferritina, que habría sido de gran utilidad para orientar el diagnóstico. Aunque no están disponibles en todos los hospitales, en algunos terciarios podemos realizar la determinación de proteínas s100 como la calprotectina sérica o de la interleukina 18, que tienen una alta sensibilidad y especificidad para esta enfermedad (respuesta 1 correcta). Aunque la complicación pulmonar más frecuente sea la pleuritis, pueden producirse casos de afectación pulmonar intersticial, por lo que en caso de tos o disnea habría que hacer cribado con radiografía de tórax y pruebas de función respiratoria (respuesta 4 correcta). Por último, según las últimas guías europeas de 2024, dados los buenos resultados con inhibidores de la IL-1 y la IL-6, los glucocorticoides no son la piedra angular de tratamiento, recomendándose desde el momento que se realiza el diagnóstico la introducción de tocilizumab, canakinumab, anakinra o rilonacept, y quedando relegados los corticoides a una terapia concomitante en casos graves o con control parcial (respuesta 2 correcta, 3 incorrecta)

114. En relación con la biopsia de lesiones musculoesqueléticas sospechosas de malignidad, señale la opción incorrecta:

1. Debe planificarse considerando el abordaje quirúrgico definitivo.
2. La biopsia incisional puede ser necesaria cuando la biopsia con trocar resulta no diagnóstica.
3. De forma preferente debe realizarse en un plano intermuscular.
4. La PAAF tiene menos rendimiento diagnóstico que la BAG (con trocar).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La biopsia no debe realizarse en un plano intermuscular dado que eso contaminaría AMBOS compartimentos. Debe realizarse atravesando el menor número de compartimentos y tejidos posibles y considerando el abordaje quirúrgico definitivo, resecando además la cicatriz de la biopsia. La biopsia con trocar proporciona más material para análisis histológico que la PAAF. La biopsia incisional es un recurso que se reserva cuando la biopsia con trocar no es diagnóstica.

115. Un paciente de 47 años sufrió una fractura de radio distal tratada de forma conservadora con un yeso, ya retirado hace 1 mes y en seguimiento. Mueve favorablemente la muñeca pero adelanta cita de revisión por dolor y limitación en el hombro derecho desde hace unos 2 meses de evolución, pero que no lo había acusado hasta no retirar el cabestrillo ya que estaba concentrado con la muñeca. Refiere que el dolor aumenta por la noche, no recuerda traumatismo ahí, y cada vez tiene más dificultad para peinarse o vestirse. A la exploración presenta limitación tanto activa como pasiva en todas las direcciones, especialmente en rotación externa (20°) y abducción (70°). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Rotura del manguito rotador.
2. Tendinopatía calcificante.
3. Capsulitis adhesiva.
4. Artrosis glenohumeral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media sobre diagnóstico diferencial de patología de hombro. La capsulitis adhesiva o “hombro congelado” se caracteriza por limitación global del rango de movimiento tanto activo como pasivo (a diferencia de la patología del manguito rotador donde la limitación es fundamentalmente activa con rango pasivo preservado). Es más frecuente en diabéticos, y a veces puede verse relacionado con un periodo de reposo importante (cabestrillo). Cursa con dolor progresivo, de predominio nocturno, sin traumatismo previo. La limitación afecta a todos los arcos de movimiento, siendo más marcada en las rotaciones. El cuadro típicamente evoluciona en fases (dolor, rigidez y recuperación). La rotura del manguito rotador (opción 1) presenta limitación fundamentalmente de la movilidad activa pero no de la pasiva. La tendinopatía calcificante (opción 2) suele presentar episodios más agudos de dolor. La artrosis glenohumeral (opción 4) es menos frecuente, afecta generalmente a pacientes más mayores y suele mostrar crepitación.

116. Niño de 8 años que acude a consulta por deformidad progresiva en el pie izquierdo. Los padres refieren que el niño comenzó a caminar con normalidad, pero en los últimos 2 años han notado que arrastra la punta del pie al caminar y tropieza con frecuencia. A la exploración se

observa pie cavo con garra de los dedos, atrofia de musculatura peronea y debilidad para la eversion del pie. Presenta además disminución de la sensibilidad en territorio del nervio peroneo. No hay antecedentes traumáticos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth.
2. Parálisis cerebral infantil.
3. Secuelas de poliomielitis.
4. Siringomielia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El cuadro descrito es altamente sugestivo de enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) o neuropatía hereditaria sensitivo-motora. Esta enfermedad neuromuscular hereditaria se caracteriza por una degeneración progresiva de los nervios periféricos que produce debilidad muscular distal, atrofia y alteraciones sensitivas. Los hallazgos típicos incluyen: pie cavo progresivo, dedos en garra, atrofia de la musculatura intrínseca del pie y peroneos (“piernas de cigüeña”), y alteraciones sensitivas en territorio del nervio peroneo. El inicio es típicamente en la infancia, con progresión lenta y afectación simétrica, aunque puede haber asimetría. La parálisis cerebral infantil (opción 2) suele manifestarse desde el inicio de la deambulación con hipertonía y espasticidad, no con atrofia. La poliomielitis (opción 3) es actualmente excepcional en países desarrollados y produce parálisis flácida aguda, no progresiva. La siringomielia (opción 4) afecta principalmente a miembros superiores con disociación sensitiva termo-algésica.

117. Paciente de 40 años con antecedente de fractura abierta Gustilo IIIB de tibia tratada mediante fijador externo y posterior enclavado endomedular. Consulta 6 meses después por dolor, eritema y drenaje purulento a través de un trayecto fistuloso en la cara anteromedial de la tibia. Se observa secuestro óseo en radiografías y la TC muestra un segmento diafisario necrótico de 4 cm. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?:

1. Tratamiento antibiótico supresivo prolongado.
2. Desbridamiento, secuestrectomía y técnica de Masquelet.
3. Amputación transtibial.
4. Recambio del clavo endomedular por uno con cemento antibiótico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El cuadro descrito corresponde a una osteomielitis crónica con secuestro óseo y defecto segmentario tras fractura abierta. La técnica de Masquelet (opción 2) es un posible tratamiento en estos casos, donde todos tienen como punto en común un primer tiempo con desbridamiento radical. El defecto en este caso se rellena con cemento óseo para un relleno futuro de injerto de hueso, cuando la infección

esté curada. El tratamiento antibiótico supresivo aislado o el recambio del clavo serían insuficientes en presencia de secuestro óseo.

118. Paciente mujer de 65 años que ingresa por fractura subcapital desplazada de fémur derecho tras caída casual. La paciente es independiente para las actividades básicas de la vida diaria, camina sin ayudas técnicas y no presenta comorbilidades relevantes. ¿Cuál sería el tratamiento de elección?:

1. Tratamiento conservador con descarga durante 6 semanas.
2. Osteosíntesis con tornillos canulados.
3. Hemiartroplastia de cadera.
4. Artroplastia total de cadera.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre el tratamiento de la fractura subcapital desplazada de fémur en pacientes de edad avanzada. En pacientes de 65 años, con buena calidad de vida previa, independientes y sin comorbilidades importantes, la artroplastia total de cadera (sustitución tanto del componente femoral como del acetabular) es el tratamiento de elección para las fracturas subcapitales desplazadas. Esto se debe al alto riesgo de necrosis avascular y pseudoartrosis que presentan estas fracturas con la osteosíntesis, y a los mejores resultados funcionales a largo plazo de la artroplastia total frente a la hemiartroplastia en pacientes activos. La hemiartroplastia (opción 3) sería de elección en pacientes más ancianos (>75-80 años) o con menor demanda funcional. La osteosíntesis con tornillos canulados (opción 2) se reserva para fracturas no desplazadas o en pacientes jóvenes. El tratamiento conservador (opción 1) no está indicado.

119. Niño de 5 años cuyos padres consultan porque consideran que tiene los pies planos. En la exploración física se observa un aplanamiento del arco plantar cuando el niño está de pie, sin alteraciones cutáneas ni rigidez. Al ponerse de puntillas o al realizar la maniobra de Jack (extensión del primer dedo del pie) se recupera el arco plantar. ¿Cuál es el diagnóstico y manejo más adecuado?:

1. Pie plano rígido, requiere radiografía para descartar coalición tarsiana.
2. Pie plano flexible fisiológico, solo requiere observación.
3. Pie plano flexible patológico, precisa plantillas correctoras.
4. Pie plano por acortamiento del tendón de Aquiles, precisa estiramientos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El pie plano flexible fisiológico (opción 2) es extremadamente frecuente en niños pequeños y generalmente se re-

suelve espontáneamente con el crecimiento, sin requerir tratamiento. Se caracteriza por un aplanamiento del arco longitudinal cuando el niño está de pie, que se corrige al ponerse de puntillas o al extender el primer dedo (prueba de Jack). El pie plano rígido (opción 1) no corrige con estas maniobras y puede asociarse a coalición tarsiana, requiriendo estudio radiológico y potencial tratamiento.

120. Paciente de 58 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia que consulta por dolor en el pie izquierdo de 3 semanas de evolución. Refiere inicio progresivo sin traumatismo previo, con empeoramiento del dolor al soportar peso y al palpar el arco longitudinal. A la exploración presenta tumefacción y dolor a la palpación de la fascia plantar, especialmente en su inserción calcánea. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?:

1. Infiltración con corticoides.
2. Férula nocturna, ejercicios de estiramiento y AINE.
3. Tratamiento quirúrgico mediante fasciotomía plantar.
4. Ondas de choque extracorpóreas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El caso describe una fascitis plantar, cuyo tratamiento inicial debe ser conservador mediante una combinación de férula nocturna, ejercicios de estiramiento de la fascia plantar y musculatura posterior y antiinflamatorios (opción 2). Las infiltraciones con corticoides o las ondas de choque se reservan para casos refractarios al tratamiento inicial tras 3-6 meses. El tratamiento quirúrgico se realiza en casos refractarios, fundamentalmente con liberación del gastrocnemio medial.

121. Respecto a los criterios de inestabilidad en fracturas toracolumbares que requieren tratamiento quirúrgico, señale la opción INCORRECTA:

1. Una cifosis angular mayor de 25° indica inestabilidad.
2. La presencia de déficit neurológico es indicación absoluta de descompresión y estabilización quirúrgica.
3. La pérdida de altura del cuerpo vertebral mayor del 50% indica inestabilidad.
4. La afectación aislada del pilar anterior no suele requerir tratamiento quirúrgico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad alta sobre criterios de inestabilidad en fracturas vertebrales toracolumbares. La opción 2 es incorrecta porque la presencia de déficit neurológico no siempre es indicación absoluta de cirugía; depende del tipo de déficit y su evolución. Un déficit neurológico incompleto que me-

jora con tratamiento conservador no siempre requiere cirugía. Las otras opciones son correctas: una cifosis angular mayor de 25° (opción 1) es criterio de inestabilidad e indicación de cirugía; la pérdida de altura vertebral mayor del 50% (opción 3) también indica inestabilidad significativa; y la afectación aislada del pilar anterior (opción 4) es considerada estable y se trata conservadoramente, independientemente del grado de acúñamiento, siempre que no existan otros criterios de inestabilidad

122. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones NO es habitual encontrar en un paciente con amiloidosis cardiaca por transtirretina?:

1. Macroglosia.
2. Estenosis del túnel del carpo.
3. Estenosis del canal lumbar.
4. Rotura proximal de la porción larga del bíceps con "signo de Popeye".

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La amiloidosis con afectación cardiaca por TTR y AL comparten muchas características, si bien el curso clínico de la AL es mucho más agresiva y requiere un tratamiento dirigido y rápido. Entre las diferencias, destacar la macroglosia, que es mucho más característica en la AL y apenas está presente en la TTR. El resto son correctas. Recuerda que todas las manifestaciones de las amiloidosis se producen por depósito de amiloide en diferentes tejidos.

123. Señale la afirmación incorrecta en relación a la cardiotoxicidad farmacológica:

1. La cardiotoxicidad por antraciclinas es dosis dependiente.
2. La toxicidad por anti-HER2 aumenta en combinación con las antraciclinas.
3. Los inhibidores de check-point como anti-PD1 carecen de toxicidad cardiaca.
4. El riesgo de cardiotoxicidad es superior en aquellos pacientes con cardiopatía previa, si bien habitualmente no es una contraindicación para el tratamiento oncológico con agentes cardiotóxicos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La cardiotoxicidad es un tema muy de moda y que debes dominar. Hace referencia a la toxicidad farmacológica de agentes utilizados para el tratamiento de tumores, y aunque inicialmente se veían afectados aquellos pacientes que recibían tratamiento para tumores de mama, hematológicos y sarcomas (esquemas basados en antraciclinas) hoy en día existe un mayor rango de cardiotoxicidad por las nuevas terapias. Las antraciclinas producen daño directo en el miocardio, como consecuencia dilatación ventricular y pérdida de función sistólica, siendo un efecto dosis dependiente que puede estar favorecido por otros tratamientos (también la radioterapia). En ocasiones subyace una predisposición ge-

nética (pacientes con genotipo alterado para miocardiopatía que no expresan fenotipo hasta que haya una agresión). Como tema novedoso, la toxicidad por inmunoterapia a nivel cardiaco produce miocarditis, que habitualmente se asocia a la "triada M": miocarditis, miositis y miastenia.

124. Un paciente de 90 años hipertenso y fumador acude a Urgencias por dolor torácico. Se documenta bradicardia a 30 lpm e hipotensión. Se realiza ECG en el que se muestra elevación del ST en al menos dos derivaciones contiguas y un bloqueo AV completo. El paciente acudió a una revisión rutinaria la semana pasada y en el ECG no presentaba estos cambios. La sospecha fundamental es de SCACEST, ¿cuál crees que es la arteria responsable con total probabilidad?:

1. Descendente anterior a nivel distal.
2. Arteria circunfleja dominante.
3. Coronaria derecha proximal o media.
4. Interventricular posterior.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un IAM con una complicación eléctrica, el BAV completo. Este habitualmente lo vemos en infartos inferiores (elevación en DII, DIII y aVF) como consecuencia de la oclusión aguda de la coronaria derecha, a nivel proximal o medio ya que las ramas para el nodo auriculoventricular (estructura afectada en el BAV) salen de la CD a nivel medio. Habitualmente tras apertura de la arteria, se recupera la conducción por lo que no es necesario implantar un marcapasos permanente (puede precisar uno transitorio si presenta gran inestabilidad hemodinámica previa a ICP). También puede haber BAV completo en infartos anteriores muy extenso, que son de muy mal pronóstico, habitualmente por afectación de las fibras de Purkinje. Aquí, probabilidad de recuperar la conducción es más remota.

125. En una de las siguientes entidades existe un shunt con flujo D-I. Señale de cuál se trata:

1. Comunicación interauricular en situación de Eisenmenger.
2. Comunicación intraventricular.
3. Ductus arterioso persistente.
4. Fístula coronaria a ventrículo derecho.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las 4 opciones producen shunt izquierda-derecha, pero un pequeño (o gran) matiz hace que la opción 1 sea la correcta: cualquier cardiopatía congénita con shunt I-D en situación de Eisenmenger invierte el shunt convirtiéndolo en D-I, ya que la presión pulmonar ha superado la sistémica y se considera una situación irreversible.

126. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO ha demostrado beneficio cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardiaca con FEVI reducida (<40%)?

1. Dapagliflozina.
2. Sacubitril-valsartan.
3. Vericiguat.
4. Atenolol.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esperemos que no te hayas liado, porque la pregunta tenía una pequeña trampa. Recuerda que el tratamiento de la IC con FEVI reducida incluye: betabloqueantes, IECA/ARA-2/ARNI (sacubitril-valsartan), antagonistas del receptor de los mineralocorticoides (espironolactona o eplerenona) e iSGLT-2 (empagliflozina o dapagliflozina). Además, deberemos valorar otras terapias coadyuvantes (como el hierro intravenoso) o en caso de descompensaciones de IC frecuentes a pesar de tratamiento médico óptimo, el uso de otros fármacos como el vericiguat, que ha demostrado disminuir ingresos hospitalarios. Pero ojo, porque entre los betabloqueantes, solo debemos utilizar aquellos que CaMBiaN el pronóstico: Carvedilol, Metoprolol, Bisoprolol o Nebivolol. El atenolol no está entre ellos.

127. En un paciente de 71 años con miocardiopatía dilatada isquémica con FEVI severamente reducida (25%) y función conservada de ventrículo derecho, en situación NYHA III a pesar de tratamiento médico óptimo, portador de DAI-TRC no respondedor y con ergoespirometría que aporta datos de mal pronóstico cardiovascular, no candidato a trasplante cardiaco por edad pero sin mayores comorbilidades, la actitud a considerar será:

1. Colocación de dispositivo de asistencia ventricular de corta duración (por ejemplo, sistema Impella) como puente a candidatura de trasplante cardiaco.
2. Iniciar estudio para implante de asistencia ventricular de larga duración.
3. Derivar a cuidados paliativos de cara a planificar el fin de la vida.
4. Colocación de bomba de infusión de inotrópicos positivos como milrinona o dobutamina y seguimiento por Hospitalización a Domicilio para alargar su esperanza de vida.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Hasta hace unos años los pacientes con IC avanzada y mala evolución clínica no tenían otra opción que ser trasplantados, sin embargo muchos presentaban contraindicaciones que impedían el trasplante (edad, comorbilidades...). Hoy en día para este grupo de pacientes que no son candidatos al trasplante y tienen comorbilidades no limitantes podemos ofrecerles máquinas de asistencia ventricular de larga duración, que extraen la sangre desde la punta del ventrículo izquierdo y lo envían a la aorta ascendente (haciendo el trabajo del ventrículo izquierdo). No están exentas de complicaciones y permiten una buena calidad de vida a los pacien-

tes, con controles periódicos y estrechos. Por el momento solo existen aquellas que soportan el ventrículo izquierdo, no siendo aptos para pacientes que tienen disfunción biventricular (recuerda que el Qp:Qs es de 1; si soportamos el ventrículo izquierdo pero el derecho no funciona bien, el ventrículo derecho fracasará).

128. Paciente que acude a Urgencias por malestar general y palpitaciones, en ECG de objetiva taquicardia regular de QRS ancho. Su TA de es de 70/50mmHg. La medida inicial será:

1. Ver si tiene pulso, si lo tiene cardioversión farmacológica con amiodarona.
2. Ver si tiene pulso, si lo tiene cardioversión farmacológica con procainamida.
3. Realizar cardioversión eléctrica sincronizada.
4. Realización de masaje de seno carotídeo y maniobras vagales, si no resultan efectivas administrar adenosina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

No te lo pienses. Paciente con taquicardia regular de QRS ancho, si está inestable: CVE. Hoy en día las recomendaciones es que si está estable el tratamiento también será la CVE, aunque podremos utilizar fármacos (amiodarona, procainamida) para su tratamiento.

129. ¿Cuál de las siguientes arritmias es característico que cese tras administración de adenosina?:

1. Taquicardia auricular.
2. Taquicardia ortodrómica medida por vía accesoria.
3. Flutter auricular.
4. Taquicardia sinusal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las taquicardias que responden a maniobras vagales o ceden con adenosina son aquellas cuyo circuito incluye el nodo auriculoventricular, es decir, las taquicardias por reentrada nodal (TIN) y la taquicardia mediada por vía accesoria (WPW). En el resto, la adenosina producirá un bloqueo transitorio del nodo AV pero no cesará la taquicardia, y en cuanto pase su efecto, volverán a conducir a través del nodo AV.

130. En relación a la parada cardiorrespiratoria señale la respuesta INCORRECTA:

1. La causa más frecuente en adultos es la cardíaca y en niños la respiratoria.
2. En el adulto intubado deben realizarse 30 compresiones y dos ventilaciones por minuto.
3. Si persiste un ritmo desfibrilable tras 3 choques de desfibrilación, se debe administrar un bolo intravenoso de 300mg de amiodarona.
4. Evitar la hipertermia mediante el control

de temperatura o la hipotermia terapéutica disminuyen la apoptosis y la producción de radicales libres y tienen un efecto neuroprotector, y está indicado en pacientes comatosos tras una parada cardiorrespiratoria, en aquellos cuya causa es de origen cardiológico (FV).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que resume generalidades de la parada cardiorrespiratoria y cuidados postresucitación. En el adulto no intubado debemos realizar 30 compresiones por minuto y 2 ventilaciones; una vez hayamos aislado la vía aérea (intubación orotraqueal con tubo o mascarilla laríngea) aplicaremos ventilaciones continuas mientras se realizan compresiones manuales, lo cual nos permite no detener las compresiones.

131. ¿Qué parámetro se utiliza para establecer la gravedad de la obstrucción en el EPOC?:

1. Índice de Tiffeneau.
2. DLCO.
3. FEV1.
4. PaO2.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Aunque el índice de Tiffeneau diagnostica obstrucción, la gravedad se clasifica según el FEV1 (GOLD).

GOLD 1:	Obstrucción leve	> 80%
GOLD 2:	Obstrucción moderada	50-79%
GOLD 3:	Obstrucción grave	30-49%
GOLD 4:	Obstrucción muy grave	<30%

132. Respecto al diagnóstico diferencias de las enfermedades intersticiales indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

1. La silicosis en una neumoconiosis producida por la exposición al sílice cuya afectación más característica son la formación de placas pleurales.
2. En un paciente con diagnóstico de asbestosis que presenta derrame pleural es indicativo de que existe un mesotelioma.
3. El tumor más frecuentemente asociado a la asbestosis es el mesotelioma.
4. En el lavado broncoalveolar de una paciente con neumonitis por hipersensibilidad crónica demuestra un incremento de linfocitos T.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica que mezcla conceptos de diferentes neumonitis por inhalación de polvos inorgánicos u orgánicos. Las placas pleurales son la afectación más frecuente en la asbestosis, no en la silicosis (respuesta 1 incorrecta). El derrame pleural de la asbestosis suele ser benigno y no implica necesariamente la presencia de mesotelioma (respuesta

2 incorrecta). El mesotelioma es el tumor más característicamente asociado al asbesto pero el más frecuente es el cáncer de pulmón (opción 3 falsa). La correcta es la 4: en la neumonitis por hipersensibilidad, tanto es su fase aguda como crónica, se demuestra en el lavado broncoalveolar un incremento de linfocitos T con predominio de los CD8.

133. Paciente de 59 años, fumador de 30 paquetes/año, con nódulo pulmonar periférico. Se realiza PET con captación patológica, sin adenopatías ¿Próxima actitud?:

1. Biopsia transbronquial.
2. Cirugía de resección.
3. Biopsia percutánea guiada por TC.
4. Seguimiento con TC de torax.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nódulo con alta sospecha de malignidad (PET+ , fumador y > 35 años) sin adenopatías → tratamiento quirúrgico directo.

134. Varón de 55 años con antecedentes de EPOC que recientemente ha sido diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón de 2,5 cm de diámetro en el bronquio principal derecho. En el PET- TAC se objetivan adenopatías hiliares ipsilaterales sin metástasis a distancia. Dado los antecedentes del paciente se realiza una espirometría: FEV1 850 ml 40% del teórico, FVC 1300 ml 70% del teórico, FEV1/FEV 0.6. ¿cuál sería el estadiaje y el manejo más adecuado?:

1. T1N1M0 resección quirúrgica.
2. T2N1M0 resección quirúrgica y posterior quimioterapia.
3. T1 N1 M0, valorar FEV1 post quirúrgica y si es mayor a 40% cirugía.
4. T2N1 M0 valorar FEV1 post quirúrgica y si es mayor a 40% cirugía.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para resolver esta pregunta lo primero es realizar una correcta estadificación TNM del cáncer de pulmón de células no pequeñas. Nos comentan que se trata de un adenocarcinoma de 2,5 cm PERO, ATENCIÓN, se encuentra en un bronquio principal por tanto T2. Nos describen adenopatías hiliares ipsilaterales sin metástasis, por tanto, estaríamos ante un T2 N1M0 (posibles opciones correctas la 2 y la 4), a priori un tumor resecable con intención curativa. El siguiente paso es saber si nuestro paciente es operable. Uno de los datos que nos indican operabilidad es la FEV1, si es mayor de 80% el paciente es operable, pero si es menor de 80% debemos calcular el FEV1 postoperatorio predicho. Si esté es mayor a 40% podremos operar (opción 4 correcta).

135. Mujer de 35 años con antecedentes de asma acude a consulta de revisión. En su última espirimetría el FEV1 es de 70% y se encuentra bajo tratamiento con B agonistas de acción prolongada y corticoides inhalados a dosis altas. Ha tenido 2 ingresos hospitalarios en el último año en época primaveral en relación a exposición a las gramíneas, y ha precisado ciclos de corticoides sistémicos con adecuada respuesta, pero al retirarlos mal control de síntomas habituales. Señale la respuesta correcta en cuanto al fenotipo asmático y la mejor opción de tratamiento:

1. Se trata de un asma eosinofílica (T2) y una buena opción terapéutica sería añadir omalizumab.
2. Se trata de un asma alérgico (T2) y una buena opción terapéutica sería omalizumab.
3. Se trata de un asma no T2 y la mejor opción terapéutica sería antileucotrienos.
4. Se trata de un asma no T2 y la mejor opción terapéutica sería azitromicina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos hablan de una paciente con asma grave a pesar de tratamiento inhalador pleno. Cuando llegamos a este punto terapéutico con una paciente asmática debemos plantearnos si cumple criterios de un fenotipo para buscar dianas terapéuticas más específicas. La descripción de sus características nos orienta hacia un asma tipo T2 alérgico (síntomas primaverales, antígeno específico, mejoría con corticoterapia). En el asma alérgico T2 se trata en primer lugar con un anti IgE llamado omalizumab (respuesta 2 correcta).

136. Un paciente varón de 52 acude al servicio de endoscopias para realizarse una gastroscopia por déficit de vitamina B12. Se toman múltiples biopsias de antro y cuerpo, y el patólogo informa las biopsias como atrofia corporal con metaplasia intestinal incompleta, que respeta antro gástrico. De las siguientes afirmaciones, señale la correcta:

1. La causa más probable de esta gastritis crónica atrófica es la infección por *Helicobacter pylori*.
2. La metaplasia incompleta asocia mayor riesgo de progresión a adenocarcinoma que la metaplasia completa.
3. En este tipo de gastritis aumenta el riesgo de adenocarcinoma gástrico, pero no de tumores carcinoides.
4. La endoscopia de magnificación y la cromoendoscopia no parecen ser útiles en la detección de neoplasias precoces del estómago.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Este caso clínico nos habla de una gastritis crónica atrófica de predominio corporal asociado a déficit de B12, muy probablemente en relación con una gastritis crónica autoinmune. Este tipo de gastritis asocia un mayor riesgo de atrofia y metaplasia, que se asocian a adenocarcinoma gástrico así como acloridia, asociada hipergastrinemia, lo cual asocia una mayor incidencia de tumores carcinoides. La metaplasia intestinal puede ser completa (como la del intestino delgado) o incompleta (como la del colon), asociando esta última a un mayor riesgo de displasia y por tanto de progresión a adenocarcinoma gástrico. Entendiendo la gastritis crónica atrófica con metaplasia como una condición premaligna, se recomienda realizar periódicamente endoscopias de cribado con biopsias, realizando una exploración endoscópica de lesiones potencialmente malignas, siendo la endoscopia de magnificación y la cromoendoscopia fundamentales para realizar una detección precoz de estas lesiones.

137. Un paciente con colitis ulcerosa extensa en remisión presenta colangitis de repetición, elevación de GGT y fosfatasa alcalina, y colangiorresonancia con estenosis multifocales de los conductos biliares intrahepáticos. ¿Cuál de los siguientes hallazgos se espera encontrar en este contexto?:

1. Autoanticuerpos anti-LKM1 positivos
2. Aumento de riesgo de colangiocarcinoma
3. Niveles de IgE elevados
4. Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) negativos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una colangitis esclerosante primaria (CEP) asociada a colitis ulcerosa. Este paciente tiene alto riesgo de colangiocarcinoma, independientemente del grado de actividad inflamatoria intestinal. Es típica la positividad para p-ANCA, no anti-LKM1 (relacionado con hepatitis autoinmune tipo 2). No se relaciona con los niveles de IgE.

138. En relación con el diagnóstico del síndrome del intestino irritable con predominio de diarrea, es cierto que:

1. La enfermedad celiaca se debe excluir únicamente por clínica.
2. Se basa en criterios clínicos como los de Roma IV tras descartar otras patologías.
3. No requiere analítica alguna si los síntomas son típicos.
4. Una calprotectina fecal elevada permite excluir otros diagnósticos como la enfermedad inflamatoria intestinal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La calprotectina fecal, los anticuerpos antitransglutaminasa son pruebas analíticas que deben ser normales para excluir

otros diagnósticos en patología funcional del tubo digestivo como el síndrome del intestino irritable, que se diagnostica con los criterios de Roma IV tras haber excluido otras enfermedades orgánicas.

139. Acude a consulta una mujer de 45 años refiriendo dificultad para tragar sólidos y líquidos desde hace 3 meses asociando pérdida de peso. Se realiza una manometría esofágica en la que se observa ausencia de peristalsis y falta de relajación del EEI con presión elevada. ¿Qué enfermedad padece la paciente?:

1. Espasmo esofágico difuso.
2. Esclerodermia.
3. Acalasia.
4. Motilidad esofágica ineficaz.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el caso de una acalasia en la manometría veremos ausencia de peristalsis y fallo de relajación del EEI con presión elevada. El espasmo esofágico difuso se diagnosticaría cuando se detectan ondas simultáneas en más del 20% de las degluciones. La esclerodermia se caracteriza por una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y una peristalsis ineficaz o ausente. En la motilidad esofágica ineficaz >50% de las secuencias peristálticas son ineficaces y la relajación del esfínter esofágico inferior es normal.

140. Paciente de 70 años con antecedentes de estreñimiento crónico y dieta pobre en fibra acude a consulta por episodios recurrentes de dolor en fosa iliaca izquierda, no febril, que mejora con la defecación. Se sospecha enfermedad diverticular sintomática no complicada. En relación con la fisiopatología y anatomía de la enfermedad diverticular colónica, señale la opción correcta:

1. Los divertículos colónicos son divertículos verdaderos, por tanto, se afectan todas las capas de la pared intestinal y predominan en colon izquierdo.
2. El aumento de la presión intraluminal se asocia con herniación de la mucosa y submucosa en puntos débiles de la capa muscular.
3. La enfermedad diverticular es más prevalente en el colon derecho en población occidental.
4. La localización típica de los divertículos es en las bandas longitudinales del colon, donde convergen las asas colónicas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La enfermedad diverticular colónica es una patología adquirida en la que, por factores como la baja ingesta de fibra y el aumento de la presión intraluminal (especialmente en el colon sigmoide), se producen pequeñas herniaciones de la mucosa y submucosa a través de zonas de debilidad

de la capa muscular, típicamente donde penetran los vasos perforantes. Estas estructuras se consideran divertículos falsos, ya que no incluyen todas las capas de la pared. La opción A es incorrecta porque describe un divertículo verdadero. La C es errónea porque en población occidental predominan en el colon izquierdo. La D también es falsa: los divertículos no se originan directamente en las bandas longitudinales, sino entre ellas, en zonas de debilidad muscular.

141. En una ecografía de rutina semestral para cribado de hepatocarcinoma, se identifica una LOE hepática de 25 mm de diámetro. Se solicita TAC con contraste, que confirma la presencia de hipercaptación en fase arterial con lavado precoz en fase venosa. La paciente es una mujer de 60 años con cirrosis por VHC, diagnosticada a raíz de un primer episodio de hemorragia por varices esofágicas. En aquel momento se inició tratamiento con sofosbuvir/velpatasvir, encontrándose la paciente en respuesta viral sostenida desde entonces. No hábitos tóxicos ni otras comorbilidades extrahepáticas relevantes. ¿Cuál es la actitud más adecuada a seguir a continuación?

1. Biopsia con aguja gruesa de la lesión.
2. Derivar a la paciente para trasplante hepático.
3. Ablación por radiofrecuencia.
4. Resección quirúrgica de la lesión con intención curativa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una lesión hepática con comportamiento dinámico típico que asienta sobre un hígado cirrótico, por lo que asumimos hepatocarcinoma sin necesidad de obtener una biopsia hepática. Por tamaño y extensión se trata de un estadio A, en el que las opciones con mayor tasa de curación van a ser el trasplante y la resección quirúrgica. Sin embargo, la paciente no es buena candidata a cirugía resectiva por tener hipertensión portal significativa (recuerda que tiene varices esofágicas con antecedentes de sangrado). Por este motivo, la mejor opción terapéutica en esta paciente es el trasplante hepático.

142. Respecto a los pólipos vesiculares, es cierto:

1. La mayoría son adenomas, susceptibles de evolucionar a cáncer de vesícula.
2. Habitualmente son sintomáticos.
3. La primera línea de tratamiento es la CPRE.
4. Precisan tratamiento cuando miden >10 mm.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Los pólipos vesiculares, en su mayoría, son milimétricos y asintomáticos; la mayoría corresponden a pólipos de colesterol, es decir, acúmulos de detritus sin potencial maligno. No obstante, ecográficamente no es posible distinguir los

pólipos de colesterol de los verdaderos adenomas. Por este motivo se realiza seguimiento ecográfico, sabiendo que la inmensa mayoría van a tener un comportamiento indolente. En aquellos, pocos, que crecen por encima de los 10 mm, está indicada la colecistectomía por el riesgo de degeneración maligna.

143. Mujer de 28 años diagnosticada hace 1 año de colitis ulcerosa izquierda en tratamiento con mesalazina oral y tópica que acude a urgencias por astenia, dolor abdominal, aumento del número de deposiciones líquidas a 15 diarias con rectorragia en todas ellas. En la analítica se observa creatinina 1,2 mg/dL, iones en rango, leucocitos 8000 mm³, Hb 10 g/dL, PCR 100 mg/dL, INR 1,5, resto sin alteraciones. ¿Cuál sería el manejo más adecuado?:

1. Tratamiento con ciclosporina a 2 mg/kg.
2. Tratamiento con metilprednisolona 1 mg/kg.
3. Tratamiento con metilprednisolona 1 mg/kg + antiTNF como infliximab.
4. Beclometasona 10 mg y prednisona 60 mg vía oral.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la pregunta se describe un brote grave de colitis ulcerosa por lo que el tratamiento a instaurar es metilprednisolona 1 mg/kg (máximo 60mg). La ciclosporina o el antiTNF sería el paso siguiente a dar. Los corticoides orales y tópicos se podrían dar en un brote moderado.

144. Mujer de 42 años con disfagia progresiva a sólidos y líquidos. La manometría esofágica de alta resolución muestra aperistalsis completa y aumento de la presión del esfínter esofágico inferior (EEI), con relajación incompleta. Se decide tratamiento endoscópico. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la miotomía peroral endoscópica (POEM) es correcta?:

1. Se realiza una incisión mucosa exclusivamente en cara anterior del esófago para que, posteriormente de una forma "tunelizada" se consiga acceder al músculo y llevar a cabo la miotomía.
2. La técnica no permite miotomía gástrica.
3. Tiene mayor riesgo de reflujo que la cirugía de Heller con funduplicatura.
4. No está indicada en pacientes jóvenes por riesgo de perforación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El POEM es una técnica endoscópica mínimamente invasiva utilizada en el tratamiento de la acalasia, que permite realizar una miotomía del EEI accediendo a través

de una incisión en la mucosa esofágica proximal, creando un túnel submucoso. A diferencia de la cirugía de Heller, no se acompaña de una funduplicatura, por lo que los pacientes tienen una mayor incidencia de reflujo postprocedimiento, lo que justifica la respuesta correcta.

- Opción a) Incorrecta porque la incisión mucosa puede realizarse en cara anterior o posterior del esófago proximal
- Opción b) Falsa. A diferencia de la cirugía, el POEM permite extender la miotomía al estómago (miotomía gástrica de 2–3 cm); en ciertos casos eso es deseable para asegurar una relajación adecuada del EEI. Esto es una de sus ventajas técnicas.
- Opción d) También incorrecta. El POEM es una opción segura en pacientes jóvenes, y de hecho se prefiere en algunos casos por ser menos invasiva y ofrecer buenos resultados funcionales. El riesgo de perforación existe, pero es bajo en manos expertas y no es una contraindicación por edad.

145. Paciente de 59 años intervenido hace 10 días mediante hemicolectomía. Consulta por enrojecimiento y dolor en la zona de la herida quirúrgica, con salida de pus por un punto lateral. ¿Qué actitud es correcta?:

1. Antibioterapia empírica oral.
2. Cierre inmediato de la herida con puntos nuevos.
3. Apertura de la herida y curas locales.
4. Solicitar TC para valorar absceso profundo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las infecciones de herida quirúrgica superficial se tratan con apertura de la herida, drenaje si hay supuración, y curas locales. Añadiremos antibiotico en caso de que la infección este produciendo afectación sistémica o mucha celulitis. Pero lo que tenemos que hacer es abrir la herida y lavarla

146. Hombre de 69 años intervenido hace 5 años de hernioplastia inguinal derecha por vía abierta tipo Liechtenstein con malla, consulta por aparición de masa dolorosa en región inguinal derecha, que aumenta con maniobras de Valsalva. ¿Ante una recidiva herniaria tras cirugía abierta por vía anterior, cual sería la técnica quirúrgica más adecuada para abordar esta hernia?:

1. Como ya está operado no se debe volver a operar.
2. Cirugía por vía laparoscópica TEP o TAPP.
3. Cirugía abierta por vía anterior de nuevo.
4. Lo correcto sería quitarle la malla al paciente y no volver a colocar otra porque la primera ya ha fallado.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las hernias conceptualmente se pueden abordar por delante del “Agujero” (Vía anterior) o por detrás del “agujero” (Vía posterior). Cuando una hernioplastia ha recidivado por una de las vías lo correcto es operar por la vía que no se usó la primera vez. Es decir, en nuestro paciente que si que hay que operarle porque las hernias se operan, ya se ha usado la vía anterior y por tanto nos tenemos que ir a la vía posterior. Todas las técnicas laparoscópicas usan la vía posterior. La cirugía abierta clásica generalmente usa la vía anterior y algunas técnicas poco usadas la posterior (Técnica Nyhus). Por lo tanto la vía anterior o posterior no es exclusiva de la abierta, pero si todas las técnicas laparoscópicas son por vía posterior. Por lo tanto a nuestro paciente hay que operarle, hay que colocarle malla porque es lo que disminuye el riesgo de recidiva y debemos usar la vía posterior en este caso la única opción posible es la 2

147. Mujer de 32 años de hábito estreñido que acude a consulta por dolor anal que comenzó hace 2 meses tras una deposición dura. Aunque ha mejorado parcialmente actualmente cada vez que realiza deposición tiene dolor y le queda una sensación dolorosa en el ano y en la pelvis después de la misma, durante todo el día. Le diagnosticaron de una fisura anal y ha recibido tratamiento analgésico y tratamiento tópico durante 6 semanas sin llegar a remitir del todo. ¿Cuál sería la siguiente actitud terapéutica?:

1. Infiltración de toxina botulínica.
2. Cirugía esfinterotomía lateral interna.
3. Continuar con tratamiento médico.
4. Cirugía con láser.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las fisuras anales crónicas (≥ 6 semanas) no responden bien al tratamiento médico y su tratamiento debe ser quirúrgico. Históricamente la cirugía que se proporcionaba a los pacientes era la esfinterotomía lateral interna que consistía en cortar un 20-40% del esfínter anal interno para evitar su contracción involuntaria y que al relajarse permitiese la cicatrización de la fisura y cesar el dolor. Sin embargo, esto tiene su lado malo que no es otro que el riesgo de incontinencia fecal a largo plazo. Este riesgo es mayor en las mujeres inherentes a sus características (menor masa muscular pélvica, suelo de la pelvis atravesado por 3 órganos en vez de dos, posibilidades de parto y menopausia). Este escollo se ha visto solventado por la toxina botulínica que ha permite “romper” químicamente el músculo temporalmente, el tiempo suficiente para la cicatrización de la fisura con el mismo efecto que la esfinterotomía lateral interna pero sin la desagradable consecuencia de la incontinencia. Por lo tanto las guías marcan que el siguiente escalón, tras el tratamiento médico inefectivo es la inyección de toxina botulínica en el espacio interesfínteriano antes de valorar la sección irreversible del esfínter. Esta técnica tiene probabilidades muy altas de éxito evitando la ELI clásica.

148. Niño de 6 años sufre una quemadura con agua hirviendo que afecta el 12% de superficie corporal, incluyendo cara anterior de ambos muslos y región perineal. En urgencias presenta ampollas rotas y zona blanquecina con pérdida de sensibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Quemadura de primer grado.
2. Quemadura de segundo grado superficial.
3. Quemadura de segundo grado profunda.
4. Quemadura de tercer grado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La pérdida de sensibilidad y aspecto blanquecino indica afectación de la dermis profunda (reticular), sin llegar a fascia o grasa por eso nuestra quemadura es de segundo grado profundo. Estas quemaduras cicatrizan lentamente, muchas veces precisan injerto, y tienen mayor riesgo de secuelas. El uso de la “regla del nueve modificada” en niños es clave para valorar extensión

149. Un varón de 68 años con linfoma difuso de células B grandes (LDCBG) y prostatitis crónica con infección urinaria reciente tratada con trimetoprima/sulfametoxazol ingresa para recibir quimioterapia de inducción esquema R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona). Recibe profilaxis con alopurinol. Cuatro días después presenta clínica de temblor distal, parestesias y debilidad generaliza. En analítica de urgencias se objetiva potasio de 7,2 mEq/L; calcio de 7,0 mg/dL; fósforo de 8,1; ácido úrico de 12 mg/dL y creatinina sérica de 3 mg/dL (basal: 1,2 mg/dL). En ECG urgente se objetiva bradicardia a 40 lpm con QRS ancho. Además de administrar gluconato cálcico, insulina y glucosa, ¿cuál es el tratamiento más adecuado?:

1. Iniciar hemodiálisis con dializado bajo en potasio.
2. Cambiar alopurinol por febuxostat.
3. Administrar rasburicasa.
4. Colocación de un marcapasos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta: 3. Estamos ante un caso de hiperpotasemia tóxica en contexto de fracaso renal agudo por síndrome de lisis tumoral. Además de las medidas iniciales (gluconato cálcico para estabilidad la membrana miocárdica, glucosa e insulina para favorecer el shift intracelular de potasio) debemos valorar cuál es el siguiente paso más acertado. En este caso no está indicada la colocación de un marcapasos dado que la cardiotoxicidad tiene una causa tratable (la hiperpotasemia). Podríamos valorar la hemodiálisis en caso de no respuesta a la medidas antihiperpotesemia pero debemos disminuir

cuanto antes la concentración de ácido úrico para evitar la formación y precipitación de cristales de ácido úrico a nivel intratubular que perpetúen el fracaso renal. Por ello e deberemos iniciar tratamiento con rasburicasa que consigue una rápida disminución de los niveles de ácido úrico. El febuxostat previene la formación de más ácido úrico pero no disminuye los niveles existentes en el proceso agudo.

150. Mujer de 89 años con diagnóstico reciente de adenocarcinoma de pulmón que acude al servicio de Urgencias por desorientación y caídas repetidas en domicilio. A la exploración se encuentra normotensa, sin hallazgos reseñables. En la analítica de sangre de obtienen los siguientes resultados: Glucosa 101 mg/dL; Cr 1 mg/dL; Urea 40 mg/dL; Na 124 meq/L; K 4,5 mEq/L; Cl 89 mEq/L; ácido úrico 2,1 mg/dL; Hb 10 g/dL; Leucocitos 6500 u/L; plaquetas 150 000 u/L. En relación a la patología que usted sospecha señale la correcta:

1. Es esperable encontrar un sodio en orina elevado (>30 mmol/L) con una osmolaridad baja en orina (<100 mOsm/kg H₂O).
2. Solicitaría un estudio hormonal con cortisol y TSH.
3. El tratamiento incluye el uso de suero hipertónico para corregir rápidamente la hiponatremia.
4. Las cifras bajas de ácido úrico orientan a un caso de posible potomanía.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Respuesta: 2. Paciente con antecedente de adenocarcinoma de pulmón e hiponatremia con euvoemia, mi primera sospecha en el MIR es el SIADH. Es importante descartar hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal porque pueden emular un SIADH. El Na en orina y la Osmo urinaria estarán ambos elevados por déficit de eliminación de agua libre. Es importante evitar la corrección rápida de la hiponatremia para evitar un síndrome de desmielinización osmótica. El ácido úrico bajo se asocia a ganancia de agua libre y es típico del SIADH.

151. Un varón de 60 años con antecedentes de tabaquismo e hipertensión en tratamiento con enalapril 5 mg al día acude a Urgencias por un cuadro de edemas de dos semanas de evolución. A la exploración presenta TA 140/80 mmHg, FC 85 lpm, SaO₂ basal 92%, crepitantes finos en bases y edema con fovea hasta rodillas de manera bilateral. Se solicita radiografía de tórax sin evidencia de derrame pleural y una analítica sanguínea con Cr 1,3 mg/dL, Urea 72 mg/dL, Na 135 mEq/L; K 4,9 mEq/L, perfil hepático normal, CK 80 UI/L, NT-proBNP 900 ug/mL, Albúmina 2,5 g/dL, Hb 9 g/dL, Leucocitos 7×10^3 u/L/L Plaquetas 195.000 u/L. Usted solicita una

muestra de orina porque el paciente refiere orinas espumosas. El índice proteínas/creatinina en orina es de 7000 mg/g y se objetiva también la presencia de una cruz de hematíes. Ingres a cargo de Nefrología. El estudio inmunológico básico es normal, salvo el antiPLA2R que está pendiente, las serologías son negativas. Se decide realizar una biopsia renal percutánea y el patólogo llama para informar de los resultados preliminares. Refiere que en la muestra se objetiva una membrana basal engrosada con spikes y apolillamiento de la misma. En base a la patología que usted sospecha señale la falsa:

1. Estaría indicado hacer un despistaje de patología infecciosa y tumoral como parte del estudio de causas secundarias, también en presencia de antiPLA2R positivo en pacientes con antecedentes de exposiciones de riesgo.
2. La toma de enalapril está descrita como causa secundaria de esta glomerulonefritis.
3. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto.
4. En el análisis con inmunofluorescencia se observa un depósito granular de IgG y C3 en los capilares glomerulares.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Respuesta 2: Se trata de una GN membranosa, causa más frecuente de sd nefrótico en el adulto. En este caso la falsa es la respuesta 2 dado que solo está descrito el captopril dentro del grupo de los IECA como causa secundaria de GN membranosa. En pacientes con antiPLA2R positivo se asume prácticamente que se trata de una GN primaria y por tanto no sería necesario ampliar el estudio de causas tumorales o infecciosas si bien, y esto es particularmente cierto en población asiática, hay casos descritos de patología tumoral concomitante en pacientes con antiPLA2R y dado el antecedente de tabaquismo no está de más hacer un cribado a este paciente.

152. En relación a la nefropatía diabética una es cierta:

1. Es frecuente que tanto los pacientes con DM tipo 2 como con DM tipo 1 con nefropatía diabética presenten hipertensión arterial en el momento del diagnóstico de su nefropatía.
2. Más del 75% de los pacientes con DM1 desarrollarán nefropatía diabética al cabo de 25 años.
3. En un paciente con DM y enfermedad renal crónica la ausencia de retinopatía diabética excluye el diagnóstico de nefropatía diabética.
4. No existen diferencias histológicas a nivel renal en pacientes con DM de tipo 1 o DM 2 de tipo 2 con nefropatía diabética.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Respuesta: 4. Es frecuente que los pacientes con DM2 ya tengan hipertensión arterial en el momento del diagnóstico de su ERC (suelen presentar síndrome metabólico), sin embargo en los pacientes con DM1 la ERC es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión en el futuro. Aproximadamente el 25% de los pacientes con DM1 desarrollarán ND al cabo de 25 años. La ausencia de retinopatía diabética no excluye el diagnóstico de nefropatía diabética (presente en el 95% de los paciente con DM1 y ND, y en el 60% de los pacientes con DM2 y ND). A nivel histológico la nefropatía diabética se presenta igual en pacientes con DM1 y DM2.

153. ¿Cuál de las siguientes drogas se asocia en menor medida con el desarrollo de nefritis tubulointersticial aguda?:

1. Trimetoprima/sulfametoxazol.
2. Omeprazol.
3. Bevacizumab.
4. Pembrolizumab.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta 3: Los antiVEGF se asocian más con el desarrollo de hipertensión y microangiopatía trombótica por el daño endotelial

154. ¿Cuál de las siguientes no es un factor de progresión de ERC?:

1. Dieta basada en proteínas de origen animal.
2. Acidosis metabólica.
3. Hiperpotasemia.
4. Hiper magnesemia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Respuesta: 4. La dieta basada en proteínas de origen animal parece tener ventajas en relación a la dieta carnívora habitual y retrasa la progresión de la ERC. Se ha descrito la asociación entre acidosis metabólica, hiperpotasemia y aumento de riesgo de progresión de ERC, no así con la hiper magnesemia (parece que tanto la hipo como la hiper magnesemia se asocian a mayor mortalidad pero no a mayor progresión de la ERC).

155. ¿Cuál es la técnica de tratamiento renal sustitutivo más prevalente en nuestro país?:

1. La hemodiálisis en centro.
2. El trasplante renal.
3. La hemodiálisis domiciliaria.
4. La diálisis peritoneal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Respuesta: 2. Hay más pacientes con trasplante renal, seguido de pacientes en hemodiálisis en centro seguido de las técnicas domiciliarias.

156. Mujer de 30 años sin antecedentes conocidos que es traída al servicio de Urgencias por bajo nivel de conciencia. A la exploración presenta TA 180/90 mmHg; FC 100 lpm, SaO₂ 89% basal, T 36,9°. Se realiza TC de cráneo urgente que no objetiva patología aguda y analítica sanguínea urgente con los siguientes resultados: Cr 3,4 mg/dL, Urea 120 mg/dL; Na 136 mEq/L; K 5,1 mEq/L; LDH 845 UI/L; BT 1,5 mg/dL; ALT 20 UI/L; AST 32 UI/L; Albúmina 3,8 g/dL; Hb 8 g/dL; Plaquetas 80.000 u/L; Leucocitos 5430 u/L. Usted solicita un frotis de sangre con presencia de más de 3 esquistocitos por campo. En relación a la patología que usted sospecha una es cierta:

1. Unos niveles elevados de haptoglobina en sangre y un test de Coombs negativo confirman que se trata de una anemia hemolítica microangiopática.
2. La presencia de esquistocitos es patognomónica de la púrpura trombótica trombocitopénica.
3. En caso de actividad de ADAMTS13 <10% estaría indicado el recambio plasmático +/- glucocorticoides.
4. En caso de confirmarse un caso de síndrome hemolítico urémico atípico, si la paciente no recupera función renal podría ser candidata a trasplante renal de donante vivo emparentado.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta: 3. La 1 es falsa, se asocia con niveles bajos de haptoglobina. La 2 es falsa, también se pueden ver en el resto de anemias hemolíticas microangiopáticas y en anemias hemolíticas mecánicas (por ejemplo asociadas a circulación extracorpórea, valvular etc). La 4 es falsa, en paciente con SHUa se sospecha siempre la presencia de mutaciones en la vía alternativa del complemento aunque no se puedan demostrar y dado que tiene agregación familiar se evita incluir a los familiares de estos pacientes como posibles donantes por si presentaran también una mutación de la vía alternativa del complemento.

157. En la hiperplasia benigna de próstata una de las afirmaciones es falsa:

1. Es una de las causas más frecuentes de consulta urológica.
2. El tumor vesical in situ puede simular un síndrome prostático.
3. La retención urinaria puede ser aguda o crónica.
4. La polaquiuria es un síntoma obstructivo o de vaciado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La polaquiuria se considera un síntoma de llenado o irritativo

158. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para presentar un tumor de testículo?:

1. Criptorquidia.
2. Síndrome de Klinefelter.
3. Tabaco.
4. Tumor testicular contralateral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El tabaco no se considera factor de riesgo para desarrollo de neoplasia testicular primaria.

159. Ante la presencia de una bacteriuria asintomática en una mujer qué debemos hacer:

1. Tratamiento con antibióticos, pauta de un día.
2. Tratamiento con antibióticos, pauta de tres días.
3. Tratamiento con antibióticos, pauta de siete días.
4. No administrar antibióticos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ante una bacteriuria asintomática en una mujer no embarazada no debe implementarse el tratamiento antibiótico.

160. Ante la llegada de un paciente politraumatizado al servicio de urgencias la primera actuación médica ha de ser:

1. Realización de angioTC para valorar lesiones de órganos internos.
2. Realización de ecografía abdominal para valorar lesiones de órganos internos.
3. Colocación de sonda urinaria para monitorizar diuresis.
4. Estabilización hemodinámica del paciente y colocación de vía periférica para perfusión de sueros.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En el abordaje del paciente politraumatizado lo primero que debemos comprobar es la estabilidad hemodinámica del paciente.

161. Mujer de 60 años con segunda recidiva de cáncer de mama con metástasis pulmonares, peritoneales y óseas, pendiente de inicio de nueva línea terapéutica. Previo al inicio del tratamiento, presenta anemia de nueva aparición y en el frotis de sangre periférica destaca la aparición de formas inmaduras (metamielocitos, mielocitos, cayados, dacriocitos, eritroblastos ortocromáticos y eritroblastos policromatófilos). Ante el cuadro que usted sospecha, ¿qué tratamiento elegiría?:

1. El cuadro impresiona de una leucemia aguda mieloblástica relacionada con la quimioterapia previa, por lo que debería iniciar un tratamiento con 3+7 y después tratar el cáncer de mama.
2. Debe realizarse una determinación de vitamina b12 y fólico debido a las células observadas en el frotis y, en caso de déficit nutricional, debe reponerse adecuadamente.
3. Impresiona de afectación metastásica de la médula ósea. Los tratamientos deben enfocarse en tratar el cáncer de mama.
4. Es probable que se trate de mieloptosis, debe diferirse el tratamiento del cáncer de mama hasta que las citopenias se recuperen.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el enunciado nos dicen que la paciente tiene un cáncer de mama que afecta, entre otros lugares, al hueso, por lo que hay altas probabilidades de que invada la médula ósea. El frotis hace referencia a una reacción leucoeritroblástica (opciones 1 y 2 incorrectas) y tenemos que sospechar una mieloptosis o infiltración metastásica de la médula ósea. El cuadro hematológico sólo se resolverá si tratamos la etiología, es decir, la invasión tumoral de la médula ósea, por lo que debemos enfocarnos en tratar el cáncer de mama (opción 3 correcta, opción 4 incorrecta).

162. Mujer de 59 años con anemia, neutropenia y trombocitosis. En frotis se ven rangos displásicos en las tres series. En el cariotipo destaca delección del 5q y en el aspirado de médula se cuantifican 14% de blastos, según la clasificación de la OMS 2022, ¿ante qué patología estamos y qué tratamiento elegiría?:

1. Se trata de un síndrome mielodisplásico 5q- por lo que inicio lenalidomida.
2. La paciente presenta una LAM por lo que debo iniciar quimioterapia intensiva y plantear un TPH.
3. Se trata de un SMD EB tipo 2, por lo que debo iniciar azacitidina para disminuir carga de enfermedad y después llevar a la paciente a TPH.
4. Es un SMD con sideroblastos en anillo, debe hacerse vigilancia de momento.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad intermedia. Ciertamente la paciente tiene delección del 5q pero si tiene blastos en médula, esto último es lo que más importa. Como tiene más de un 10% de blastos en MO se trata de un SMD EB tipo 2 y debe llevarse a la paciente a trasplante porque evolucionará a una leucemia aguda en poco tiempo. A muchos pacientes les tratamos antes con varios ciclos de azacitidina, puesto que permite ir al trasplante con menos enfermedad (siempre interesa ir al tph con la menor enfermedad posible) (opción 3 correcta).

163. La esplenomegalia es característica de los siguientes trastornos, EXCEPTO:

1. Anemia mielopóitica.
2. Leucemia mieloide crónica.
3. Síndrome de Felty.
4. Enfermedad de Gaucher.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Todos los procesos descritos cursan con esplenomegalia salvo la mielopóitica.

164. Varón de 40 años con diagnóstico de LAM FLT3 +, pendiente de iniciar tratamiento, elija la respuesta correcta:

1. Esta leucemia es de buen pronóstico, puesto que tenemos un inhibidor de FLT3, la midostaurina.
2. Se trata de una leucemia aguda de curso clínico agresivo, por lo que debe tratarse con quimioterapia asociada a midostaurina y luego ir a trasplante de progenitores hematopoyéticos.
3. Se trata de una leucemia con un buen curso clínico con quimioterapia intensiva y midostaurina, siendo el trasplante anecdótico.
4. Debe asociarse ivosidenib a la quimioterapia convencional. Realizar o no un TPH dependerá de la respuesta inicial.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre nuevas terapias en LAM. Las LAM que tienen mutación de FLT3 suelen ser leucemias agresivas hiperleucocitósicas (opción 1 incorrecta) que requieren de tratamiento con quimioterapia, inhibidor de FLT3 y posterior trasplante de progenitores hematopoyéticos (opción 2 correcta, opción 3 incorrecta). Como truco, recuerda que las leucemias con mutaciones de alto riesgo (aquellas que no sean NPM1 +, t(8;21), inv 16, t(15;17)) y las leucemias en recaída, necesitan de trasplante. Ivosidenib es un inhibidor de IDH, no de FLT3 (respuesta 4 incorrecta). Si has fallado esta pregunta no te desanimes, está pensada para que la falles y aprendas algo adicional del complejo mundo de las leucemias agudas. ¡Animo! Matías, Abel, Pablo.

165. De los siguientes anticuerpos con actividad clínica frente a distintas neoplasias hematológicas, señale cuál de los siguientes tiene indicación en el Linfoma de Hodgkin:

1. Brentuximab Vedotin.
2. Midostaurina.
3. Inotuzumab ozogamicina.
4. Blinatumumab.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

De todos los expuestos, Brentuximab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra CD30 que está indicado en el LH

refractario o en recaída. Midostaurina está indicada en LA mieloblástica con una mutación concreta, la FLT3. Inotuzumab es un anticuerpo monoclonal anti-CD22 y Blinatumomab es un anticuerpo biespecífico, que facilita la unión de linfocitos CD3+ a células tumorales CD19+. Estos dos últimos están aprobados en LA linfoblástica.

166. Mujer de 52 años, fumadora de unos 10 cigarrillos diarios y con antecedentes de hipertensión arterial, sobrepeso, enfermedad hepática metabólica y una psoriasis palmoplantar por la que se encuentra en seguimiento en su consulta. Ha realizado sucesivos tratamientos con corticoides tópicos, acitretina, metotrexato (suspendido por hepatotoxicidad) y adalimumab vía subcutánea 40 mg cada 2 semanas. Si bien con este último había presentado una excelente respuesta, acude por rebrote grave que limita mucho sus actividades diarias. En la analítica de sangre destacan niveles indetectables del fármaco con presencia de anticuerpos anti-adalimumab. Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes alternativas considera más razonable?:

1. Intensificar la pauta de adalimumab a 80 mg cada 14 días.
2. Insistir en cese de hábito tabáquico y pérdida de peso junto a tratamiento con deucravacitinib.
3. Dada la ausencia de mejoría con anti-TNF, plantearía cambio a un inhibidor de IL-17 o de IL-23 como nemolizumab.
4. Los inhibidores de JAK como upadacitinib o filgotinib serían la opción más adecuada en este caso.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los pacientes tratados con fármacos anti-TNF como infliximab o adalimumab desarrollan anticuerpos frente a los mismos con relativa frecuencia, lo que suele derivar en pérdida de eficacia tras meses de tratamiento. En este contexto, probablemente no resulte efectivo ni eficiente intensificar la dosis del fármaco (respuesta 1 incorrecta) sino que es preferible cambiar de diana terapéutica. Serían alternativas válidas los anti-IL17 (excepto si la paciente tuviera una enfermedad inflamatoria intestinal), los anti-IL23 o el deucravacitinib (inhibidor de TYK2, parte de la familia JAK). Ni el nemolizumab (inhibidor de IL-31 próximamente disponible para el tratamiento de la dermatitis atópica grave) ni los inhibidores de JAK mencionados tienen indicación en psoriasis, aunque el upadacitinib sí la tiene en artritis psoriásica (respuestas 3 y 4 incorrectas).

167. Varón de 16 años que consulta por acné en tronco y espalda de 3 años de evolución. Presenta comedones abiertos y cerrados, pápulas, pústulas, y escasos nódulos y quistes en ramas mandibulares y espalda. Respecto al tratamiento del acné, ¿Cuál es correcta?:

1. Podría iniciar tratamiento con antibiótico tópico, por ejemplo eritromicina en toallitas o en gel durante 3-6 meses, y si no mejora plantear tratamiento oral.
2. Si precisa tratamiento oral, una opción adecuada sería doxiciclina 100 mg diarios durante una semana e indicar la extirpación quirúrgica de los nódulos más inflamatorios.
3. Se podría pautar doxiciclina oral hasta 3 meses, y si no es suficiente, asociar isotretinoína.
4. Ninguna es correcta.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Ninguna es correcta. No se recomienda el uso de antibióticos tópicos en monoterapia por riesgo de resistencias. En el caso que nos cuentan impresiona de que va a precisar tratamiento oral para su control, pero doxiciclina durante una semana sería muy probablemente insuficiente. Los antibióticos orales que se utilizan para acné (tetraciclinas, macrólidos) tienen también un papel antiinflamatorio y precisan tiempos mayores. Una pauta frecuente es doxiciclina hasta 3 meses, aunque tampoco se debe abusar de los antibióticos orales. La opción 3 es falsa porque si precisa tratamiento con isotretinoína nunca deben asociarse por riesgo de efectos secundarios (como la hipertensión intracraneal benigna), por lo que lo correcto sería suspender doxiciclina y pautar la isotretinoína.

168. Un hombre de 62 años con hipertiroidismo por bocio multinodular tóxico, sin oftalmopatía, presenta un episodio de fibrilación auricular paroxística. ¿Cuál sería el tratamiento definitivo más apropiado en este caso?:

1. Tratamiento con radioyodo.
2. Tiroidectomía total.
3. Antitiroideos de síntesis de forma indefinida.
4. Betabloqueantes únicamente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En bocio multinodular tóxico, especialmente en pacientes mayores o con complicaciones cardíacas (fibrilación auricular), la opción terapéutica preferida es el tratamiento con radioyodo, por su eficacia y menor morbimortalidad asociada respecto a la cirugía, que quedaría reservada a casos en los que haya existan además clínica compresiva y/o sospecha de malignidad.

169. Atiende en la consulta a un varón de 65 años con antecedentes de HTA, extabaquismo, obesidad, gonartrosis bilateral, EPOC no agudizador, aneurisma de aorta abdominal, litiasis renal, e hiperplasia benigna de próstata. Presenta un análisis con glucemia 106, perfil hepático y renal, y hemograma normales. El perfil lipídico muestra colesterol total 220, LDLc 150, HDLc 40, TG 180. Usted le calcula el SCORE2 obteniendo un riesgo de eventos vasculares a 10

años del 9,3%. Con esta información, señale la respuesta correcta:

1. El riesgo cardiovascular de este paciente es alto. Su objetivo de control LDLc es <100 mg/dL, estaría indicado iniciar estatina.
2. El riesgo cardiovascular de este paciente es alto. Su objetivo de control LDLc es <70 mg/dL, estaría indicado iniciar estatina.
3. El riesgo cardiovascular de este paciente es muy alto. Su objetivo de control LDLc es <70 mg/dL, estaría indicado iniciar estatina.
4. El riesgo cardiovascular de este paciente es alto. Su objetivo de control LDLc es <55 mg/dL, estaría indicado iniciar estatina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

No caigas en la trampa. Independientemente del SCORE calculado, un paciente con un aneurisma de aorta abdominal puede considerarse de muy alto riesgo por tener enfermedad cardiovascular establecida. Su objetivo de control es LDLc <55 mg/dL y amerita una estatina.

170. Varón de 48 años, gran fumador, sin antecedentes de enfermedades previas. Consulta en Atención Primaria por malestar general, con astenia, mareo frecuente, torpeza motora inespecífica, y calambres. En la exploración física tiene TA 132/78, FC 86 lpm, SatO₂ 64%; auscultación cardíaca y exploración neurológica normales, salvo enlentecimiento de la velocidad de la marcha y aumento de la base de sustentación en reposo, sin lateropulsión ni Romberg. En el análisis, presenta glucemia 112 mg/dL, urea 20 mg/dL, creatinina 0.98 mg/dL, sodio 124 mEq/L, potasio 4.2 mEq/L. Sospecha usted un SIADH y solicita una batería de estudios complementarios. Tan solo uno de los siguientes perfiles sería compatible con diagnóstico de SIADH:

1. Sodio urinario 60 mEq/L, Osmolaridad urinaria 150 mOsm/Kg, ácido úrico sérico 5 mg/dL.
2. Sodio urinario 60 mEq/L, Osmolaridad urinaria 150 mEq/L, ácido úrico sérico 1.5 mg/dL.
3. Osmolaridad sérica 280 mOsm/Kg, Sodio urinario 60 mEq/L, Osmolaridad urinaria 150 mEq/L.
4. Osmolaridad sérica 240 mOsm/Kg, Sodio urinario 20 mEq/L, Osmolaridad urinaria 350 mEq/L.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El diagnóstico de SIADH es complejo, requiere la concordancia bioquímica con el SIADH y la exclusión de otras enfermedades que puedan simularlo. Los criterios mayores (por así decirlo) de SIADH son la presencia de hiponatremia (Na <135 mEq/L) hipoosmolar (Osmolaridad sérica <275 mOsm/Kg) con normalidad del volumen extracelular,

y sodio y osmolaridad urinaria inadecuadamente elevados. El sodio urinario debe ser > 40 mEq/L, y la osmolaridad > 100 mOsm/Kg, que es inadecuadamente alta pero no alta en valores absolutos. Hay otros criterios bioquímicos que podríamos denominar menores, pues no son universales, como la urea o el ácido úrico bajos en sangre, o la excreción fraccional de urea $< 55\%$; son específicos, pero poco sensibles. Por ello, la opción con NaO 60, OsmO 150 y uricemia normal es la única compatible. La opción con osmolaridad urinaria 150 mEq/L y uricemia baja es incorrecta, pues la osmolaridad se mide en mOsm(Kg, no en mEq/L.

171. Mujer de 32 años con astenia, pérdida ponderal, hiperpigmentación cutánea y presión arterial baja. Se sospecha insuficiencia suprarrenal primaria (enfermedad de Addison). ¿Qué patrón bioquímico apoyaría este diagnóstico?:

1. Cortisol bajo, ACTH elevada, potasio elevado, sodio bajo.
2. Cortisol alto, ACTH baja, potasio normal, sodio normal.
3. Cortisol bajo, ACTH baja, potasio elevado, sodio bajo.
4. Cortisol alto, ACTH elevada, potasio normal, sodio bajo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La insuficiencia suprarrenal primaria (enfermedad de Addison) se caracteriza por daño en las glándulas suprarrenales, causando déficit de cortisol y aldosterona. Al faltar cortisol, el eje hipotálamo-hipófisis se activa intensamente tratando de compensar la pérdida, elevándose mucho la ACTH. El exceso de ACTH provoca aumento secundario de la hormona estimuladora de melanocitos (MSH), generando la típica hiperpigmentación cutánea. Por otra parte, la ausencia de aldosterona causa pérdida de sodio (por lo que aparece hiponatremia) y acumulación de potasio (hiperpotasemia). Esto diferencia claramente la insuficiencia suprarrenal primaria de la secundaria (de causa hipofisaria o hipotalámica), donde no suele haber alteraciones electrolíticas ni pigmentación.

172. Mujer de 39 años con hipertensión arterial resistente de 6 años de evolución, episodios de debilidad muscular, parestesias y cefalea intermitente. En la analítica presenta hipopotasemia leve persistente, alcalosis metabólica leve y niveles plasmáticos bajos de actividad renina. En este contexto, ¿qué prueba diagnóstica solicitaría a continuación para confirmar la sospecha clínica inicial?:

1. Test de estimulación con captopril y determinación de aldosterona plasmática.
2. Test de infusión salina rápida con determinación posterior de cortisol plasmático.
3. Determinación plasmática de angiotensina II tras administración de losartán.

4. Determinación plasmática de aldosterona y cálculo del cociente aldosterona/renina plasmática.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En este caso clínico, la hipertensión resistente con hipopotasemia persistente, alcalosis metabólica y actividad plasmática de renina baja orientan hacia un hiperaldosteronismo primario. La prueba inicial y más ampliamente aceptada es la determinación plasmática de aldosterona y el cálculo del cociente aldosterona/renina plasmática (elevado en este caso). El test de captopril es una prueba complementaria utilizada en casos seleccionados y requiere medir tanto aldosterona como renina plasmática tras administrar captopril. En el hiperaldosteronismo primario, tras administrar captopril, la aldosterona plasmática no se suprime (permanece elevada), mientras que la renina sí aumenta por bloqueo del eje RAA. Por tanto, la opción 1 es parcialmente correcta pero incompleta, ya que solo menciona medir aldosterona. Las otras opciones no son adecuadas ni validadas para confirmar esta sospecha diagnóstica.

173. Valora usted a un paciente de 45 años con antecedente de ex-enolismo y pancreatitis crónica enólica. Mide 172 cm y pesa 57 kg, por lo que su índice de masa corporal es de 19,3 kg/m². Señale la respuesta correcta:

1. Con la información que disponemos, no podemos confirmar ni descartar el diagnóstico de desnutrición.
2. El paciente presenta un IMC bajo para su edad, que junto con la presencia de una enfermedad crónica, son criterios suficiente para diagnosticar relacionada con la enfermedad (1 criterio fenotípico y 1 criterio etiológico GLIM).
3. Sería necesario realizar algunas determinaciones analíticas para confirmar la presencia o no de desnutrición en este paciente.
4. El índice de masa corporal es normal. El paciente no presenta ningún dato de desnutrición.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los criterios GLIM son actualmente los criterios de consenso más empleados para diagnosticar la desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE). Aunque las determinaciones analíticas son importantes y aportan información, no son necesarias para el diagnóstico de DRE. A priori este paciente puede parecer que cumple criterios de DRE (GLIM: bajo IMC y enfermedad crónica), pero NO podemos afirmar que tenga desnutrición. Esto es así porque, para poder aplicar los criterios GLIM, previamente debe haberse realizado un cribado nutricional con una escala validada (MST, MUST, MNAsf...). Aunque pueda parecer un detalle poco importante, este cribado previo es fundamental ante un paciente con bajo peso. Un paciente que siempre ha sido constituti-

vamente delgado, con IMC bajo, pero que come bien y tiene un peso estable, no va a estar desnutrido sólo por el hecho de tener una enfermedad crónica. Recuerda: el diagnóstico de DRE se realiza en dos pasos, cribado nutricional con escala validada, seguido de los criterios GLIM.

174. Acude a Consulta de Riesgo Vascular un paciente de 57 años, no fumador, con vida sedentaria y obesidad de perfil abdominal, hipertenso en tratamiento con combinación enalapril+amlodipino. Tras la evaluación clínica y analítica completa, usted diagnostica síndrome metabólico con riesgo cardiovascular moderado, SCORE 3%. Con respecto al síndrome metabólico, tan sólo una es correcta:

1. Sus criterios diagnósticos están en continua revisión.
2. Existen tratamientos de eficacia cardiovascular selectiva para el síndrome metabólico.
3. Se discute si la presencia de diabetes tipo 2 es criterio o no de síndrome metabólico.
4. El diagnóstico implica la indicación de tratamiento hipolipemiente con estatinas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El síndrome metabólico es un complejo nosológico derivado de la obesidad abdominal, con un perfil lipídico típico y aumento de riesgo de hipertensión, diabetes y eventos cardiovasculares. Su diagnóstico no ha variado en los últimos años (definiciones ATP-III de 2004 e IDF de 2009), pero a día de hoy se discute si la presencia de DM tipo 2 debe no ser criterio diagnóstico, pues la utilidad principal del síndrome metabólico es identificar a pacientes con aumento de riesgo cardiovascular y de diabetes. El manejo cardioprotector de estos pacientes consiste en un abordaje multifactorial, similar al de cada componente del síndrome por separado, no existiendo fármacos específicos. El síndrome metabólico no constituye indicación de tratamiento hipolipemiente, pero sí que es un factor potenciador de riesgo, pudiendo “empujar” la indicación o dosis de hipolipemiente basada en el riesgo cardiovascular individual por SCORE.

175. Hombre de 65 años con antecedentes de HTA, DM-2, dislipemia, hígado graso y tabaquismo activo. Actualmente está en tratamiento con enalapril/hidroclorotiazida, atorvastatina, metformina y pioglitazona, con buen control. Ingresa en la Unidad Coronaria tras cateterismo urgente por SCACEST realizándose ICP con colocación de stent en descendente anterior y circunfleja. En la ecografía de control pre-alta se objetiva una FEVI de 35%. Su ingreso ha sido prolongado ajustándose su tratamiento, iniciando AAS, ticagrelor, espironolactona, bisoprolol y cambiando su antihipertensivo por sacubitrilo/valsartán. Para control glucémico ha estado con insulina SC. Respecto al resto de su tratamiento de cara al alta, usted sabe que:

1. Mantendrá el resto de su tratamiento habitual sin cambios, dado que el paciente estaba bien controlado.
2. Mantendrá el resto de su tratamiento habitual añadiendo semaglutide, dado que el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida.
3. Añadirá empagliflozina manteniendo el resto de su tratamiento.
4. Sustituirá la pioglitazona por empagliflozina manteniendo el resto de su tratamiento.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos encontramos ante un paciente con DM-2 entre otros FRCV que ha tenido un SCACEST que se ha revascularizado y tras el evento ha quedado con una FEVI deprimida. Cuando el paciente está estable y se le da el alta llega el momento de reintroducir sus antidiabéticos pensando tanto en las características que tenía previamente el paciente como las actuales, analizando los fármacos en función de efectos beneficiosos y adversos que puedan proporcionarle. Aunque el semaglutide puede ser a priori una buena opción al tener el paciente una enfermedad cardiovascular establecida (SCACEST), el paciente presenta además insuficiencia cardíaca con FEVI reducida. Los arGLP1 solo han demostrado beneficio en ICC con FEVI preservada. Debemos buscar una opción más adecuada (respuestas 1 y 2 falsas), se podría añadir más adelante el arGLP1. La mejor opción es añadir un iSGLT2 que ha demostrado beneficio en ICC con FEVI deprimida (también en conservada). También conviene suprimir en pacientes con ICC la pioglitazona por la tendencia a retención hidrosalina que tienen, lo que causaría descompensaciones, sobre todo cuando la FEVI está disminuida como es el caso (respuesta 3 incorrecta, respuesta 4 correcta).

176. Varón de 55 años con HTA, DM2, y claudicación intermitente. Presenta un dislipemia mixta con hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia en tratamiento. Actualmente el control glucémico y tensional es adecuado. Recibe tratamiento con atorvastatina/ezetimiba y presenta el siguiente perfil lipídico: colesterol total 120; HDLc 42 mg/dL; TG 350 mg/dL; LDLc no calculable. ¿Cuál de las siguientes opciones le parece más adecuada?:

1. Añadir un fibrato.
2. Añadir ácido bempedoico.
3. Añadir ácido eicosapentanoico.
4. Añadir evolocumab.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente con muy alto riesgo vascular y por tanto objetivo LDLc <55 mg/dL. Debido a la hiperTG, la LDLc no es calculable, por lo que tenemos que valorar el colesterol no-HDL (col total - col HDL), cuyo objetivo en pacientes de muy alto riesgo es <85 mg/dL. Nuestro paciente tiene un col no-HDL de 78 mg/dL, y por tanto no es ne-

cesaria la actuación sobre el colesterol LDL (opciones 2 y 4 incorrecta). Los fibratos no están generalmente indicados con TG<500 mg/dL (opción 1 incorrecta), pues el riesgo de pancreatitis es bajo, y no aportan beneficio cardiovascular. Sin embargo, los ácidos grasos omega 3 pueden ser beneficiosos en pacientes de muy alto riesgo vascular cuyo LDLc (en este caso col no-HDL) está bien controlado, pero en el que los TG sean >200 mg/L, como es nuestro caso.

177. En relación con la endocarditis asociada a marcapasos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

1. El microorganismo más frecuentemente implicado es el *S. aureus*.
2. La fiebre sin foco evidente debe hacer sospechar infección del sistema en pacientes portadores de marcapasos.
3. La extracción completa del sistema es el tratamiento de elección.
4. La realización de un PET puede ayudar en el diagnóstico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En las endocarditis asociadas a dispositivos el agente causal más frecuente es el *S. epidermidis*. El resto de opciones son correctas.

178. Mujer de 60 años que consulta por fiebre de 38°C y clínica urinaria. En la exploración se objetiva bajo nivel de conciencia, frecuencia respiratoria de 24 rpm, tensión arterial 80/40 mmHg, frecuencia cardiaca 120 lpm y saturación oxígeno de 89%. Indique la respuesta correcta:

1. La determinación de ácido láctico es diagnóstico pero no indica evolución.
2. Los hemocultivos son positivos en el 90 % de los casos.
3. La comorbilidad no se asocia a mayor mortalidad.
4. La infección del tracto urinario generalmente se asocia con las tasas de mortalidad más bajas que otras localizaciones.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente con sepsis de origen urinario. Dentro de los focos infecciosos la infección urinaria presenta menos mortalidad. Se asocia más mortalidad en la sepsis la comorbilidad y la edad. Recuerda que entre los biomarcadores ninguno es diagnóstico de sepsis, pero su valor y su evolución son pronósticas. Los hemocultivos son positivos solo en el 30-40% de los casos de sepsis, no obstante se deben recoger en todos los casos.

179. ¿A cuál de los siguientes pacientes recomendarías el uso de profilaxis preexposición (PrEP)?:

1. Varón no infectado por el VIH cuya pareja habitual (cerrada) es un varón con infección conocida por el VIH y que mantiene carga viral indetectable.
2. Varón con infección por el VIH sin pareja habitual que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres, unas 10 al mes, y no utiliza preservativo habitualmente.
3. Varón no infectado por VIH, sin pareja habitual, que tiene relaciones sexuales con hombres y mujeres, unas 10 al mes, y no utiliza preservativo habitualmente y que ha sido diagnosticado de linfogranuloma venéreo en el último año.
4. Mujer sin pareja con relaciones sexuales esporádicas, unas 8 al año, sin preservativo y sin haber padecido una ITS nunca.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los criterios de PrEP son: 1. Trabajadoras del sexo que refieran un uso no habitual de preservativo. 2. HSH, transexuales, mujeres y hombres cissexuales, o usuarios de drogas inyectadas con prácticas de inyección no seguras, que refieran un uso no habitual del preservativo y que cumplan al menos 2 de los siguientes criterios: Más de 10 parejas sexuales diferentes en el último año. Practica sexo anal sin protección en el último año. Uso de drogas relacionado con el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección en el último año. Administración de profilaxis post-exposición en varias ocasiones en el último año. Al menos una ITS bacteriana en el último año, o infección por virus de la hepatitis C. Entre todas las opciones, la persona de la opción 3 es quien cumple los criterios. En un paciente con infección ya conocida por el VIH no tiene sentido usar PrEP (opción 2 falsa), mientras que en casos de pareja cerrada serodiscordante, si la CV está indetectable, tampoco (indetectable = intransmisible).

180. ¿Cuál de los siguientes pacientes asintomáticos NO es subsidiario de realizar cribaje de infecciones de transmisión sexual en la situación que se describe?:

1. A cualquier persona con una pareja única de larga duración y mutuamente exclusiva al comienzo de la relación.
2. Mujer cis heterosexual de 24 años con más de 10 parejas sexuales en los últimos 12 meses.
3. Personas usuarias de PrEP cada 3-6 meses.
4. Persona perteneciente al subgrupo de población LGTBI con pareja estable cerrada. Realizar cribado una vez al año.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En personas asintomáticas está recomendado el cribado de ITS en: a) A cualquier persona con una pareja única de larga duración y mutuamente exclusiva: se recomienda testar al comienzo de la relación. b) Personas sexualmente activas:

se recomienda un cribado anual y tras cambiar de pareja hasta un máximo de una vez al trimestre. c) Personas sexualmente activas con riesgo elevado de ITS (usuarios de PrEP, más de 10 parejas sexuales en los últimos 12 meses, múltiples o anónimas parejas sexuales desde la última ITS, uso sexualizado de drogas o primer año tras una ITS): podría recomendarse cada 3 meses. Es importante destacar que tener VIH o pertenecer al subgrupo de GBHSH, personas trans u otras poblaciones diversas no se puede utilizar de forma aislada como criterio para valorar el riesgo de adquisición de ITS, salvo que coexistan otros factores asociados.

181. Respecto a la infección genital por *Neisseria gonorrhoeae* es cierto:

1. En varones con secreción uretral la presencia en la tinción de Gram de diplococos gramnegativos en el interior de polimorfonucleares tiene una elevada sensibilidad y especificidad como prueba diagnóstica rápida.
2. La microscopía tiene una elevada sensibilidad en varones asintomáticos y en la infección endocervical y rectal, lo que la convierte en una buena prueba de exclusión en estas situaciones.
3. En las infecciones en la mujer la muestra de orina es la muestra más sensible.
4. El cultivo es barato, específico y permite la confirmación diagnóstica, pero su realización no debe ser rutinaria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La tinción de Gram para el diagnóstico de uretritis gonocócica es muy sensible y específica solo en los casos de uretritis sintomática del varón, ya que en casos de varones asintomáticos o en la mujer la sensibilidad disminuye, convirtiéndola en una prueba poco útil para el diagnóstico. Para el diagnóstico de la uretritis/cervicitis en la mujer la prueba de elección es la PCR, preferiblemente en exudado endocervical (como alternativas se pueden usar la secreción vaginal o la orina del primer chorro miccional, menos sensibles); el cultivo sólo puede realizarse en el exudado endocervical. Siempre se debe cultivar para determinar el patrón de resistencias en el antibiograma.

182. Varón de 38 años que cuatro días después de regresar de viaje de Tailandia comienza con fiebre de 38.5°C, cefalea, artromialgias generalizadas y exantema maculopapular, eritematoso y pruriginoso en abdomen y ambas piernas. El paciente había realizado correctamente la profilaxis antipalúdica. Analítica: Hb 14 g/dl, leucocitos 3200/mm³, plaquetas 89000/mm³, AST 72, ALT 89. Frotis y gota gruesa negativos. Se realiza antígeno NS1 que resultó positivo. Respecto a la enfermedad que sospecha, señale la correcta:

1. Recomendaría tratamiento sintomático con ibuprofeno.

2. La recuperación de la infección otorga inmunidad de por vida contra el serotipo que la ha causado.
3. La persistencia de la fiebre de más de 48h de evolución es un signo de alarma.
4. La sensibilidad del antígeno frente a NS1 es mayor en las infecciones secundarias que en las primarias.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un caso de dengue. Se cree que la recuperación de la infección otorga inmunidad de por vida contra el serotipo que ha causado la infección (respuesta 2 correcta). Sin embargo, la inmunidad cruzada a los otros serotipos tras la recuperación es solo parcial y temporal. Las infecciones posteriores (secundarias) causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer formas graves de dengue. El uso de AINEs en el dengue debe evitarse por su efecto antiagregante y su potencial para aumentar el riesgo de sangrado (respuesta 1 falsa). La persistencia de fiebre durante 48h no es un criterio de alarma; algunos que sí lo son: vómitos persistentes, derrame pleural o ascitis, dolor o distensión abdominales, irritabilidad, hepatomegalia > 2 cm, aumento del hematocrito y descenso rápido del recuento plaquetario... La sensibilidad del antígeno NS1 desciende en infecciones secundarias (respuesta 4 falsa).

183. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA con respecto a la lefamulina?:

1. Es una buena opción para el tratamiento de la neumonía comunitaria.
2. Tiene actividad frente SAMR y neumococo resistente.
3. Actúa sobre la subunidad 30s del ribosoma.
4. Tiene vía oral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La lefamulina es un antibiótico con actividad frente a gram positivos (incluyendo SARM y *S. pneumoniae* resistente) y atípicos. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas bacterianas en el ribosoma (subunidad 50S); puede administrarse vía oral y ha demostrado ser no inferior a moxifloxacino en el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Debe evitarse en pacientes con disfunción hepática ≥ moderada a grave, QT largo o toma de otros fármacos que alarguen el QT, mujeres embarazadas y lactantes, y mujeres con potencial reproductivo que no utilicen anticonceptivos.

184. Mujer de 68 años con antecedentes de HTA, DM, portadora de válvula protésica aórtica metálica que se ha sometido recientemente a manipulación odontológica que acude a urgencias por presentar fiebre de 38° C de 2 días de evolución sin presentar clínica respiratoria ni urinaria ni otra focalidad infecciosa aparente. En la exploración física presenta: constantes: TA 101/54 mmHg, FC 103 lpm, FR 18 rpm,

SatO2 95%, Tª 37,9° C. AC: soplo sistólico en foco aórtico no presente previamente. AP: MVC. Abdomen blando no doloroso. MMII: leve edema bimalleolar. Aunque hemos pedido a cardiología un ecocardiograma, todavía no tenemos los resultados. Se han recogido hemocultivos. Con respecto a la actitud terapéutica a seguir en este momento, ¿cuál de las siguientes actuaciones le parece más correcta en espera de los resultados de las pruebas?:

1. Iniciar tratamiento antibiótico empírico con daptomicina + gentamicina + rifampicina.
2. Iniciar tratamiento antibiótico empírico con cloxacilina + gentamicina + ampicilina.
3. Dado que la paciente está estable podemos esperar a los resultados del ecocardiograma y hemocultivos para comenzar antibioterapia dirigida.
4. Avisar a cirugía cardíaca dado que tiene indicación de cirugía emergente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se trata de una paciente que acude a urgencias por fiebre, hipotensión y taquicardia, no se encuentra foco aparente pero tiene antecedentes de ser portadora de válvula protésica y presentar un nuevo soplo (recuerda que en ausencia de ecocardiograma, es un criterio menor). Este soplo junto con el antecedente predisponente y la fiebre, suman 3 criterios menores por lo que cumple criterios de endocarditis posible. La paciente tiene una endocarditis aguda y está inestable por lo que deberíamos de comenzar tratamiento antibiótico empírico a la espera de resultados. Sobre válvula protésica el tratamiento empírico de elección es la vancomicina o daptomicina + rifampicina + gentamicina. Los criterios de cirugía emergente es la presencia de edema agudo de pulmón, shock cardiogénico o datos de insuficiencia cardíaca NYHA IV.

185. Un varón de 47 años diagnosticado hace 6 meses de un cáncer de pulmón. Acude a Urgencias con una neutropenia (310 neutrófilos/mm3) febril sin foco aparente. A los 3 días el paciente está afebril y los cultivos son negativos. Señale lo CORRECTO sobre la duración del tratamiento antibiótico:

1. El paciente debe recibir un total de 14 días de tratamiento antibiótico.
2. El paciente debe recibir tratamiento antibiótico hasta que la cifra de neutrófilos alcance 1000/mm3.
3. En la situación descrita es suficiente con completar 5 días de tratamiento antibiótico.
4. Dado que es un cáncer de pulmón y el foco más probable es respiratorio el tratamiento debe ser de 10 días.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La duración del tratamiento debe individualizarse y basarse en criterios de estabilidad clínica, con un mínimo de 5 días y pudiéndose suspender tras 48h de ausencia de fiebre y sin signos de inestabilidad. En caso de neumonía necrosante, absceso pulmonar, microorganismos no comunes (*Pseudomonas*, *S. aureus*, anaerobios...) se debe prolongar el tratamiento. La procalcitonina puede ser útil en la toma de decisiones en la duración del tratamiento. En caso de usar macrólidos las pautas son de 3 días.

186. Una paciente de 75 años ingresada por colecistitis aguda comienza con diarrea y fiebre en el quinto día de tratamiento con piperacilina-tazobactam, con buena tolerancia oral. Sus antecedentes médicos son diabetes mellitus tipo 2, hipotiroidismo y valvulopatía mitral con fibrilación auricular permanente. La toxina de *Clostridioides difficile* en heces es positiva, y en la analítica destaca una creatinina sérica de 1.9 mg/dl (siendo la previa 0.8 mg/dl), 19.580 leucocitos/microl y un lactato sérico normal. La paciente mantiene cifras de tensión arterial normales. Señale lo correcto sobre este caso:

1. La presencia de fiebre, leucocitosis > 15.000 cels, y aumento de la creatinina sérica > 50% de su valor basal definen el caso como fulminante.
2. La edad no es un factor de riesgo de infección grave.
3. La paciente presenta factores de riesgo de recurrencia, por lo que se debe considerar el uso de fidaxomicina.
4. Se deben administrar vancomicina intravenosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un caso de diarrea por *C. difficile*. Recuerda que la primera elección de tratamiento según las guías vigentes es la fidaxomicina, siendo alternativa la vancomicina por vía oral (por vía intravenosa no es capaz de llegar a la luz del tubo digestivo). Dado el precio elevado de la fidaxomicina en nuestro medio se prioriza para aquellos pacientes con mayor riesgo de recurrencia. Los factores de mal pronóstico son: la edad avanzada (>65), hipoalbuminemia, leucocitosis e incremento de la creatinina sérica. Se define como diarrea fulminante aquella que se acompaña de hipotensión o shock, íleo o megacolon.

187. La pauta de elección de la tuberculosis sensible es rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol durante 2 meses seguido de rifampicina + isoniazida durante 4 meses. Recientemente otras pautas más sencillas han demostrado también efectividad para el tratamiento de la tuberculosis sensible. De las siguientes a continuación hay una que NO es una pauta para el tratamiento de la tuberculosis sensible, indíquela:

1. Isoniazida + pirazinamida + rifapentina + moxifloxacino durante 2 meses, seguido de isoniazida + rifapentina + moxifloxacino durante 9 semanas.
2. Isoniazida + rifampicina + etambutol 2 meses, seguido de isoniazida + rifampicina 7 meses.
3. Bedaquilina + linezolid + isoniazida + pirazinamida + etambutol durante 8 semanas.
4. Bedaquilina + pretomanid + linezolid durante 6 meses.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recientemente existe una pauta alternativa para la tuberculosis sensible que incluye: rifapentina (RP) (no comercializada en España) + moxifloxacino + H + Z durante 8 semanas, seguido de rifapentina + moxifloxacino + H durante 9 semanas. Esta pauta puede ser útil en casos de VIH con linfocitos CD4 >100/μL con TAR que incluya efavirenz y en menores de 16 años con tuberculosis pulmonar leve (radiografía normal, afectación de un lóbulo sin cavitación), afectación ganglionar intratorácica o derrame pleural. En caso de no poderse utilizar pirazinamida (por intolerancia, efecto adverso o contraindicación), se puede usar la pauta de rifampicina + isoniazida + etambutol 2 meses seguido de rifampicina + isoniazida 7 meses. Además, recientemente se ha demostrado que en la tuberculosis sensible la estrategia de tratamiento con bedaquilina + linezolid + isoniazida + pirazinamida + etambutol durante 8 semanas es no inferior al tratamiento estándar para conseguir la curación clínica. No obstante, hubo una tasa de recidivas mayor, por lo que actualmente no sustituye a la pauta habitual. En caso de MDR con resistencia a quinolonas (pre-XDR) se usará la pauta: bedaquilina + pretomanid + linezolid durante 6 meses, pero esta pauta no constituye una pauta alternativa para la tuberculosis sensible.

188. Un paciente es diagnosticado de infección por VIH con CD4+ de 50 células/ml, carga viral 675000 copias/ml y tuberculosis pulmonar. Se realiza un Xpert MTB/RIF de Mycobacterium tuberculosis, sin resistencia a rifampicina. ¿Cuál de las siguientes es la actitud correcta?:

1. Iniciar tratamiento con rifampicina + isoniazida + etambutol + pirazinamida junto con tratamiento antirretroviral con efavirenz/TDF/FTC.
2. Iniciar tratamiento con rifampicina + isoniazida + etambutol + pirazinamida y esperar dos semanas para iniciar darunavir/cobicistat + TAF/FTC.
3. Iniciar tratamiento con rifampicina + isoniazida + etambutol + pirazinamida y retrasar el tratamiento antirretroviral hasta completar la fase de inducción.
4. Iniciar tratamiento con rifampicina + isoniazida + etambutol + pirazinamida y, si no hay efectos adversos, iniciar a las dos semanas raltegravir + TDF/FTC + prednisona 40 mg.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Paciente VIH muy inmunodeprimido con tuberculosis pulmonar: el manejo debe realizarse primero tratando la tuberculosis y, si no hay eventos adversos, debe iniciar el TAR en las 2 semanas siguientes. Al tener menos de 100 CD4+ está indicado asociar corticoides para evitar el desarrollo de un SIRS. Entre las pautas de TAR en la tuberculosis se prefieren el uso de 2 ITIAN + EFV/RAL/DTG. Recuerda que en caso de meningitis tuberculosa el TAR debe retrasarse 4 semanas.

189. ¿Cuál de las siguientes modificaciones farmacocinéticas es característica del envejecimiento y puede aumentar la semivida de los fármacos lipofílicos en el anciano?:

1. Aumento del aclaramiento hepático por flujo.
2. Aumento del volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles.
3. Disminución del agua corporal total y aumento de la masa magra.
4. Aumento de la proporción de grasa corporal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Vamos a ir una a una. La respuesta 1 es falsa porque los hepatocitos (igual que todas las células en el anciano) van muriendo, por lo tanto, el aclaramiento/metabolismo hepático no aumenta, sino disminuye. La respuesta 2 es falsa también porque en los ancianos hay menos volumen de agua, por lo que la distribución de los fármacos hidrosolubles es menor. Por el contrario, hay más grasa, por lo que el volumen de distribución de los fármacos liposolubles es aún mejor (respuesta 4 verdadera). La respuesta 3 es falsa porque, aunque en el anciano disminuye el agua corporal total, la masa magra (músculo, huesos, densidad de los órganos...) no aumenta, sino que disminuye también.

190. Una pareja acude a la consulta de genética para asesoramiento reproductivo. La mujer tiene antecedentes familiares de hemofilia A. ¿Cuál es el riesgo de que su hijo varón padezca hemofilia A si ella es portadora?:

1. 0%.
2. 25%.
3. 50%.
4. 100%.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La hemofilia A es un trastorno de coagulación sanguínea con herencia recesiva ligado al cromosoma X. Esto significa que: Las mujeres tienen dos cromosomas X (XX), por lo que pueden ser portadoras del gen defectuoso sin manifestar la enfermedad si el otro cromosoma X tiene una copia funcional del gen. Los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y (XY), por lo que si heredan el gen defectuoso en su cromosoma X, desarrollarán la hemofilia. En este caso, si la mujer es portadora (es decir, tiene un cromosoma

X con el gen defectuoso y otro normal), existe un 50% de probabilidad de que transmita el gen defectuoso a su descendencia. Por lo tanto: Si tienen un hijo varón, hay un 50% de probabilidad de que herede el cromosoma X con el gen defectuoso y, por lo tanto, padezca hemofilia A. Si tienen una hija, hay un 50% de probabilidad de que sea portadora, como su madre.

191. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

1. El síndrome de inmovilidad en el paciente anciano puede predisponer al ortostatismo y al aumento de frecuencia cardíaca tanto a nivel basal como con el esfuerzo.
2. Los criterios START recomiendan el uso de estrógenos tópicos vía vaginal para aliviar los síntomas de la vaginitis atrófica en la mujer anciana.
3. Los criterios STOP recomiendan no iniciar/suspender antihistamínicos de segunda generación, AINES y anticolinérgicos.
4. El proceso de envejecimiento conlleva entre otras cosas un descenso en la producción de acetilcolina, lo cual tiene consecuencias tanto a nivel de la memoria como del funcionamiento del sistema nervioso autónomo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La respuesta 3 es incorrecta porque los fármacos que los criterios STOP recomiendan suspender son los antihistamínicos de PRIMERA generación, no de segunda. Esto se debe a que los antihistamínicos de primera generación atraviesan la BHE y generan somnolencia. Los de segunda generación, por el contrario, no la atraviesan y no tienen este efecto secundario. Todas las demás afirmaciones son puramente verdaderas.

192. Varón de 82 años que acude a consulta por debilidad progresiva y caídas ocasionales en los últimos 6 meses. Refiere dificultad para levantarse de la silla sin apoyarse. En la exploración evidenciamos masa muscular disminuida en extremidades inferiores y fuerza prensil disminuida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la sarcopenia en el anciano?:

1. La sarcopenia solo se diagnostica cuando coexiste con desnutrición calórico-proteica.
2. La disminución de la fuerza muscular es suficiente para confirmar el diagnóstico de sarcopenia.
3. El ejercicio físico aeróbico es el tratamiento de elección para mejorar la función muscular en pacientes ancianos con sarcopenia.
4. La medición de la fuerza muscular tiene mayor valor diagnóstico que el diámetro muscular en las guías actuales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Analicemos una a una. La respuesta 1 es falsa porque la sarcopenia y la desnutrición son diagnósticos independientes. Pese a que en la mayoría de ocasiones son concomitantes (el paciente con sarcopenia suele estar desnutrido y viceversa) el diagnóstico es diferente y se realiza de forma independiente para cada patología. La respuesta 2 también es falsa porque recordamos que para diagnosticar una sarcopenia hay que pasar por diferentes estratos: primero pasar el cuestionario SARC-F con una puntuación > 4 puntos, luego realizar alguna prueba de fuerza muscular con resultado patológico, y finalmente confirmación mediante una prueba de imagen de que efectivamente existe una disminución de la masa muscular. Recordamos que primero observamos una "pérdida de fuerza muscular" y después confirmaremos una "pérdida de masa muscular". La respuesta 3 es falsa porque el ejercicio físico aeróbico se recomienda para mejorar el sistema cardiovascular, capacidad respiratoria, resistencia etc.; pero para luchar contra la sarcopenia los pacientes deben realizar ejercicios de fuerza. La respuesta 4 es verdadera porque, de acuerdo a las Guías EWSOP2 la fuerza muscular (que se utiliza para el diagnóstico) tiene mayor peso para el diagnóstico de la sarcopenia que el diámetro de cualquier músculo (por ejemplo, el diámetro de la pantorrilla), que se utiliza no para diagnosticar sarcopenia, sino para valorar desnutrición.

193. Varón de 84 años que acude a consulta acompañado de su hija por caídas frecuentes en el último año, pérdida de peso no intencionada (concretamente 6Kg en los últimos 4 meses) y cansancio generalizado. Vive en domicilio con su esposa, pero necesita ayuda para cocinar y hacer la compra. Su hija es quien le organiza la medicación. En la exploración evidenciamos una velocidad de la marcha de 0,7 m/s y debilidad muscular en extremidades superiores (dinamometría 18Kg). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a su diagnóstico y manejo?:

1. El paciente no cumple criterios de fragilidad ya que mantiene su autonomía para las actividades básicas de la vida diaria.
2. La fragilidad es un síndrome geriátrico que se asocia a un déficit de IL-6 y a una hiperactividad del sistema nervioso autónomo.
3. Cumple criterios de fragilidad según el fenotipo de Fried, por lo que debe iniciarse un programa multicomponente de ejercicio físico y suplementación proteica.
4. El diagnóstico de fragilidad requiere de un índice de comorbilidad elevado y la presencia de al menos dos síndromes geriátricos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Recordamos que de acuerdo a los Criterios de Fried, un paciente se considera frágil si cumple 3 o más de los siguientes

criterios: pérdida de peso no intencionada, mala tolerancia al esfuerzo (fatiga), debilidad (baja fuerza de prensión), lentitud (baja velocidad de la marcha) y baja actividad física. Nuestro paciente parece que tiene (por lo menos) los cuatro primeros, y por lo tanto sí que podemos diagnosticarlo de fragilidad (respuesta 3 correcta) e iniciar rápidamente un programa adecuado de ejercicio físico y nutrición. La respuesta 1 es falsa porque tener un Barthel de 100/100 o no necesitar ayuda para las ABVD no implica que el paciente no sea frágil. La respuesta 2 es falsa porque, recordamos, el envejecimiento se asocia a una inflamación crónica con aumento de todos los reactantes inflamatorios. La afirmación 4 también es falsa porque el diagnóstico de fragilidad (que es un síndrome geriátrico) no implica que el paciente tenga que tener además otros dos síndromes geriátricos. Por otro lado, aunque hay escalas como la Clinical Frailty Scale (CFS) de Rockwood en las que se hace un sumatorio de patologías (cuantas más enfermedades presente el anciano mayor será su grado de fragilidad), hay que tener claro que no sirven para DIAGNOSTICAR fragilidad, sino para CLASIFICAR posteriormente el grado de la misma (leve, moderada-grave, extrema).

194. Acude a su consulta de Atención Primaria un varón de 75 años traído por su hija, muy preocupada por el devenir de su padre. El paciente ha sido recientemente diagnosticado de demencia en fase inicial; aún puede comunicarse y expresa su voluntad. Sin embargo, su familia quiere tomar todas las decisiones médicas y no médicas por él. ¿Cómo debe proceder el equipo médico?:

1. Evaluar la capacidad del paciente para decidir y respetar su autonomía si es competente.
2. Seguir las decisiones de la familia sin consultar al paciente ya que la demencia hace que el paciente se convierta en incapaz.
3. Nombrar automáticamente a un tutor legal para facilitar la toma de decisiones sucesivas.
4. Administrar el tratamiento que precise el paciente según mejor criterio médico sin informar ni al paciente ni a la familia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Si el paciente aún tiene capacidad de decisión, su autonomía debe ser respetada. Solo si su deterioro es severo y no puede tomar decisiones informadas, se delega a su familia o tutor legal. Para considerar que un paciente tiene deterioro cognitivo que le impida la toma de decisiones tiene que ser evaluado por un profesional médico (generalmente neurólogo en caso de demencias; en otros casos, médico de familia, psiquiatra...).

195. Una mujer de 32 años llega a su consulta de Urgencias con moretones visibles en el cuello y la cara, además de síntomas de ansiedad. Al interrogarla, admite que su pareja la ha golpeado

repetidamente durante los últimos meses. ¿Qué debe hacer usted?:

1. Realizar una exploración física y dar el alta de Urgencias con el tratamiento que precise, únicamente.
2. Crear un ambiente de confianza que permita a la paciente compartir información, realizar el parte de lesiones y notificarlo al juzgado de guardia.
3. Ignorar los síntomas ya que no tiene usted pruebas fehacientes de la existencia de violencia doméstica.
4. Administrar tratamiento para las lesiones y derivar al paciente a un psiquiatra.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En situaciones de violencia doméstica, el médico debe actuar con delicadeza, crear un entorno de confianza para que la víctima se exprese libremente y, si se confirma la violencia, debe elaborar el parte de lesiones y notificarlo al juzgado de guardia. Además, se debe orientar a la víctima a recibir atención psicológica y legal.

196. Varón de 76 años con ELA en fase avanzada, alimentado por PEG y con traqueostomía, conservando aún la capacidad de juicio y expresión con ayuda de un dispositivo ocular. Solicita iniciar el procedimiento para la prestación de ayuda para morir. El médico que lo atiende argumenta objeción de conciencia y le recomienda “consultar con otro profesional si insiste”. ¿Qué error comete el médico según la Ley de Eutanasia?:

1. No puede negarse si el paciente cumple criterios y debe iniciar el procedimiento.
2. Incumple la ley al no garantizar una derivación efectiva a otro profesional.
3. Debe notificar obligatoriamente al comité de ética del centro antes de rechazar.
4. Solo puede objetar si el paciente aún no ha perdido la capacidad de obrar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La objeción de conciencia es legal, pero obliga al médico a derivar a otro profesional para asegurar que se respeta el derecho del paciente.

197. Mujer de 32 años sin antecedentes relevantes que es trasladada al hospital tras haber sido encontrada inconsciente en la calle. Presenta los siguientes signos y parámetros hemodinámicos: TA de 80/50 mmHg, FC de 125 lpm, Gasto Cardíaco (GC) de 2,5 L/min y Presión Capilar Pulmonar (PCP) de 6 mmHg. En base a estos datos, ¿cuál es el diagnóstico hemodinámico más probable?:

1. Shock cardiogénico.
2. Shock hipovolémico.
3. Shock séptico.
4. Shock obstructivo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Tenemos a una paciente con una TA baja y una FC elevada (común en todos los shocks salvo el distributivo de tipo neurológico, que cursaría con bradicardia pero no sale como opción). Por lo tanto, lo que nos va a permitir distinguir entre los cuatro tipos de shock serán las otras dos medidas que nos dan: GC y PCP. Un GC de 2,5 L/min es un GC bajo (valores normales: 4-8 L/min). El único shock que NO cursa con GC bajo es el distributivo, por lo que podemos descartarlo (respuesta 3 falsa). Una PCP de 6 mmHg es el límite bajo (valores normales: 6-12 mmHg). Tanto el shock cardiogénico como el obstructivo cursan con PCP elevadas, por lo tanto respuestas 1 y 4 descartadas también. Esta paciente tiene un shock hipovolémico (respuesta correcta 2).

198. Atiende usted en Urgencias a una mujer de 72 años con insuficiencia renal crónica en tratamiento con oxicodona por dolor en relación a diagnóstico reciente de adenocarcinoma de páncreas. Es llevada a urgencias por su familia debido a un estado de confusión aguda, alucinaciones visuales y movimientos musculares involuntarios en las extremidades. Hace una semana inició quimioterapia y los últimos días ha tenido abundante diarrea y vómitos. En la exploración, se observa somnolencia importante y movimientos mioclonícos finos distales en extremidades. No presenta fiebre ni signos de infección. ¿Cuál es la causa más probable del cuadro clínico?:

1. Delirium por infección urinaria no diagnosticada.
2. Sangrado intracraneal (ictus hemorrágico).
3. Neurotoxicidad inducida por opioides (NIO) secundaria a acumulación del fármaco.
4. Crisis epiléptica focal secundaria a metástasis cerebrales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La paciente presenta factores de riesgo para el desarrollo de NIO como edad avanzada y un probable fracaso renal en relación a deshidratación por pérdidas digestivas (náuseas y vómitos de la quimioterapia). Esto favorece la acumulación del opioide y sus metabolitos activos, desencadenando síntomas neurológicos típicos de la NIO como delirium, alucinaciones y mioclonías.

199. Acude a su consulta de preanestesia un varón de 78 años con HTA, DL, FA no valvular y DM tipo 2. Está en tratamiento con Apixabán, Bisoprolol, Enalapril, Atorvastatina y Metformina.

Va a someterse a una colecistectomía laparoscópica programada. Respecto al manejo de su tratamiento habitual en el periodo perioperatorio, señale la opción correcta:

1. Se debe suspender atorvastatina al menos 48h antes de la cirugía para reducir el riesgo de miopatía en contexto quirúrgico.
2. El bisoprolol debe suspenderse el día antes de la cirugía para evitar hipotensión intraoperatoria.
3. La metformina debe suspenderse 24-48h antes de la cirugía para evitar acidosis láctica, especialmente si se prevé uso de contraste o deterioro de función renal perioperatorio.
4. El apixaban debe mantenerse hasta el día de la cirugía por su bajo riesgo de sangrado y su corta vida media.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Recordamos que la metformina es uno de esos fármacos que hay que suspender 24h antes de la cirugía y sustituirlo por insulina, ya que si no existe riesgo elevado de que el paciente desarrolle acidosis láctica (respuesta 3 verdadera). Con respecto a las opciones 1 y 2, las estatinas y los beta-bloqueantes son fármacos cardiovasculares que NO hay que suspender (opciones 1 y 2 falsas). Podemos dudar con la opción 4 ya que lo que más nos gustaría es suspenderlo 24-72h antes de la cirugía; pero estrictamente, como acabamos de decir, se pueden suspender incluso solo 24h antes, por lo que la opción 4 es al menos mucho más verdadera que la opción 3.

200. Mujer de 84 años que acude a consulta tras a ver sufrido 3 caídas en el último mes, una de ellas con fractura de radio. Vive sola, camina con bastón y refiere dificultad para incorporarse del sillón. Durante la valoración geriátrica integral se objetiva: velocidad de la marcha de 0,6 m/s, SPPB de 6 puntos y fuerza de prensión de 10Kg. ¿Cuál sería el paso más adecuado según el algoritmo de manejo de caídas de las guías clínicas?:

1. Solicitar un estudio neurológico completo con RNM cerebral y potenciales evocados.
2. Iniciar ejercicios de fisioterapia centrada en entrenamientos de fuerza y equilibrio. Revisión dentro de un mes.
3. Derivar a traumatología para infiltración articular por artrosis de rodilla.
4. Añadir fludrocortisona para mejorar la hipotensión ortostática sintomática

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Si seguimos el algoritmo de manejo de las caídas en los ancianos, vemos que la mayoría de información que nos dan en esta pregunta no la necesitamos. El paciente se ha caído

tres veces en el último mes y además una de esas caídas ha tenido una consecuencia grave (una fractura). Estamos por lo tanto ante un paciente con RIESGO ALTO, y por consiguiente lo que corresponde es iniciar un programa de intervención individualizada con ejercicios de fuerza, equilibrio, aeróbicos... y revisar al paciente cada poco tiempo (1-3 meses). El resto de respuestas no tienen nada que ver con el manejo de las caídas en el anciano.

201. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de los tumores de faringe es correcta?:

1. El carcinoma escamoso queratinizante de cavum es la estirpe histológica más frecuente y dentro de los factores de riesgo que provocan la aparición de esta neoplasia se encuentra el alto consumo de nitrosaminas.
2. El carcinoma epidermoide de orofaringe asienta más frecuentemente en la amígdala palatina; aunque clásicamente se ha asociado a tabaco y alcohol, recientemente existe un aumento de la incidencia de tumores asociados a la oncogenicidad del virus de Epstein Barr.
3. Ante la presencia de síndrome faríngeo (disfagia progresiva, odinofagia y otalgia refleja) en un paciente fumador se recomienda valorar la posible presencia de un carcinoma epidermoide de hipofaringe.
4. Es excepcional que cualquier tumor de la faringe genere adenopatías, ya que los síntomas derivados de tumores faríngeos son muy floridos y provocan que el paciente acuda rápidamente a consultar por ellos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta clásica sobre las características de los tumores de faringe. Recordad que el cáncer de cavum está asociado a la infección por virus de Epstein Barr o el consumo de nitrosaminas y la estirpe histológica más frecuente es el carcinoma no queratinizante o linfopitelioma (respuesta 1 incorrecta). El cáncer de orofaringe asienta principalmente en el tejido linfóide de la amígdala palatina pero aunque se asocia clásicamente al tabaco y el alcohol, cada vez se ha visto mayor asociación con el virus del papiloma Humano (VPH) - respuesta 2 incorrecta. La presencia de síndrome faríngeo nos obliga a sospechar un proceso neoplásico a nivel del seno piriforme, aunque la forma de aparición más frecuente es la aparición de adenopatías (respuesta 3 correcta). Todos los tumores de faringe evolucionan en una viscera hueca por lo que su diagnóstico es en ocasiones tardío y frecuentemente por la presencia de adenopatías (respuesta 4 incorrecta) por lo que empeora su pronóstico.

202. ¿Qué hormona se está investigando por su potencial rol frente a complicaciones metabólicas en el embarazo?

1. Progesterona.
2. HCG.
3. Estriol.
4. Lactógeno placentario.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El lactógeno placentario se libera en respuesta a la hipoglucemia y asegura el suministro de glucosa al feto, actuando como una hormona diabetógena. Así mismo, en la segunda mitad del embarazo, interfiere con la acción de la insulina.

203. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los opioides es correcta?:

1. Los opioides menores, como la codeína y el tramadol, no tienen techo terapéutico y su eficacia aumenta a medida que se incrementa la dosis.
2. La morfina sigue siendo el opioide de referencia para la titulación de dosis debido a su versatilidad, seguridad y coste.
3. El fentanilo ultrarrápido tiene un inicio de acción rápido y un efecto prolongado (12h), lo que lo hace ideal para el tratamiento de dolor irruptivo oncológico.
4. La buprenorfina es un opioide menor cuya característica especial es que es agonista parcial del receptor.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La respuesta 1 es falsa porque los opioides menores SÍ tienen techo. El fentanilo ultrarrápido efectivamente se usa en dolor irruptivo oncológico por su farmacocinética especial: tiene un inicio de acción muy rápido (5-15 min) y dura poco (2-3h). La buprenorfina es agonista parcial pero no es un opioide MENOR si no mayor.

204. ¿En que circunstancia se valoraría iniciar VMNI de forma aguda?:

1. pH 7.30, pCO₂ 70, pO₂ 54, HCO₃ 33.
2. pH 7.37, pCO₂ 75, pO₂ 65, HCO₃ 40
3. pH 7.35, pCO₂ 45, pO₂ 54, HCO₃ 27
4. pH 7.28, pCO₂ 45, pO₂ 70, HCO₃ 18.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La opción correcta es la opción 1, en la que se muestra una acidemia con acidosis respiratoria NO compensada, por lo que está indicado iniciar VMNI de manera inmediata. En la opción 2 hay una acidosis respiratoria COMPENSADA, dado que se consigue un pH normal gracias a la compensación renal con el aumento de bicarbonato, probablemente este paciente precise VMNI de forma crónica. En la opción 3 existe una insuficiencia respiratoria hipoxémica, en este caso lo que estaría indicado sería oxigenoterapia. La opción 4 se trata de una acidosis metabólica.

205. Acude a su consulta una paciente de 63 años derivada por hallazgo incidental de datos de cirrosis hepática en una prueba de imagen realizada por otro motivo. Antecedentes personales de obesidad, hipertensión arterial y cirugía de prótesis de rodilla bilateral. La paciente está sorprendida y alarmada por el diagnóstico: cree que tiene que haber un error, puesto que ella sólo bebe un vasito de vino con la comida. Nunca ha sido fumadora o consumidora de otros tóxicos. No conductas de riesgo. Aporta un análisis inicial desde su Centro de Salud en el que se objetivan: GOT 45, GPT 60, FA 90, GGT 250. Bilirrubina 0'8, normal. Colesterol total 230, triglicéridos 300, IST 20%, ferritina 1000. Serologías de virus hepatotropos negativas. Señale la causa más probable de la enfermedad hepática de la paciente:

1. Hemocromatosis hereditaria.
2. Esteatohepatitis metabólica.
3. Cirrosis hepática por alcohol.
4. Colangitis biliar primaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La presencia de varios factores de síndrome metabólico (DM2, obesidad, HTA, dislipidemia), una vez descartadas la hepatitis vírica crónica y el consumo perjudicial de alcohol, tiene que hacernos pensar inmediatamente en una esteatohepatitis metabólica con evolución silente a la hepatopatía avanzada. Se trata de una forma de presentación cada vez más frecuente; de hecho, a día de hoy ésta ya es la primera causa de hepatopatía avanzada en USA y UK. No sospechamos hemocromatosis hereditaria porque el IST es <45%. Que no te despisten las cifras de ferritina: se trata de una hiperferritinemia dismetabólica, que suele acompañar a las esteatohepatitis como dato de disfunción metabólica y de inflamación. No implica una verdadera sobrecarga férrica, y el pronóstico no mejora con sangrías (a diferencia de lo que ocurre en la hemocromatosis hereditaria).

206. ¿Cuál de los siguientes bloqueos se usa para tratar el dolor visceral del abdomen superior, especialmente en cáncer de páncreas?:

1. Bloqueo del ganglio estrellado.
2. Bloqueo del plexo celíaco y nervios espláncnicos.
3. Bloqueo del plexo hipogástrico superior.
4. Bloqueo del ganglio impar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Para responder a esta pregunta debemos recordar la anatomía (qué región de las preguntadas inervará el abdomen superior y, por tanto, el páncreas). El plexo celíaco se encuentra a la altura de T12-L1 y los nervios espláncnicos se originan en los ganglios simpáticos a los lados de la médula espinal y transportan fibras simpáticas hacia el plexo celíaco y otros ganglios prevertebrales. Su bloqueo es una técnica

de analgesia muy útil sobre todo en cáncer de páncreas. El ganglio estrellado está formado por la unión del último ganglio cervical y el primero torácico y su bloqueo ayuda en el tratamiento de patología que afecta sobre todo a cuello y brazo (neuropatías periféricas o post-irradiación de esas zonas o problemas vasculares como Raynaud). El plexo hipogástrico superior se encuentra anterior a L5-S1 y recibe aferencias simpáticas de vísceras de la pelvis (vejiga, próstata, vagina, útero, ovarios, recto y sigma). El ganglio impar o de Walter está localizado en la cara anterior de la unión sacrocóxigea y proporciona inervación simpática y nociceptiva a varias estructuras pélvicas y perineales, incluyendo el perineo, el recto distal, la región perianal, la uretra distal, la vulva/escroto y el tercio distal de la vagina.

207. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se utiliza en el tratamiento de la dermatitis atópica?:

1. Dupilumab – anti-IL4Rα.
2. Risankizumab – anti-IL23.
3. Lebrikizumab – anti-IL13.
4. Upadacitinib – inhibidor selectivo de JAK1.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Risankizumab es un anti-IL-23 utilizado en el tratamiento de la psoriasis moderada-grave. Todos los demás son tratamientos sistémicos aprobados para la dermatitis atópica moderada-grave. Lebrikizumab es un nuevo fármaco biológico que tiene un mecanismo de acción similar a tralokinumab.

208. Una mujer embarazada de 32 años en la semana 10 presenta TSH ligeramente suprimida con T4 libre normal. No tiene clínica de tirotoxicosis ni antecedentes familiares ni personales relevantes. ¿Cuál es la actitud más adecuada en esta situación?:

1. Iniciar antitiroideos de síntesis.
2. Solicitar anticuerpos anti-TPO e iniciar tratamiento si son positivos.
3. Realizar gammagrafía tiroidea inmediatamente.
4. Observación clínica y analítica sin tratamiento farmacológico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Durante el primer trimestre de embarazo es normal que la TSH pueda estar ligeramente suprimida debido al efecto estimulador de la hCG sobre la glándula tiroidea. En ausencia de clínica, no está indicado tratamiento farmacológico ni estudio gammagráfico.

209. Acude a su consulta un varón de 75 años, sin comorbilidades importantes, con diagnóstico reciente de neoplasia de pulmón avanzada con metástasis óseas. Tiene importante dolor general que localiza bien en cadera derecha, lumbar y

hombro izquierdo. Toma tapentadol 50 mg/12h además de paracetamol 1g/8h. El paciente tiene su dolor en reposo bastante bien controlado (EVA 2) pero empeora francamente con las movilizaciones. Por esa razón, está limitado funcionalmente y hace vida cama sillón. Además, está comiendo muy poco y duerme mal. Se encuentra muy bajo de ánimo. Señale la opción INCORRECTA.

1. Plantearía introducir dexametasona para disminuir el dolor óseo en relación a las metástasis.
2. Propondría radioterapia sobre las lesiones óseas como tratamiento antiálgico.
3. Introduciría otro opioide de liberación rápida, como la morfina, para que el paciente pueda emplear en los picos de dolor (por ejemplo, las movilizaciones).
4. El insomnio parece reactivo a la situación general por lo que no está recomendada la utilización de fármacos para tratarlo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil que muestra un paciente típico con cáncer avanzado y plurisintomatología. Los corticoides, y en concreto la dexametasona, tienen múltiples usos en paliativos. Ayudan con la astenia oncológica, mejoran el apetito y el ánimo, con analgésicos y tienen un efecto antiinflamatorio muy potente. Esto último los hace muy útiles para disminuir edema perilesional ocasionado por masas, implantes, metástasis. Por ejemplo, los usamos en LOEs cerebrales con mucho edema, metástasis en columna vertebral (que tienen a comprimir raíces nerviosas) o implantes peritoneales que producen suboclusiones u oclusiones intestinales. En este caso puede ayudar con la inflamación alrededor de las metástasis óseas mejorando el dolor. Por otro lado, la radioterapia es muy útil en neoplasias no solo como tratamiento per se antitumoral si no como para control del dolor, sobre todo en lesiones óseas. El paciente que nos presentan tiene un opioide retard con buen control del dolor basal. Sin embargo, presenta exacerbaciones con las movilizaciones para lo que podemos emplear otro opioide de liberación rápida como, por ejemplo, la morfina. Ojo, recordad que no siempre hay que rescatar con el mismo fármaco que lleve el paciente de base (fentanilo con fentanilo por ejemplo). Además, en España no existe tapentadol rápido. El insomnio efectivamente suele ser reactivo a la situación ya que los pacientes suelen tener dificultades para dormir por pensamientos intrusivos o pesadillas. Se puede pautar fármacos que ayuden a conciliar como benzodiazepinas, mirtazapina...

3. Trastornos de ansiedad.
4. A y B son correctas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

aparecer en los cuadros depresivos graves y en la esquizofrenia (recordar que es un subtipo de esquizofrenia). El tratamiento de elección es la TEC.

210. La sintomatología catatónica puede aparecer en:

1. Depresión.
2. Esquizofrenia.

